República de Cuba

Universidad de Oriente

Centro de Estudios Pedagógicos "Manuel F. Gran"

LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA EN ECUADOR

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Por

Autor: Lenny Cecilia Mariscal San Martin

Santiago de Cuba

2022

República de Cuba

Universidad de Oriente

Centro de Estudios Pedagógicos "Manuel F. Gran"

LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA EN ECUADOR

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Por

Autor: Lenny Cecilia Mariscal San Martin

TUTORAS:

Dr. C. PT Blanca Cortón Romero (Prof. Consultante).
Dr. C. PT Julia Esther Céspedes Acuña (Prof. Consultante).

Santiago de Cuba

2022

DEDICATORIA

A DIOS, quien inspiro mi alma en este desafío personal para concluir la tan anhelada tesis, además, me sostuvo cuando mi salud fue quebrantada, solo por El pude levantarme y continuar haciendo de mí, una guerrera que a pesar de la adversidad continué, con altas y con bajas con momentos de desgano. El me sostenía, sino fuera por Dios no hubiera terminado me dio la fuente de ingreso y el valor para no parar sin El nada sería posible en mi hoy, por eso esta Dedicatoria para el Padre Eterno.

También a todos aquellos que me apoyaron moral y económicamente.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por iluminar mi camino, guiar mi espíritu y por darme la sabiduría necesaria para afrontar las dificultades, siempre Su misericordia conmigo.

A la Universidad de Oriente, por las enseñanzas, las anécdotas y especialmente por formarme como profesional, asumiendo con dedicación el compromiso de educar.

A mis tutoras de tesis, por la dedicación, paciencia, comprensión y la búsqueda a la excelencia en la formación académica y en esta tesis.

A mis hijos, por su apoyo y comprensión siempre, por el tiempo, experiencias, reuniones, cumpleaños que tuvimos que sacrificar con la distancia en la persecución de llegar a ésta meta.

A mi madre y hermana, por los consejos de ánimo y por inculcarme los valores humanos que hoy guían mi ejercicio profesional.

A mis amigos, por convertirse en mis ángeles al apoyarme con su tiempo, palabras y experiencias en cada una de mis caminos metas.

SINTESIS

La investigación se inserta en la formación del Técnico Superior en Enfermería como un reto en el contexto actual ecuatoriano, considerando la elaboración de una concepción pedagógica de formación de la competencia ética en este estudiante desde su formación inicial. Desde el punto de vista práctico se concibe una estratégica pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería estructurada desde lo formativo como eje central integrador que permite, de forma coordinada y planificada, llevar el encargo social mediante el establecimiento de pasos y vías, a fin de poder alcanzar el crecimiento de las partes involucradas para que respondan a las necesidades tanto individuales como a las exigencias sociales. La novedad de la investigación se revela se revela en la estructuración de la concepción pedagógica sobre la base de la relación dialéctica entre los presupuestos teóricos de la Bioética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la Bioética médica, lo que supera las concepciones eminentemente médicas de la Ética y permite la articulación del pensamiento ético contemporáneo con las ideas que sirven de marco conceptual a la estrategia de desarrollo de la salud pública en el Ecuador. El empleo de criterio a especialistas, taller de socialización y la realización de un estudio de caso, permitieron demostrar la pertinencia de la investigación.

INDICE

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO I. MARCO REFERENCIAL EN TORNO A LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA EN EL TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA 10

1.1 Referentes teórico-metodológicos sobre el proceso de formación del Técnico Superior en Enfermería 10

1.1.1 La formación de la competencia ética de los estudiantes Técnico Superior en Enfermería 28

1.2 Reseña histórica de la formación de la competencia ética en el estudiante Técnico Superior en Enfermería. 34

1.3 Diagnóstico del estado actual de la formación de la competencia ética del estudiante Técnico Superior en Enfermería 40

Conclusiones del capítulo 44

CAPÍTULO II CONCEPCIÓN PEDAGOGICA DE FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA EN EL TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA 45

2.1 Fundamentos que sustentan la concepción pedagógica de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería. 45

2.2 Contenido y estructura de la concepción de la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería 51

Conclusión del capítulo 76

CAPITULO III ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA EN EL TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA. CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS 77

3.1-Estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería. 77

3.2 Valoración de la factibilidad de la estrategia pedagógica y la pertinencia de la concepción en que se sustenta 88

Conclusiones del capítulo 111

CONCLUSIONES GENERALES 112

RECOMENDACIONES 113

INTRODUCCIÓN

La sociedad ecuatoriana aspira a consolidar un modelo social que cumpla con las expectativas de todos los ciudadanos desarrollando procesos sustanciales en todas las esferas de la vida social, económica y cultural; para ello se necesita un pueblo con una elevada preparación cultural, específicamente profesionales con alta calificación; el logro de este propósito exige entre otros aspectos el perfeccionamiento de la educación, lo cual constituye además una contribución al cumplimiento a los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015, especialmente al objetivo 4: "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos" (ONU, 2015, p.16).

Este objetivo incluye entre sus metas asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria; y aumentar el número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Estos propósitos están a tono con las los objetivos y metas de la educación ecuatoriana refrendados en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), documento en cuyo artículo 2 se plantea que el mismo tiene como objeto "… garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna." (LOES, 2010, p. 5)

Un lugar importante entre los objetivos de la educación ecuatoriana lo ocupa la formación con calidad de los recursos humanos encargados de asegurar los servicios de salud, ya que de la calidad de su formación depende en gran medida un desempeño profesional a tono con las necesidades del sistema de salud ecuatoriano y con el cumplimiento del ODS 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades." (ONU, 2015, p.16)

La formación de técnicos superiores en enfermería (TSE), es uno de los procesos a los que se le brinda especial atención dada la significación y el rol de este profesional en el perfeccionamiento del sistema de salud. De ahí la necesidad de direccionar los centros formadores de estos profesionales hacia el perfeccionamiento y acreditación de la calidad de la formación, incorporando nuevas miradas epistemológicas entre las que se encuentran los fundamentos de la bioética como ética global y profunda y las posiciones filosóficas predominantes en Ecuador, junto a la bioética médica.

La carrera de Técnico Superior en Enfermería se inició en 2008, y constituye un proyecto de base teórica metodológica para el desarrollo de un nuevo modelo de formación en las carreras de los profesionales de la salud, que amplió la visión en el campo de la salud específicamente en la carrera de enfermería, en la cual se producen rápidas y diversas transformaciones curriculares tanto en el diseño, como en el proceso formativo.

En correspondencia con esas transformaciones, se han realizado adecuaciones a los reglamentos y otros documentos normativos con flexibilidad para propiciar un mejor ajuste de los procesos a las condiciones con que se cuenta para su desarrollo y a las exigencias del desempeño de este profesional.

En este sentido, el Modelo del profesional de la carrera Técnico Superior en Enfermería, es de un profesional de la salud que se forma de manera gradual e integral como básico, técnico y profesional, preparado para desempeñar diversas funciones en los niveles de atención del sistema nacional de salud; por este motivo, el proceso de formación debe transcurrir en instituciones docente-asistenciales diversas.

Por otra parte, la flexibilización curricular y de horario ha creado nuevas condiciones que deben tenerse en cuenta en la dirección del proceso pedagógico. El hecho de que los estudiantes puedan matricularse de acuerdo con sus posibilidades personales y atendiendo a las precedencias en el plan

de estudio, es una de las condiciones que apoya la organización del proceso pedagógico, lo que constituye una diferencia importante ya que hay comodidad en escoger horarios y desarrollar la carrera con facilidad.

El diseño actual del plan de estudio de este Técnico Superior en Enfermería incluye diversos ejes transversales de coordinación interdisciplinar que no existían en los planes de estudio precedentes, cuya aplicación requiere de un funcionamiento viable en directivos técnicos que se encarguen de su planificación, ejecución y control, similares a los de un proyecto, en coexistencia con la estructura piramidal tradicional de dirección académica en la que las diversas dependencias siguen desempeñando un papel importante en la formación y superación de profesores y el desarrollo de las disciplinas, pero no puede abarcar lo interdisciplinario.

Las consideraciones anteriores generaron la necesidad de proponer adecuaciones necesarias como significar la importancia de la Ética en la carrera de Técnico Superior en Enfermería y de las estructuras metodológicas reglamentadas para la dirección del proceso formativo de profesionales, según los niveles de integración de la carrera, para que resulten apropiadas a las condiciones en que se desarrolla dicho profesional con posibilidades de funcionar con eficacia y efectividad en el logro de los objetivos generales de la formación.

El Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB)-institución que forma este tipo de profesional-tiene como misión formar profesionales técnicos que porten una excelencia académica como exige el crecimiento global sostenido, ya que deben mostrar competencias en su desempeño en la práctica apoyada en las bases científicas que las guían y a su vez proporcionar los recursos para la legitimidad y autonomía de la profesión.

En la formación del TSE tiene un lugar fundamental la formación ética, por cuanto se trata de un profesional cuyo desempeño exige un alto grado de sensibilidad, empatía y responsabilidad, en este

sentido, se han obtenido resultados positivos, pero aún se evidencian insuficiencias en el proceso formativo y sus resultados.

Un estudio exploratorio efectuado a partir de la práctica profesional de la autora y del análisis de varias fuentes, entre ellas: el Plan de estudio de la carrera TSE, informes de colectivos de docentes, así como la observación a clases, prácticas pre profesionales y actividades extracurriculares, revelan insuficiencias en:

El conocimiento de los estudiantes que optan por la carrera del sistema de valores propios de la ética profesional del personal de la salud en general, y del TSE en particular.

La correspondencia entre el comportamiento de los estudiantes en las actividades docentes y en la práctica pre profesional, y el sistema de valores profesionales.

Las prácticas pre profesionales que inciden negativamente en la apropiación por los estudiantes de la ética de la profesión.

Estas insuficiencias y los vacíos teóricos constatados en la revisión de la literatura sobre la temática permitieron formular como problema científico: Insuficiencias en la formación ética del Técnico Superior en Enfermería que limitan su desempeño profesional, y consiguientemente, la calidad del servicio asistencial.

Al analizar la problemática se identifican entre sus causas:

Insuficiente intencionalidad e integralidad en la concepción y práctica de la formación ética del TSE expresados en:

1. El tratamiento y el enfoque de los contenidos relacionados con la formación ética desde lo curricular y su sistematización epistemológica y metodológica.
2. La intencionalidad formativa de las actividades extracurriculares.
3. El enfoque reduccionista del tratamiento de la bioética circunscribiéndolo al tratamiento bioética

médica

4. Insuficiencias en la preparación de los docentes para desarrollar la formación ética del TSE.

En la práctica se revela una contradicción entre la exigencia de un comportamiento en concordancia con la ética de la profesión como condición indispensable para un desempeño profesional exitoso del TSE, y la concepción y desarrollo del proceso de formación desde una perspectiva ético profesional. La actividad profesional del técnico en enfermería, incluye otorgar cuidado individualizado, la intervención de un enfermero/a como recurso terapéutico y la integración de habilidades específicas. El cuidado comprende aspectos afectivos relativos a la actitud, compromiso y elementos técnicos, los cuales no pueden ser separados al otorgar cuidados, así como la identificación del significado del cuidado para quien lo otorga y para quien lo recibe, la intención y la meta que se persigue, cuestión valorada por los investigadores Morse, S (1990); Pepin, (1992) y Benner, (1989), citados por Kerouac, (1996, p.26).

La problemática de la formación del TSE ha sido abordada por diversos investigadores en el contexto ecuatoriano, en este sentido se consultaron las investigaciones de Grunauer, (2016); Altamirano, (2016); Alzate, (2016); Placencio, (2016); Caicedo, (2016); Moore, (2018), todas dedicadas a la formación del TSE; las mismas se refieren a aspectos relacionados con la formación para la promoción de la salud, el aprendizaje cooperativo asistencial, las prácticas comunitarias en la formación y la prevención de enfermedades desde el vínculo con la comunidad respectivamente. Estas investigaciones constituyen referentes necesarios en la investigación que se sigue, en la medida que revelaron insuficiencias en el desarrollo de un juicio crítico y la formación en valores éticos, del TSE en los aspectos específicos que estudiaron.

Los trabajos de Tapia, (2016); Rodríguez, (2016), relacionados con el uso de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la formación del TSE también fueron consultados por cuanto de

alguna manera hacen referencia a aspectos relacionados con la formación ética relacionados con el uso de la tecnología.

Aunque en todos los casos se refieren a la formación del TSE, se evidencia la existencia de vacíos en el estudio de la problemática, de la cual han sido tratados aspectos específicos, pero quedan aún cuestiones por abordar de ahí que la formación del TSE se defina como el objeto de esta investigación. En las investigaciones consultadas se tienen en cuenta de alguna manera la formación ética del TSE, sin embargo, este proceso no es abordado en toda su integridad. La formación del TSE que se concibe como formación por competencias, no se sustenta en la definición de esta competencia y las vías para su formación; además el enfoque del proceso tiene por base la concepción de la bioética como ética médica sin incorporar los enfoques actuales de la bioética como global y profunda.

Dadas las peculiaridades de la sociedad ecuatoriana que singularizan el contexto de desempeño de este profesional se hace necesario tener en cuenta las posiciones teóricas que sirven de base a la política y las estrategias de desarrollo económico social del país

En consecuencia, la investigación se propuso como objetivo la elaboración de una estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería, sustentada en una concepción pedagógica desde un enfoque intercultural, integral y ecológico. Se define como campo de acción la formación de la competencia ética del Técnico Superior en Enfermería.

Investigadores como Santiago Andrade, (2013); Cantos, M (s/f); los chilenos Rivera, y Urrutia, (2005); Cid, (2013); y los cubanos Urbina, Omayda y Otero, (2003) y Fernández, (s/f), entre otros, abordan temas referidos a la ética del enfermero sus criterios sirven de base al estudio que se sigue, así como documentos normativos establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en Ecuador, y estudios realizados en otros entornos latinoamericanos asociados a la temática.

Se precisa como idea a defender: La implementación de una estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería, sustentada en una concepción de este proceso, desde un enfoque intercultural, integral y ecológico, contribuirá al perfeccionamiento de la formación ética de este profesional, y de su desempeño favoreciendo la estrategia de desarrollo de la salud pública en Ecuador.

Para el desarrollo de la investigación se cumplimentaron las siguientes tareas científicas:

Sistematizar los referentes teórico-metodológicos sobre el proceso de formación del Técnico Superior en Enfermería con énfasis en la formación de la competencia ética.

-Reseñar la evolución histórica del proceso de la formación del Técnico Superior en Enfermería con énfasis en la formación de la competencia ética.

-Diagnosticar el estado actual de la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

-Elaborar una concepción pedagógica de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

-Elaborar una estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

-Valorar la pertenencia y factibilidad de la concepción y la estrategia en que se concreta a través de talleres de socialización, criterio de especialistas y un estudio de caso.

En la investigación se utilizaron diferentes métodos y técnicas, entre ellos del nivel teórico:

Análisis y la síntesis: presentes en la lógica de la investigación para dar tratamiento a la información que aportan los textos consultados y los datos obtenidos como resultado del diagnóstico, así como para la elaboración de los aportes teórico y práctico.

Histórico-lógico: para el estudio de la teoría del objeto y la elaboración de la reseña histórica.

La modelación desde el enfoque aportado por la Teoría General de los sistemas, para elaborar la concepción de la formación de competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería y la estrategia en que se concreta.

Entre los métodos empíricos se utilizó la observación, tanto en el diagnóstico como en el proceso de corroboración de la pertinencia y factibilidad de los aportes. Para esto último se utilizaron además talleres de socialización, criterio de especialistas y un estudio de caso.

Entre las técnicas empíricas su utilizaron el análisis documental para el procesamiento de los documentos normativos del proceso de formación; la entrevista a profesores, estudiantes y directivos para constatar el estado actual de la problemática estudiada; y la observación científica todos en el diagnóstico.

Los talleres de socialización, encuesta a especialistas y el estudio de caso fueron utilizados para corroborar la pertinencia y factibilidad de la concepción y la estrategia respectivamente.

Se utilizaron métodos matemáticos específicamente la estadística descriptiva, para el análisis y valoración de los resultados del diagnóstico. Durante la investigación se desarrolló la triangulación de métodos y fuentes.

La contribución a la teoría consiste en la concepción pedagógica de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería, su novedad se revela en el enfoque intercultural integral y ecológico de la formación ética del TSE sobre la base de la relación dialéctica entre las posiciones teóricas de la bioética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la bioética médica, lo que permite superar el reduccionismo médico en el proceso de formación y articular el pensamiento ético contemporáneo con las ideas que sustentan la estrategia de desarrollo de la salud pública en Ecuador.

El aporte práctico consiste en una estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería sustentada en la concepción de igual naturaleza.

La significación práctica, deviene del impacto en la práctica pedagógica, el perfeccionamiento de la formación inicial del TSE y en su incidencia en el desempeño de este profesional de la salud y consiguientemente en el mejoramiento de la asistencia y en la práctica social.

CAPÍTULO 1. MARCO REFERENCIAL EN TORNO A LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA EN EL TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA

En el capítulo se exponen los referentes teóricos que conforman el marco teórico referencial en torno a la formación de la competencia ética en el estudiante Técnico Superior en Enfermería sustentado en el análisis de categorías como formación, formación profesional, formación ética, aprendizaje ético, formación/educación en valores, formación por competencias, competencia, desempeño, entre otras, y sus relaciones desde un enfoque integral. Se analiza además una reseña histórica y se presentan los resultados del diagnóstico del estado actual en estudiantes Técnicos Superior en Enfermería del Instituto Tecnológico Bolivariano en Ecuador.

1.1 Referentes teórico-metodológicos sobre el proceso de formación del Técnico Superior en Enfermería.

En el mundo contemporáneo la formación ética de los individuos tiene importancia cardinal; en el logro de este propósito, la educación desempeña un papel fundamental especialmente el proceso de formación de profesionales que se desarrolla en las instituciones de Educación Superior. Este es también uno de los problemas más complejos que en la actualidad enfrentan las instituciones ecuatorianas que forman técnicos y tecnólogos de la salud, lo cual se debe a la significación que tiene lograr en los futuros profesionales de la salud formar la competencia ética que les permita desarrollar una actividad profesional reflexiva, crítica y transformadora en su práctica asistencial y dar solución a los dilemas éticos que enfrentan durante su desempeño con independencia y sentido de la responsabilidad.

Este reto demanda un proceso formativo singular del profesional de la salud, y específicamente del (TSE), cuya preparación debe dar respuestas a los problemas de la sociedad ecuatoriana de hoy.

Para el análisis de esta problemática es necesario fundamentar el proceso formativo del profesional TSE partiendo de la categoría formación, formación profesional y formación inicial, para luego caracterizar el proceso formativo de las competencias, en particular de la competencia ética, sobre la base de los aportes de la Bioética (ética global o profunda), la Bioética médica y la filosofía del Buen Vivir, lo cual requiere el tratamiento de otras categorías y relaciones.

La formación es concebida como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y experiencias a través de la actividad creadora de los sujetos, en ello coinciden investigadores como: Baxter, E. (1989); Flórez (1996); Ferry, (1997); Álvarez de Zayas, C. (1999); Fuentes, H., Estrabao, A. y Macías, T. (2003); Paz, I. (2003); Rojas, (2004); Mendoza, (2004); Horruitiner, P. (2006 y 2010) y otros del contexto ecuatoriano como Regalado, E. (2012) y Fabara, E y otros (2013).

Estos autores significan, de una manera u otra, la necesaria contextualización de la formación desde lo pedagógico como un proceso asociado a la actuación de docentes y estudiantes en el contexto docente, extradocente y en la praxis en que se desempeñará el futuro TSE, donde interactúa todo el equipo multidisciplinario de salud visto como la preparación para desempeñarse en el campo de la salud.

Se tiene en cuenta la consideración aportada por la autora Paz, I. (2011) al entender la formación como un proceso que transcurre durante todo el desarrollo evolutivo del ser humano y orienta a movilizar las potencialidades de los sujetos para favorecer su desarrollo. Considera la comprensión por el sujeto de su propia existencia, la atención y cuidado de sí y la responsabilidad ante su yo, lo cual implica la participación activa de los sujetos a partir de la interacción con otros y la posición reflexiva y autorreflexiva que asumen.

Según Báxter, E. (2003) la formación es el resultado de la educación recibida, es decir, el resultado de un conjunto de actividades organizadas coherente y sistemáticamente que le permite al estudiante actuar consciente y creadoramente, criterios asociados a los fines de esta investigación a partir de tener en cuenta su carácter consciente, creador y sistemático.

La autora de la actual investigación, considera que la formación es un complejo proceso de construcción activa de la subjetividad en relación con las influencias externas; transcurre como un sistema durante toda la formación profesional y su desarrollo.

Se significan en los criterios anteriores, aspectos asociados al proceso formativo en la esfera de la salud que pueden ser resumidos en:

-desarrollo de la individualidad humana e integridad de la personalidad.

-dirección del desarrollo y formación como ser espiritual.

-proceso y resultado, cuya función es preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad.

pone al sujeto en condiciones de asumir una actitud transformadora.

-contiene actividades organizadas, coherentes y sistemáticas.

El proceso formativo en los Institutos Superiores Tecnológicos se fundamenta en la solución de problemas inherentes a la realidad social y profesional que el estudiante enfrentará en su praxis; en este sentido, el proceso tiene su lógica propia al estar estructurada sobre la base de los procesos aprendidos por los estudiantes durante su formación, como también, en el desarrollo de habilidades y valores.

En tal sentido, responden al método empleado y a la asimilación de contenidos impartidos en la formación profesional, lo que exige nuevas concepciones teóricas y metodológicas que sinteticen el espíritu humanista de esta profesión como expresión de carácter ético en su desempeño profesional,

de modo que el proceso formativo del TSE demanda de análisis e interpretación que permitan de manera intencionada la formación y el desarrollo de competencias.

Se consideran los criterios de autores como: Álvarez de Zayas, C. (1996); Addine, F. (2002); Vargas, Z, (2007); Horruitiner, P. (2009); Paz, I. (2011); Regalado, L. (2012), y Fabara, E y Colectivo (2013), que asumen y distinguen en el proceso formativo, la creación de un tipo específico de hombre de acuerdo a definidos ideales, objetivos y fines sociales, argumento que se asume en esta investigación por la importancia que reviste para la formación inicial.

Regalado, L. (2012) y Fabara, E. (2013) son investigadores ecuatorianos que teorizan acerca de la formación. La primera la asume como un proceso totalizador a partir de dos formas de concreción: una, a través de la auto-preparación y otra, desde la concepción del ministerio de educación, dando mayor significado a la auto-preparación del docente para la formación activa del estudiante desde el inicio preparándolo para el desarrollo en esta sociedad tan demandante en el campo laboral.

Otros investigadores ecuatorianos, como Fabara, E. (2013), abordan el tema desde las buenas prácticas de los educadores, quedando insuficientemente desarrollado en el orden teórico la asunción de su esencia. Estos autores dejan mucha responsabilidad a los docentes desmereciendo la cultura y el desenvolvimiento a lo largo de la formación de los estudiantes, debido a que estos en este proceso, tienen un papel activo y protagónico, pues a juicio de esta investigación, se considera son constructores de sus conocimientos.

Se tienen en cuenta, además criterios por Grunauer, (2016); Altamirano, (2016); Alzate, (2016); Placencio, (2016); Caicedo, (2016), Moisés (201), Tapia (2016), Rodríguez (2016), los cuales valoran el proceso de formación en el TSE como un proceso integral, y proponen alternativas desde la formación inicial y continua para su perfeccionamiento que permiten al estudiante la apropiación de saberes para la solución de los problemas en la práctica.

En esta investigación, se asumen los criterios de Grunauer (2016) quien considera que el proceso formativo en el TSE implica, no solo apropiación de conocimientos, habilidades, y valores generales, sino, un correcto desempeño en los diversos contextos de actuación, concepción que se asume en la investigación y se destaca la significación que tiene el desempeño ético en el ejercicio de la profesión. Ejecutar este proceso desde la formación inicial, garantiza la preparación del TSE para la vida a través de contextos diversos que incluye un sistema de formación psicológica: intereses, motivos, convicciones, autovaloraciones, aspiraciones, intenciones, ideales, carácter y capacidad, entre otras, evidenciadas en la actuación del estudiante en formación.

Fabara, E. (2013), aborda la formación inicial desde las experiencias prácticas en el contexto universitario actual en los institutos pedagógicos, sin embargo, queda insuficientemente trabajada desde una concepción teórica pues se limitan a la aprehensión de los modos de actuación profesional en su concepción más general y esencial, y se concreta en el cumplimiento de tareas básicas del profesional la posibilidad de converger el conocimiento científico con los valores dela profesión.

De la investigadora López, J. (2000) se comparte como elemento fundamental el desarrollo de la individualidad humana y la integridad de la personalidad debido a lo que significa para el técnico de salud a partir de las funciones de carácter social que desarrolla. Acota la investigadora que la formación "… expresa la dirección del desarrollo, es decir, hacia donde este debe dirigirse. Cuando se habla de formación no se hace referencia específicamente a aprendizajes particulares, destrezas o habilidades; estos constituyen más bien medios para lograr su formación como ser espiritual" (López, J 2000, p.6). En estos criterios, además de reforzar la formación en su contexto social hacia una profesión adquiriendo significado la categoría formación profesional.

Fuentes, H. (2009), entre otros, reconocen a la formación profesional como el proceso que de modo consciente se desarrolla en las instituciones de Educación Superior, a través de las relaciones de

carácter social que se establecen entre sus participantes con el propósito de educar, instruir y desarrollar a los futuros profesionales, sistematizando y recreando de forma planificada y organizada la cultura acumulada por la humanidad, y dando respuesta con ello a las demandas de la sociedad.

La formación profesional es un proceso de carácter social e integral, entendido como proceso y resultado; ideas presentes en la base teórico-conceptual de la presente investigación. Este reconocimiento refleja la intencionalidad de la formación en la Educación Superior ecuatoriana desde el desarrollo de la cultura adquirida y sistematizada por el estudiante en formación en un contexto determinado, lo cual comparte esta investigadora.

Para Chamba, C y Herminio G, (2011), de la Universidad Loja de Ecuador, la formación de profesionales tiene como fin ayudar a fortalecer la educación, investigación, cultura, práctica de valores, la defensa del medio ambiente, y el espíritu emprendedor y autogestionario del sujeto que se forma. En esta aseveración se observa intencionalidad formativa aplicable a toda carrera universitaria, aun cuando se enfatiza en el desarrollo de la carrera de Comunicación.

Desde esta misma perspectiva, Taquechel, (2014) reconoce el papel del docente en las universidades (énfasis en centros de educación superior de salud) asignándole características que les permitan dirigir el proceso formativo adecuadamente.

En este sentido, la formación profesional del TSE se caracteriza por ser sensible a las necesidades humanas y tener conciencia de su responsabilidad al contribuir al bienestar de los demás, lo que sugiere el compromiso de la profesión al servicio de la sociedad aspecto que se comienza a desarrollar desde la formación inicial.

Al respecto Altamirano, (2016) y Grunauer, (2016), plantean que la formación profesional constituye un conjunto de enseñanzas válidas para un desempeño profesional de calidad, enfatizando en la posibilidad de adaptarse a los cambios laborables que pueden producirse.

La formación profesional del TSE que en las actuales circunstancias se realiza en Ecuador, en el Instituto Tecnológico Bolivariano en Tecnología, tiene como eje la responsabilidad, la competencia y el trato humano al paciente y su familia, pilares sin los cuales el servicio estará incompleto.

Siendo coherente con lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) al definir a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, los profesionales en formación de TSE tienen como propósito incrementar la salud del ser humano, lo que significa atender y promocionar una adecuada salud física, lo cual requiere fortaleza mental y espiritual para ser alcanzada.

El TSE una vez graduado, demanda la capacidad de formar juicios sobre la realidad y lo conduzca a actuar con pleno conocimiento, sin embargo, es limitado su estudio desde el Ecuador. El trabajo del Técnico Superior en Enfermería se desarrolla en equipo inter y multidisciplinario, siempre ha de estar apto para servir y ayudar a quienes lo requieran, su comunicación debe ser cordial y afectiva con el usuario, colegas y demás miembros del equipo de salud, mostrar seguridad y confianza en sí mismo, aplicar el sentido y valor de las normas éticas y jurídicas de la profesión, entre otras, cuestiones a considerar en la formación profesional del TSE.

Por consiguiente, el técnico en salud egresado debe ser un profesional competente para la demanda competitiva actual con solidez científica, con conocimientos, habilidades y valores que le permita tomar decisiones en la solución de problemas de manera multi e interdisciplinaria convirtiéndose de esta manera en un profesional confiable para el equipo de salud, capaz de aplicar y generar el auto cuidado, nuevos conocimientos y el uso de la tecnología, aspectos que inciden en los procesos de salud-enfermedad del individuo, la familia y la comunidad, y que se logran a partir de una concepción de lo formativo desde la formación inicial y para toda la vida profesional.

El TSE resuelve tareas propias de su profesión al actualizar sus conocimientos académicos en su relación con la actividad práctica, donde encuentra el espacio y los contextos propicios para poner de manifiesto el desarrollo de habilidades y los valores relacionados con el ejercicio de su profesión.

Así, el conocimiento de enfermería se significa a partir de asumir los criterios de Carper, B. (1978), al definir cuatro nociones fundamentales del mismo: el empírico (ciencia de la enfermería), el estético (arte de la enfermería), el moral (ética de la enfermería) y el personal (uso terapéutico del yo), los cuales son asumidos añadiendo que deben ser sistematizados en el proceso formativo por los sujetos que en intervienen en este proceso.

La formación profesional del TSE es de un profesional sensible a las necesidades humanas, consciente de su responsabilidad, al contribuir al bienestar de los demás con el compromiso profesional de estar al servicio de la sociedad, lo cual le imprime un papel decisivo a la moral, y a la Ética como ciencia que la sustenta, además debe trasmitir mensajes de salud con un proceder en correspondencia con la esencia humana de su profesión. Por tales razones, se impone profundizar en la moral y la ética que debe caracterizar a este tipo de profesional.

La reflexión interdisciplinaria es esencial desde la educación donde adquiere un papel importante, de ahí su significado en el proceso formativo de profesionales de la salud, como el camino para promover el ideal de sociedad que se aspira alcanzar, ya que no basta con promover la autonomía de las personas, también es preciso respetar y salvaguardar la identidad y el desarrollo integral de los pueblos, para lo cual es importante considerar la educación moral en valores.

Los valores constituyen expresión de sus necesidades e intereses tanto a nivel individual como social, pues orientan y regulan la conducta (Chacón, N, 2005), por eso la mejor educación en valores es aquella encaminada a una coincidencia entre la imagen subjetiva del valor con el valor real objetivo

de las cosas. De ahí que esta investigación reconoce la existencia de las dimensiones objetiva, subjetiva e instituida, según declara Fabelo, Corzo, R, (2004)

Los valores se vinculan a la subjetividad como elemento del proceso de socialización del individuo, en este proceso se incorpora a su subjetividad las normas y principios sociales (González del Rey, y otros, 1989). Y es aquí donde se relaciona la Psicología con la Pedagogía, la cual se interesa por su formación.

Se asume de la idea de González M, R. (2007) de que los valores tienen como categorías o propiedades la historicidad concreta (no son inmutables), la polaridad (a cada uno le corresponde un antivalor), la pluridimensionalidad (son objetivos, subjetivos e instituidos) y la pureza (son positivos e independientes de la cantidad), pero la categoría decisiva en la regulación de la conducta es la jerarquía.

Es precisamente en el proceso de aprendizaje del TSE donde se eleva su madurez moral en la práctica, al mostrar altruismo y el bien a los demás contribuyendo a solucionar los intereses de conflicto que puedan darse, de ahí la necesidad de convertirlo en pilar de la educación del mismo al enfatizar en la relación valor-conducta-conocimiento.

Con frecuencia en la literatura sobre la temática que se aborda, se identifican los conceptos Bioética y Bioética médica y/o Ética médica, sin embargo, en esta investigación, se parte de considerar la existencia de diferencias entre estos campos del quehacer ético actual, aun cuando se reconocen sus puntos de contacto.

La ética, como una de las disciplinas teóricas más antiguas cuyo objeto de estudio es la moral, ha adquirido desde la segunda mitad del siglo XX un avance incuestionable. En respuesta a la crisis ambiental contemporánea y a los muchos problemas que enfrenta la sociedad hoy, se manifiesta una

tendencia al retorno a la Filosofía como una herramienta para resolver problemas prácticos y, dentro de ella a la Ética como una reflexión necesaria sobre el ser y el hacer en el mundo.

En este contexto, surge un ámbito completamente nuevo de exigencia de juicio y responsabilidad por cuanto no basta con la ética tradicional con respecto a las relaciones interhumanas, sino que se empiezan a descubrir también, en relación con la naturaleza no humana deberes, valores y bienes que respetar. Siendo así, la Ética se debe ocupar entonces de la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza, y procurar el bienestar de ambas.

La ética influye en las normas de conducta entre los hombres en la sociedad con el nivel teórico o de reflexión y práctico o de acción, donde la moral constituye un marco básico de conducta personal y costumbres, un conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen el comportamiento con base en la praxis, es decir, lo que discurre como correcto o no.

Por consiguiente, la ética tiene carácter histórico-concreto, supone un conjunto de normas o leyes que definen el comportamiento de la persona, del grupo o la sociedad, y trata de fundamentar racionalmente dichas normas que en la actualidad han pasado a significar cosas distintas.

Investigadores consultados como Montserrat, M; Martínez, M. y Palos, J. (2010), reconocen el desarrollo de la ética en vínculo no solo a la educación institucionalizada, sino a partir del papel de la familia y la sociedad en general; al considerar la relación ética-moral-sociedad señalan que no solo implica la labor del maestro en el área cognitiva, sino también en otras áreas específicas asociadas al entorno sociocultural, elemento ratificado por Martínez, M. (2013), o al afirmar, como Fabelo, J R. (2004), la dimensión subjetiva de los valores dada por la forma en que estos son reflejados en la conciencia individual o colectiva.

Se significa a la investigadora española Camps, V. (2006), al expresar que la ética no puede prescindir de la parte afectiva o emotiva del ser humano ya que tiene como tarea esencial poner orden, organizar

y dotar de sentido a los afectos o a las emociones, idea asumida por estar asociada a la labor del enfermero.

La ética es concebida como el saber filosófico que reflexiona y fundamenta la moral, al tiempo que realiza prescripciones normativas sobre el comportamiento humano; la moral es un reflejo en la conciencia de las personas de las condiciones materiales de su existencia a partir de la forma histórica en que se han dado las relaciones sociales entre sí y de las actitudes y conductas asumidas en el transcurso de la vida, las que se expresan en forma de principios, normas, valores, costumbres y tradiciones sociales.

Alasdair, M. (2004) estudia a la ética y expresa que su contenido esencial está basado en cómo alcanza el individuo una vida buena donde encuentren plenitud todos los aspectos de la vida humana; en este sentido, al valorar el "bien moral" lo vincula a la relación individuo-comunidad y su relación en una práctica social, referentes donde no es explícito el contenido de la Ética a partir de los objetivos establecidos y las necesidades en su desempeño, no obstante, resulta de gran valor en el presente estudio.

A partir de estas ideas es posible reconocer rasgos distintivos como:

-En lo relativo a los valores, se consideran buenos o malos según la concepción del bien y el mal de una comunidad.

-Existe un conjunto de reglas consideradas buenas o malas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, evidencia de que la moral de cada pueblo se relaciona con sus costumbres y su forma de vida.

La ética es la parte de la filosofía que estudia la conducta humana en relación con su bondad o malicia en cada época.

Así, desde la perspectiva, del estudiante TSE se justifica el papel de la ética asociada a "los valores adquiridos a través de la socialización en el grupo dominante o a través del aprendizaje personal, tienen impacto al menos en dos sentidos igualmente relevantes: a) motivan las acciones dándoles dirección, sentido e intensidad emocional, y b) actúan como criterios para juzgar y justificar la acción" (Casares, P, 2010, p. 8), por tanto, se orienta a dar respuesta a problemáticas relacionadas con la práctica del TSE.

Tales posiciones, conducen a abordar la dimensión ética en la formación profesional, y se concreta en la ética profesional, que implica considerar los valores de la profesión que va a desempeñar, su apropiación de manera reflexiva y crítica comprometido con la sociedad (Martínez, M y otros, 2003).

En documentos consultados del área de salud se enfatiza en la necesidad de preparar estos, no sólo en conocimientos y habilidades sino también en las cualidades profesionales de compasión, empatía, honestidad y sentimiento de responsabilidad para con el paciente, la familia y la sociedad, (Musick D,1999) lo que resulta imprescindible para el abordaje del objeto que se investiga.

Grífols, V (2012), se refiere desde una visión desde el sector de salud pública, a los dilemas éticos y a sus implicaciones para la actividad de los diversos profesionales de la salud que interactúan en las comunidades enfatizando en los conflictos entre los intereses particulares —de personas y de grupos— y los de la sociedad en su conjunto lo que dificulta el desarrollo de estrategias y políticas de los estados y en el proceso de formación del técnico de salud. Aspecto de interés como referente teórico en la formación para la competencia ética en el TSE.

Resulta coincidente entre las principales críticas realizadas a diversos autores respecto a la ética profesional como categoría, (Martínez, M y otros, (2003), Teijón, A y J Cifre-Mas, J (2011), el hecho de reconocer en ella normas de carácter ético aplicadas en la actividad laboral a su entorno a partir

de una correcta labor, proceso mediante el cual elabora su identidad, llegando hasta el logro de un aprendizaje ético.

Para el tratamiento al aprendizaje ético, desde los intereses de esta investigación, fueron consultado los criterios de Bárcena, F (2000); Martínez, y otros (2003); Zeledón, María del Pilar (2005); Tey, y Cifre-Mas, J. (2011), que asocian el mismo a comportamientos de las personas derivados de la práctica, cuyo proceso considera, tanto la dimensión personal como la dimensión social, por lo que permite la toma de conciencia de la identidad personal y grupal.

El aprendizaje ético es considerado también como construcción de capacidades personales que permiten alcanzar mayor autonomía y responsabilidad sobre la propia actuación en relación con temas de relevancia ética y moral definición que relacionada a una actuación a partir de un conocimiento.

Es por tanto un aprendizaje que apuesta por la consideración activa de la persona en su propio proceso de construcción, y permite diferenciar lo que considera correcto de lo que tiene por incorrecto, la faculta para defender en lo que cree, potencia la visión respetuosa del otro, permite la toma de conciencia de la propia identidad (Tey, A y Cifre-Mas, J, 2011)

Ideas que están contenidas el Código Deontológico de Enfermería (2006) y su continuidad en el Tercer encuentro en 2011 en Ginebra (Suiza), al reflexionar acerca de la necesidad de promulgar valores, actitudes y comportamientos que debe caracterizar a dicho profesional, y enfatiza en la independencia y responsabilidad de sus actos en correspondencia con el humanismo que se necesita para poder ayudar a las personas a conservar su salud.

Estas precisiones ratifican el valorar de la ética en la formación del TSE y fundamenta el comportamiento moral que han de tener para adecuarlo al bien dela sociedad y el individuo, valoraciones sirven como referentes importantes para el tratamiento de la bioética.

Existen diversidad de criterios, interpretaciones y definiciones entorno a la bioética; a los efectos de esta investigación, se asume como el campo de la reflexión filosófica, la investigación científica multidisciplinaria y el debate académico y público, cuyo objeto es el comportamiento moral de los seres humanos respecto a los problemas tanto globales como locales de salud, alimentación, superpoblación, degradación ambiental, supervivencia y mejoramiento del bienestar y la calidad de la vida humana y no humana, así como los actos deliberados de intervención directa o indirecta en los procesos biológicos. Se es del criterio que la Pedagogía, en este contexto de análisis desde la bioética y/o ética global, asume una visión participativa en lo formativo, que favorece un aprendizaje más integral en el TSE, señalado por autores como Ocampo, M. J. (2005); Outomuro, D (2008), entre otros.

Para Ocampo, M. J. (2005), la bioética es "…un quehacer reflexivo de carácter ético acerca de las múltiples implicaciones de las relaciones del hombre con el fenómeno de la vida en general y con el de la vida humana en particular…" (p.23), criterio que se orienta a trascender la dicotomía: conocimiento(s)-valor(es), colocando a la construcción social de saber decididamente al servicio de la vida, aunque no solo de la vida humana.

Asimismo, tiene en cuenta la dimensión moral de las ciencias de la vida y las consecuencias morales de cualquier acto relacionado con la Biología y la moralidad de las decisiones humanas respecto a realidades biológicas humanas o no (deberes, derechos y obligaciones morales).

Outomuro, D, (2008), realiza especulaciones filosóficas sobre quiénes, al margen de los individuos, tienen también derechos morales (fetos, partes de individuos, células, órganos, especies o individuos en estado de degradación) así como de los derechos de los animales y del medio ambiente en general; considera además que la bioética "...comprende un terreno muy amplio que va desde los aspectos

complejos de la relación cuasi privada entre médico y paciente, alcanzando la problemática y los planteamientos ecológicos planetarios, desde distintas visiones." (Outomuro, D, 2008, p.12).

Para Alfonso Sánchez, I otros (2000), la bioética toma y considera al ser humano en su relación estrecha con los factores ambientales, como son naturaleza, cultura, religión, política, sociedad, entre otros, presupuestos ratificados por Fernández Burillo, S (s/f) al considerarla dentro de un campo de investigaciones interdisciplinario y universalista, en tal sentido, busca la verdad de todo aquello relacionado con el bien integral del paciente. Esta acertada consideración no se limita a la ética biomédica, sino tiene en cuenta a la ética del enfermero cuya actividad posee características singulares y conflictos específicos.

Desde la orientación investigativa, la Bioética es considerada importante materia de enseñanza en el proceso de formación de los profesionales de la salud en cuyo desarrollo se debe tener en cuenta que "… la enseñanza de la Bioética pierde su sentido si se limita a la transmisión de conocimientos, y que solo tendrá sentido si busca el cambio, y la transformación profunda de quien aprende, en su forma de percibir el mundo y por lo tanto de su forma de actuar "(Segura, R, 2010, p.17).

Las valoraciones anteriores reafirman la necesidad de fomentar la educación bioética en el contexto educativo del TSE en Ecuador; en este sentido, se asume como educación bioética "el proceso dirigido al desarrollo de los conceptos, las aptitudes, las habilidades y los valores necesarios para formar una nueva cultura de la vida y de la naturaleza, que permita la participación responsable en la valoración, la prevención y la solución de dilemas relacionados con la dignidad humana, la calidad de la vida y la del medio ambiente" (Cárdenas, Y. 2006, p.8).

Esta visión integral de la salud exige la consideración de las condiciones que determinan los fenómenos de salud y enfermedad en cada comunidad y región, y la utilización de métodos para indagar críticamente en la realidad.

El surgimiento de la bioética propició, entonces, la renovación de la ética médica desde la nueva perspectiva que brindaba esta como paradigma, significó el inicio de la revolución burguesa en el campo de las relaciones morales en la esfera de la salud orientándose a la superación del desfasaje histórico existente entre éstas -que aún conservaban el carácter jerárquico, despótico, autoritario y de dependencia personal característico de las relaciones sociales en las sociedades pre capitalistas- y el resto de las relaciones sociales del sistema capitalista.

En la investigación, se ha tenido en cuenta los ámbitos de la bioética que engloba los problemas éticos derivados de los procederes sanitarios: transfusiones de sangre, eutanasia, trasplantes de órganos, reproducción asistida o mediante fertilización in vitro, aborto y otros asuntos implicados en la relación médico-paciente y los problemas de la investigación científica, en particular la investigación biomédica, que tanto pueden transformar al hombre: manipulación genética, tecnologías reproductivas como la fecundación in vitro o la (por ahora sólo hipotética) clonación humana y otros.

La bioética médica constituye uno de los ámbitos de acción de la bioética, es una de las tendencias en las que se ha manifestado ésta desde su surgimiento e incluso una de las más visibles e influyentes- pero no pueden identificarse, por cuanto es el resultado de la influencia de la bioética en la deontología médica que desde sus orígenes incidió positivamente en:

La renovación del interés por el estudio de los problemas éticos generados en la esfera de la salud.

La atención a la necesidad de democratizar y “moralizar” las políticas de salud, las investigaciones y las prácticas médicas.

La introducción del enfoque axiológico y de la perspectiva del paciente en particular y de la sociedad en general, en sus dimensiones cultural y ética en el proceso de toma de decisiones médicas.

Las diferentes concepciones con respecto a la bioética y la necesidad de aprehender procesos relacionados con la ética de la vida en general que han cobrado una gran importancia hoy han

condicionado el uso del término ética global o profunda, que se asume por considerarlo generalizador de las acepciones anteriores.

Estos referentes acerca de la ética profesional y el aprendizaje ético permiten analizar la formación profesional desde diversos enfoques, uno de ellos es la formación por competencias, basada en competencias o de competencias.

Al realizar un análisis del término competencia, se observan diversos criterios acerca de su definición y naturaleza, tales como: Hager, H. (1996); Gonczi, A. (2001); Forgas, J (2003); Posada Á R (2004); Fuentes, H, (2000-2007); Larios, H, (2006); Cifuentes, M (2008), Salas, W, (2010), con lo cual se revela su carácter polisémico y utilidad según los fines investigativos.

Se significa en Ecuador a Cifuentes, M (2008) el cual realiza una valoración del término competencia asociado a procesos educativos y aporta una definición que tiene por base un estudio socio histórico de su comportamiento. Realiza además una mirada al concepto desde dos vertientes: una asociada a la producción de bienes y servicios, y otra asociada al conocimiento y capacidades cognitivas.

En tal sentido, al valorar la competencia lo hace a partir de considerar tipos de contenidos: cognitivos, procedimentales y actitudinales asociados mediante relaciones de complementariedad, significando que los tres tipos de contenidos es igual a los tres tipos de saberes conocidos como aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser (UNESCO, 1996). A juicio de esta autora, la competencia está en el sujeto que revela su esencia al interactuar con eficiencia en su contexto profesional.

Hager, H. (1996) hace referencia a la competencia y su relación con las aptitudes de la persona y el desempeño satisfactorio de las tareas inherentes a su profesión, y enfatiza en la relación intrínseca entre aptitud y desempeño; y añade esta investigadora, que es una necesidad en esa relación el peso que deben tener las actitudes, las que tienen que ver con los valores morales profesionales que constituyen esencia de la formación profesional de la competencia.

En esta investigación se reconocen los rasgos distintivos entre las categorías "actitud" y "aptitud". Se entiende por aptitud el conocimiento o capacidad para desarrollar cierta actividad, el carácter o conjunto de condiciones que hacen a un individuo especial e idóneo para una función determinada, mientras que actitud es la voluntad para encarar las actividades, es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas, la predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social.

Las definiciones anteriores determinan la necesidad de una atención formativa desde la concepción educativa de los diversos contextos donde se ubiquen las personas, por ello se establece una atención especial de tipo educativa para el desarrollo de la competencia ética en la formación profesional del TSE

El investigador Gonczi, A. (2001) señala que la competencia se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas, concibiéndola como una compleja combinación de aquellos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) para la ejercitación de las tareas que tienen que desempeñar en determinadas situaciones específicas.

Las valoraciones de los autores consultados, definen posiciones diversas de competencias asociándolas a comportamientos, saberes, capacidad, procesos, entre otros. Se revela así las diversas posiciones teóricas asociadas fundamentalmente al saber hacer.

Es positivo que los mencionados investigadores establezcan la sistematización de los componentes de las competencias y las tareas que se corresponden en la ejecución del desempeño, sin embargo, no abordan la solución de problemas no predeterminados, para que pueda diferenciarse lo estático de lo dinámico en la resolución de problemas propios de la profesión.

1.1.1. La formación de la competencia ética de los estudiantes Técnico Superior en Enfermería.

Las competencias profesionales son entendidas como conocimientos, habilidades y atributos personales de la conducta de un sujeto, como característica de su comportamiento bajo el cual éste se orienta a la tarea; en este sentido, adquieren singular relación los componentes propios de las competencias profesionales como son las habilidades profesionales, y no aborda la cognición, la metacognición y los valores como elementos dinamizadores e integradores.

La formación de competencias profesionales debe estar orientada al desempeño, lo cual permite que el mismo se desarrolle de manera dinámica potenciando en la práctica la resolución de problemas comunes y no comunes de la profesión, cuestión que distingue al sujeto competente.

El investigador cubano Forgas, M. (2003) plantea que "La competencia profesional es el resultado de la integración esencial y generalizada de una serie de conjuntos de elementos sustentados a partir de conocimientos, habilidades y valores, que se manifiestan a través de un desempeño profesional eficiente en la solución de problemas de su profesión, pudiendo incluso resolver aquellos no predeterminados" (p.8).

Se asume esta definición, a partir de que establece el proceso de formación de competencias con un carácter humano, entiende al hombre como centro y reconoce en éste los conocimientos, habilidades y valores.

Con anterioridad se significó el valor de la ética en el profesional de la salud, por lo que, en el contexto de la práctica profesional de este, adquiere significativa importancia la competencia ética.

La ética como ciencia, para que tenga universalidad y validez racional, sustenta sus argumentos en el comportamiento humano sobre la moral, proceso considerado indispensable en la formación de competencias profesionales, aspecto vital en la formación profesional del TSE para la solución de los

problemas que tiene que enfrentar sabiamente en los diferentes contextos de actuación, proceso asociado a la formación de la competencia ética.

La formación por competencias ética ha sido objeto de estudio de diversos investigadores, para el desarrollo de la investigación se consultaron trabajos de Arguelles, A. (1996); Fernández B, S (2000); León, P. (2006); Cortés, P.A. (2009): García, E (2010) y Gurruchaga R, E y colectivo (2011); entre otros.

Se significa a Cortés, P.A. (2009) que presta atención la competencia ética como una competencia transversal, interpersonal y esencial que ha de aprenderse para saber hacer, ser y estar desarrollando cualquier profesión de manera adecuada, criterios que son asumidos a partir de su asunción como bien axiológico en sí mismo y para otros. De ahí su relación con el pensamiento crítico, convicción personal, comunicación interpersonal, independencia, responsabilidad, y otros.

Por su parte, León, P. (2002), en sus estudios de competencia en las Ciencias de la salud, parte de considerarla como lo intrínseco a la esencia y fin de la medicina asociada al buen trato hacia pacientes, familiares y familias en su práctica cotidiana y de forma dinámica, lo cual incluye no solo los conocimientos técnicos del saber de la medicina, sino los "valores y principios éticos que rigen la relación médico-paciente" (León, P. 2009, p.2), análisis acertado pero limitado a la ética del médico, sin considerar las potencialidades y peculiaridades del técnico de salud, aunque ello sirve de sustento al desempeño de éste.

Es asumido por la autora de esta tesis las valoraciones de León, P. (2002) respecto a la delimitación entre competencia clínica (determinada por directrices o protocolos) y la competencia ética (que proporciona la capacidad para comprender el sentido y las consecuencias de las nuevas situaciones y procedimientos clínicos), aun cuando ambas en la práctica del estudiante TSE constituyen competencia profesional.

Fernández, B (2010) asume como competencia ética las acciones orientadas a un fin: hacia la perfección de la naturaleza humana, definición que se vincula al desarrollo de acciones humanas; en este sentido, se adentra en la conciencia de los hombres y puede llegar a ejercer una influencia inversa sobre el estado y desarrollo de la moral desde lo humano, profesional y laboral.

El autor relaciona la ética con las acciones humanas que atañen al mundo del trabajo y, por ende, el lugar donde éste se desarrolla. Desde esta consideración, la mayor limitación del autor está en la valoración que hace desde el mercado capitalista cuya intencionalidad final es una competencia laboral fundamentada en el saber hacer, relegando a planos inferiores lo humano profesional.

Herrera, L (2009) relaciona la moral con los hábitos del saber y el actuar impregnando colectividad, por lo que constituye un proceso de aprendizaje que permite comprender; en este sentido, significan la educación moral como un aprendizaje que permite comprender, practicar e interesarse por valores éticos, dentro de los cuales se incluye el respeto, la justicia, la virtud cívica, ciudadanía y la responsabilidad por el prójimo.

García, G. (2010), valora la competencia ética desde la posición del docente y propone cinco ámbitos: conocer, hacer, querer, convivir y ser, que se corresponden con las dimensiones de la educación del alumno en las condiciones actuales. Se reconoce que esta propuesta constituye un intento válido que requiere preparación del docente, tanto personal, cognitivo, afectivo y moral para poder ejercer una práctica profesional de calidad, criterio considerado positivo, sin embargo, en su análisis no profundiza en cómo desarrollar la competencia ética en el estudiante desde el proceso formativo.

Se tiene como fundamento general la idea de que la educación -en el sistema de salud-en su función formativa-desarrolladora permite la formación de la competencia ética como uno de sus componentes desarrollado en su vínculo con la práctica, aspecto que le permite al estudiante en formación

desenvolver todas sus potencialidades personológicas e integrar las cualidades cognitivas, afectivas y actitudinales

En un acercamiento a la formación de competencia ética de los estudiantes TSE se considera que se constituyen en una configuración psicológica compleja que integra en su estructura y funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que determinan la calidad de la actuación profesional y garantizan un desempeño profesional responsable y eficiente (Mariscal, L 2016).

El colectivo de autores españoles Tey A; Vilá, R y Martínez, M (2014) van más allá en sus estudios sobre las competencias para el aprendizaje ético de los estudiantes universitarios, al asumir que de lo que se trata es lograr una percepción en relación a la capacidad de reflexión y convivencia del estudiante, proceso que se relaciona con la responsabilidad social de las universidades y su compromiso para alcanzar niveles óptimos de profesionalidad.

Para este colectivo de autores, la formación ética en las universidades de salud no debe identificarse solo a formación deontológica para el ejercicio de las diferentes profesiones, sino además es importante las condiciones y prácticas sociales en los diversos espacios de aprendizaje, de convivencia y participación. Con estos criterios se reconoce la esencia creativa y contextual para promover transformaciones sociales, ideas compartidas en esta investigación.

En resumen, para que se produzca las competencias para el aprendizaje ético del Técnico Superior en Enfermería, si bien no se reduce a la apropiación de determinados contenidos, es necesario una selección curricular adecuada de los contenidos del sistema de salud en general, y del Ecuador en particular, a partir de una naturaleza ética, o sea, aquellos que tengan más potencialidades para la formación y desarrollo de la cultura ética y humanista para la preparación de los mismos con vistas a asumir este proceso, de los futuros técnicos de la salud, en la práctica comunitaria y/o hospitalaria.

Por otro lado, la formación ética del TSE en el contexto de Ecuador no puede estar al margen de la influencia de la “Filosofía del Buen Vivir”, entendida como un conjunto de ideas que, aunque aún en construcción, desempeñan un papel fundamental en la sociedad ecuatoriana.

En Ecuador, el "Buen Vivir" constituye un marco conceptual para fundamentar un conjunto sustantivo de derechos refrendados en la Constitución de Montecristi y el Plan del Buen Vivir (2013-2017), ahora se denomina Toda una vida (2017-2021). Estas ideas, además, aportan elementos al marco teórico conceptual que fundamenta la educación ecuatoriana, la cual es considerada al mismo tiempo como “…condición indispensable para la construcción del derecho del Buen Vivir en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza” (LOES Art., 9, p.12), y específicamente se dirige a la formación de profesionales, técnicos y tecnólogos en la Educación Superior.

La filosofía del Buen Vivir incorpora las concepciones holísticas de la vida humana como parte de un complejo mayor propias del indigenismo andino y amazónico, pero significa un nuevo modelo de vida -frente a la concepción occidental- que va más allá de los indígenas y con valía para todo el planeta. Estas concepciones no implican una vuelta al pasado, sino son ideas contemporáneas surgidas de intelectuales indígenas y no indígenas.

La filosofía del Buen Vivir puede considerarse una filosofía alternativa que amplía el marco de consideración político desde lo social y lo antropocéntrico hacia lo biosocial. “… el “Buen Vivir” significa rescatar la armonía entre la naturaleza y el hombre, entre lo material y lo espiritual, pero en el mundo actual. Construir el futuro es la meta, y no regresar al pasado. Esto no significa una fe ciega en el progreso científico y tecnológico, ni un desprecio de las sociedades ancestrales…No se trata tampoco de una valorización ética, como si el uno fuera mejor que el otro, sino de una perspectiva histórica,

capaz de condenar lo que llamamos “progreso”, calificándolo de “mal desarrollo” y de apreciar los saberes y las prácticas materiales y simbólicas de las sociedades del pasado.” (Houtart, F. 2011, p.32). El Buen Vivir, entonces, sintetiza visiones y prácticas ancestrales, debates y propuestas actuales, pensamiento crítico y luchas sociales, juntas dinámicas nacionales e internacionales de respuesta al ‘modelo de desarrollo’ y al ‘modelo de civilización’ que han conducido a la actual situación de la humanidad y el planeta, reconocida como insostenible. Hace referencia a una filosofía de vida, un camino de vida, un plan de vida o sistema de vida con una estructura social sustentada en conceptos como complementariedad, reciprocidad, armonía, equilibrio, racionalidad, proporcionalidad, dualidad. Desde el punto de vista ético-axiológico propugna un sistema de valores entre los que se incluye el bien común, la justicia, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad y junto a los derechos individuales y comunitarios propugna además deberes como promover y anteponer el bien común al individual.

La filosofía del Buen Vivir invita a asumir otros “saberes” y “otras prácticas” al hacer visibles saberes y concepciones que han estado ocultos y sojuzgados por largo tiempo; reconoce la interculturalidad como complemento de la plurinacionalidad y fundamenta sobre estas bases la necesidad de discursos comprensibles para todos y adaptados a todos los lenguajes.

La ética del Buen Vivir propugna la recuperación del equilibrio del eco sistema, recupera la idea de la vida como eje y categoría central de la economía, y la reintegración de la naturaleza en la historia, como inherente al ser social. En el Buen Vivir existe una consideración singular de la naturaleza en su concepción, los derechos de la naturaleza no equivalen a los derechos ambientales enfocados desde su incidencia en el disfrute que el ser humano hace de la naturaleza y los perjuicios que le ocasiona su deterioro, sino que son derechos de los que la naturaleza es titular.

Significa también la importancia de lo colectivo frente al individualismo y defiende la idea de "convivir bien" y no vivir mejor que los otros, considerando el papel de los bienes espirituales en el vivir bien.

La filosofía del Buen Vivir, como filosofía alternativa, por sus características y nivel de amplitud, está en la base de la política de salud ecuatoriana, de cuya implementación los TSE junto a otros trabajadores de la salud son actores, y aporta un posicionamiento ético de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y ambiental propia de la sociedad ecuatoriana sustentada en el conocimiento, el diálogo intercultural y el respeto a los derechos de la naturaleza y de las personas para el desempeño profesional.

El Buen Vivir es una propuesta global que respeta e impulsa los conocimientos locales como fuente del cambio y del retorno a la vida en armonía y equilibrio con la naturaleza y que determina la necesidad de un perfeccionamiento en la calidad de vida de los ciudadanos que permita el mejoramiento humano, aspecto que pondera las necesidades de brindar servicios de salud con calidad y que establece la necesidad de mejorar todos los procesos formativos del TSE

1.2 Reseña histórica de la formación de la competencia ética en el estudiante Técnico Superior en Enfermería.

En el contexto internacional, la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería se ha visto condicionada por un proceso de democratización de los Estudios Superiores y las exigencias sociales contemporáneas.

Específicamente, el proceso de formación del TSE en Ecuador, al poseer un periodo relativamente nuevo, le ha antecedido la formación de enfermería, de ahí que se consideren en la historia de la educación de esta, momentos importantes para el estudio que se sigue.

Se significa la creación de la primera Facultad de Enfermería en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 1965, a partir de la cual se van sentando las bases para el reconocimiento de la enfermería

como carrera universitaria, proceso que inicia a partir del año lectivo de 1965-1966, desde un enfoque curativo, aunque incorpora la atención integral al paciente.

En ese contexto, la labor del enfermero en su práctica muestra una fuerza moral, de valores y de principios éticos que se expresan en su conducta, que si bien se comportó en sus inicios como una buena conducta en la relación paciente-familia-médico, hoy en día comprende la práctica de la atención primaria de salud y hospitalaria donde el enfermero/a tiene nuevas responsabilidades en las que se presentan problemas morales y dilemas éticos.

Hacia 1967, se crea el Ministerio de Salud Pública, que direcciona la política de salud inexistente hasta ese momento, caracterizada por tratar la enfermedad y la hospitalización. Para 1978 se incorporan nuevos programas del Ministerio de Salud Pública, así como los estudios superiores de enfermería; más adelante, en 1984, se desarrolla la formación profesional del auxiliar de clínica y la escuela de enfermería, que en 1986 incorpora la categoría profesional de auxiliar de enfermería. Si bien no se formaban técnicos superiores en enfermería, los acontecimientos mencionados marcan una tradición pedagógica significativa para el proceso que se estudia.

En el año 2003, se crea el nivel técnico de enfermería y se modificó el programa de formación de los auxiliares de enfermería con el propósito de elevar la preparación y garantizar que pudieran proseguir la formación a niveles de licenciatura y posgrado. Aspectos reflejados en el documento Alcance a la Política de Educación de Enfermería (2001/2010).

En todos estos momentos la formación ética ha estado presente, pero no con toda la intencionalidad e integralidad, como la formación de estos profesionales se enfocaba hacia lo curativo, fundamentalmente, la formación ética se sustentaba en los elementos de la bioética médica, y no tomaba en consideración los aspectos relacionados con la perspectiva de la interculturalidad en otros contextos de desempeño y las relaciones con el medio ambiente.

Para la caracterización en la formación de la competencia ética en el TSE, se utilizaron fuentes teóricas como: revisión de la literatura especializada fundamentalmente de Ferrara Fa, Acebal F. (1975) y Viteri, G (s/f), el Plan Nacional para del Buen Vivir y la malla curricular, los cuales dan significado a la evolución histórica desde la formación del enfermero/a hacia el TSE.

En el estudio histórico se asumen como indicadores:

1.-Concepción e instrumentación práctica de la formación del TSE. Enfoque de la formación del TSE. Correspondencia entre el enfoque declarado y la práctica pedagógica. Lugar y papel de la formación ética en el proceso de formación.

Tratamiento de la formación ética desde lo curricular y lo extracurricular

2.-Concepción e instrumentación práctica de la formación de la competencia ética del TSE.

Concepción de la formación de la competencia ética.

Vías y métodos para la formación de la competencia ética.

Preparación del personal docente para la formación de la competencia ética.

Como antecedente de este análisis se significa que a partir de 1970 en el contexto mundial se incrementa la publicación de libros sobre ética en enfermería, revistas sobre ética y bioética, y en varias revistas profesionales se escribían mensualmente artículos sobre la actuación de los/as enfermeros/as, lo cual tuvo virtual reflejo en el contexto ecuatoriano.

En 1985 se establece el análisis ético en situaciones clínicas condicionadas por los avances de la ciencia y la tecnología en la atención sanitaria, así como problemas éticos y dilemas bioéticos en la clínica y en la investigación; se publica en 1994 el libro “Ética en la práctica de enfermería” que constituía una guía para la toma de decisiones éticas entre los profesionales de esta rama.

La Constitución de Montecristi se aprueba en Ecuador en 2008 y seguidamente otros documentos que reordenan la vida de la sociedad. En la esfera de la salud se aprueban: el Nuevo Modelo de Atención Primaria Integral de Salud y Vida (APISV) con Enfoque integrativo e Intercultural (2013); Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017); Manual y Modelo de Atención Integral de Salud, Familiar, Comunitario e Intercultural (2012) y la Ley Orgánica de Salud (2006) las que reorganizan todo el sistema nacional de salud.

Los documentos antes mencionados se encaminan a orientar las transformaciones en materia de salud, los mismos poseen un contenido ético, aun de diversidad de posiciones y modelos establecidos en el Sistema Nacional de Salud.

Momento importante en el contexto ecuatoriano, fue el desarrollo en el 2008, en Quito, del XI Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería con la temática sobre "Seguridad del paciente/usuario, ética y atención primaria en el cuidado holístico de enfermería", donde se presentaron 479 trabajos de investigación, de los cuales 93 se refirieron a la atención primaria de salud, 38 a la seguridad del paciente, 18 a lo laboral, 17 a la educación y 16 sobre Bioética, lo cual representó un salto para la formación ética del enfermero. En este evento científico, si bien no se constatan trabajos asociados a la competencia ética, fue expresión de un salto cualitativo respecto al accionar del enfermero, aunque asociado al TSE.

Este mismo año, dada las condiciones del Ecuador frente a las casas asistenciales, debido a la alta demanda de pacientes y la escasez de un recurso humano formado para dar atención de calidad, calidez y con conocimientos científicos necesarios, se solicitad al Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) la aprobación de la nueva carrera de TSE en la ciudad de Guayaquil.

La intencionalidad de esta nueva carrera se corresponde con las trasformaciones sociales llevadas a cabo en el país a partir de la instrumentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 el cual

plantea nuevos retos, fundamentalmente de cambios en la Revolución Ciudadana hacia la construcción de un Estado plurinacional e intercultural para así alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos.

El TSE que se formaría, desde su concepción, declara explícitamente la necesidad de formar un técnico "con sólidas bases humanas, científicas y técnicas" quedando implícito en su objetivo una competencia ética asociada a la formación humana, científica y profesional. (Justificación, 25 de febrero del 2008 solicita al CONESUP, la formación de la carrera).

Sin embargo, en la concepción de la carrera del TSE se carece de una estrategia pedagógica formativa del sistema de valores de la profesión de manera explícita, basada en una concepción pedagógica, que garantice una formación óptima y de buena calidad moral y ética de los futuros profesionales desde su formación inicial, hasta la terminación de sus estudios académicos.

La malla curricular del programa del TSE comprende un total de cuatro semestres de estudios, en los cuales el estudiante recibe 100 créditos. El total de créditos requeridos para titularse es de 122, de modo tal que los estudiantes deben cumplir con pasantías tutoradas de 12 créditos, y finalmente, realizar el proyecto de titulación que tiene una valoración de 10 créditos. La enseñanza formal de Ética ésta sólo en el curso propedéutico con un total de 10 horas desde lo curricular, la ética profesional del TSE.

Una mirada a los syllabus que conforman la malla curricular revela que en la intencionalidad formativa de los objetivos hacia el técnico que se aspira formar, prima el conocimiento y las habilidades técnicas, no así los valores, siendo espontáneo el trabajo en este sentido según la experiencia del docente. Desde esta perspectiva, la formación ética del TSE adolece de una suficiente concepción de formación ética en el currículo de la carrera desde su concepción inicial.

En mayo de 2009, se realiza un proceso de rediseño de la malla curricular en la carrera, pero aún era insuficiente el tratamiento al desarrollo de la competencia ética en el TSE, no obstante, a partir del curso escolar 2010-2011 se instrumentó como curso propedéutico el syllabus "Valores y Ética personal"; sin embargo, no se revela en éste el alcance de la competencia ética al solo definir categorías como la moral, los valores, las normas morales y las formas de comportamientos del técnico en su accionar.

Quedaba insuficientemente revelado el cómo, al solo identificar desde lo teórico las categorías generales asociadas al desarrollo de la competencia ética. Tal imprecisión está en las insuficiencias de las orientaciones metodológicas del programa, tanto en el orden teórico como práctico, ya que no se delimita su intencionalidad en la formación del técnico como tampoco la bibliografía a utilizar y que pueda orientar el desarrollo de la competencia ética atendiendo a sus especificidades.

Una evaluación del pensum de la carrera Técnico Superior en Enfermería actualmente revela que no se ha podido lograr en la práctica, una formación ética para el logro de la competencia ética del mismo, por cuanto es insuficientemente tratado en el contenido y las orientaciones a los docentes para su abordaje en el proceso de enseñanza aprendizaje y las prácticas profesionales

En este sentido, las estrategias y metodologías utilizadas en la formación del Técnico Superior en Enfermería, no aprovechan, suficientemente, las potencialidades que brindan los contextos de actuación para la sistematización y generalización de los contenidos a partir de considerar el sistema de valores de la profesión.

Se resume entonces, a partir del análisis realizado que:

Limitada concepción, vías y métodos de la formación ética integral a través de todo el proceso de formación del TSE, y su incidencia en la práctica es aún insuficiente

Asistematicidad y espontaneidad como características principales en el tratamiento a los contenidos éticos en la formación del TSE.

Aun cuando se reconoce el empleo de los métodos generales desde la didáctica para favorecer el aprendizaje ético de los estudiantes TSE, no se evidencia una concepción metodológica lo suficientemente fundamentada para la formación de la competencia ética en el TSE.

1.3 Diagnóstico del estado actual de la formación de la competencia ética del estudiante Técnico Superior en Enfermería

Ante la verificación de la existencia del problema científico en la formación de la competencia ética en el TSE, se desarrolló un diagnóstico a partir del análisis e interpretación de los resultados de las diversas técnicas utilizadas basado en los siguientes indicadores:

Para docentes y autoridades:

1. Concepción e instrumentación práctica de la formación de la competencia ética del TSE.
2. Concepción de la formación de la competencia ética (concepción del PENSUM y los syllabus)
3. Vías y métodos para la formación de la competencia ética (curricular extracurricular).
4. Preparación del personal docente para la formación de la competencia ética.

Para los estudiantes

1. Importancia que atribuyen a la formación ética para el ejercicio de la profesión
2. Modos de actuación que revelan la formación de la competencia ética.

El diagnóstico se realizó en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología de Guayaquil-Ecuador en el 2018 en la carrera de TSE, a través de un muestreo intencional de 40 estudiantes, 4 directivos y 12 docentes.

2 La población es de 300 estudiantes de la carrera TSE

La selección del grupo de estudiantes obedece a que, en su composición, son de diferentes procedencias; esgrimen un criterio mucho más objetivo; han transitado por casi toda su formación y han desarrollado prácticas en instituciones de salud donde se han dado cuenta de las insuficiencias de competencia ética que tienen en su formación y están culminando su carrera Se utilizaron técnicas empíricas de investigación tales: entrevista a estudiantes (Anexo 1), entrevista a docentes y directivos (Anexo 2), análisis documental (Anexo 3), y observación científica (anexo 4)

Se reconocen las potencialidades del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología y del proceso formativo en la carrera TSE que se constata en la concepción de un proyecto institucional y de carrera que contribuye a perfeccionar la labor de sus estudiantes y docentes.

El análisis de los resultados de las *entrevistas aplicadas a los estudiantes* reveló por el56% (cuyas edades fluctúan entre 17–24 años, y el 44% entre 25–31 años y más; esta diversidad se debe a las posibilidades que brinda la institución de aceptar matrícula sin restricción de edad; el 17.5% (7) son varones, y el 82.5%, es decir 33 restantes, pertenecen al sexo femenino), coinciden con la iniciativa de insertar la asignatura Ética médica en la malla curricular de la carrera de TSE como eje transversal del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano en Tecnología de la ciudad de Guayaquil.

El 85% del total de la muestra de estudiantes considera que la Ética forma parte esencial del desempeño de los profesionales en el área de la salud; expresan además que en los contenidos de los syllabus no se trabaja lo suficientemente para lograr una formación integral que permita poseer todas las cualidades necesarias de la profesión; es limitada la jerarquización de los valores éticos en los estudiantes; resulta insuficiente el cómo aplicar ciertas normas o procedimientos.

El análisis de los resultados de las *entrevistas aplicadas a docentes y directivos* revela necesidad de potenciar el uso de herramientas para trasformar modos de actuación en la atención con pacientes, de modo tal, que al ser jóvenes se podría facilitar su formación en valores éticos.

El 62% de los docentes considera no haber recibido durante su preparación profesional la suficiente formación en valores y Ética médica, condicionado fundamentalmente, por los contextos de estudio no abiertos a las prácticas comunitarias.

EL 100% de los docentes considera necesario emplear métodos para facilitar la transferencia de conocimientos en valores a los estudiantes y facilitar el desarrollo de modos de actuación en correspondencia con los valores de responsabilidad, sensibilidad humana, la beneficencia, discreción profesional, entre otros.

El100% de los docentes y directivos están dispuestos a poner en práctica acciones para fortalecer la formación en ética profesional de los técnicos de enfermería, considerando además que la implementación de la Ética se logra si se establece desde el tratamiento de los contenidos de los syllabus una adecuada estructuración de acciones de carácter docente y extradocente que direccione esta formación para mejorar la situación actual.

Los resultados de los *documentos normativos* revisados permitieron constatar que, si bien se constata en los syllabus, los objetivos generales del perfil del egresado y de cada módulo o asignatura problemas éticos a alcanzar por los estudiantes TSE; sin embargo, no está suficientemente explícito el cómo lograrlo en la práctica profesional, lo que no se corresponde con los propósitos de la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

Al revisar el pensum y la malla curricular se evidencia que, si bien los mismos declaran la formación por competencias, no queda explícito como llegar a formar competencia ética en el TSE, ya que no definen las competencias a formar. En estos documentos no está reflejados el poder alcanzar la competencia ética en su carácter trasversal.

El pensum vigente en la carrera, aún no brinda el suficiente tratamiento a la importancia requerida en lo referido al área de la ética profesional, lo cual se evidencia en que únicamente el 33% de las

autoridades encuestadas respondieron afirmativamente a esta pregunta, contra el 54% de estudiantes, aspecto constatado en la observación realizada

Constituye una necesidad revelar aspectos de carácter ético en los syllabus para el desempeño del Técnico Superior en Enfermería a partir de las especificidades del contexto ecuatoriano, ya que los mismo no ofrecen al docente orientaciones metodológicas explícitas para la implementación en la práctica pedagógica.

El análisis de los resultados de la *observación científica* reveló que existe disposición de las autoridades y de los docentes de continuar preparándose para recibir formación ética, y de este modo poder obtener mejores resultados al transmitir, no solo conocimientos, sino además actitudes orientadas a la práctica de valores a sus estudiantes.

Se pudo constatar, además, a partir de la técnica de la observación científica, insuficiencias en el desempeño dado en el enfoque al tratamiento de los contenidos por los docentes. Se pudieron identificar además actividades donde los estudiantes desempeñan un papel protagónico en el ejercicio de la profesión y podría ser escenario para poner a prueba un aprendizaje ético como las ferias de nutrición, ferias innovadoras y de emprendimiento, sin embargo, aún es insuficiente.

En resumen, las insuficiencias detectadas en el proceso de formación de la competencia ética en estudiantes de TSE son las siguientes:

- Prevalece la utilización de los métodos espontáneos para el desarrollo de los contenidos de los programas.
- Insuficiencias en el aprendizaje ético del TSE en contextos de actuación, lo que limita el análisis de las problemáticas de salud a partir de las experiencias, intereses y motivaciones de los futuros egresados.

- Se revelan posiciones ambiguas que muestran limitaciones cognitivas y técnicas, evidenciándose la necesidad de incorporar, como eje transversal, en la malla curricular del TSE la necesidad de delimitar la concepción de la competencia ética en el técnico.
- Se revelan insuficiencias teórico–metodológicas en el tratamiento a los contenidos de la competencia ética en la formación del TSE, lo que denota limitado desarrollo de la competencia ética en el mismo.

Conclusiones del capítulo I

-Las insuficiencias epistemológicas declaradas en la formación del TSE revela que ha existido una atención espontánea y empírica en relación de la competencia profesional y la competencia ética en el profesional. La formación del TSE apunta desde su diseño a lograr un profesional con fundamentos en Ética, Bioética y Ética global, considerándose como determinante el equilibrio hombre-naturaleza y hombre-entorno;

-La caracterización de la evolución histórica, así como la caracterización del estado actual de la problemática investigativa permitió constatar que existen insuficiencias en la práctica en formación ética del TSE y demanda ponderar el desarrollo de la competencia profesional en el TSE.

CAPÍTULO II CONCEPCIÓN PEDAGOGICA DE FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA EN EL TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA

El capítulo presenta la contribución a la teoría de la investigación, consistente en una concepción pedagógica de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería, esta tiene como punto de partida los fundamentos epistemológicos desde diversas ciencias y se estructura sobre las bases de las tesis de partida y los conceptos básicos que constituyen el marco teórico.

2.1 Fundamentos que sustentan la concepción pedagógica de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

La concepción que se propone, constituye una postura epistemológica con respecto al proceso de formación ética del TSE adecuado a las peculiaridades de la formación y a los problemas que debe enfrentar este profesional una vez egresado, aspectos refrendados en la Ley Orgánica de Educación (LOES) de la República de Ecuador al señalar de su artículo 8 la necesidad de d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; (2011, LOES, p. 27).

Documentos legales como la Constitución de la República del Ecuador, el Plan del Buen Vivir (2013-2017), su actualización en el documento Toda una vida (2017-2021) y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) constituyen escritos básicos o instrumentos que refrendan la estrategia de desarrollo de la sociedad ecuatoriana a mediano y largo plazo, a la vez que se erigen en fundamentos legales de la propuesta.

Desde lo filosófico la concepción se sustenta en la ética dialéctico materialista, la filosofía de la educación y la filosofía del Buen Vivir, así como en la bioética global o profunda, como corriente

filosófica de la contemporaneidad, esta última constituye uno de los sustentos fundamentales de la propuesta.

Desde la ética dialéctico materialista se asume el condicionamiento histórico-social de la moral y su consideración como fenómeno cultural; se parte de que la moral es una forma específica de conciencia social que refleja, a través de sentimientos, concepciones, representaciones, normas, principios y valores, al ser social en una época histórica determinada, de ahí su carácter histórico concreto.

Al considerar el carácter histórico-concreto de la moral se asume el reconocimiento de la existencia de la moral de las diferentes clases, grupos y profesiones dentro de la sociedad y se reconoce la existencia de una moral profesional la cual es estudiada por la ética profesional como ética aplicada. A los efectos de esta investigación, se asume como fundamento el Código de ética profesional del enfermero/a y la Ley de ejercicio profesional de las enfermeras y enfermeros del Ecuador (2011). Se tiene en cuenta además el principio ético de unidad de la conducta y la conciencia de los sujetos.

La filosofía de la educación aporta el marco teórico conceptual para modelar el proceso de formación de la competencia ética del Técnico Superior en Enfermería, a partir de la definición del ideal de hombre que la educación ecuatoriana dando cumplimiento al encargo de la sociedad, necesita y aspira a alcanzar; además de la concepción del hombre como ser educable y su relación con las condiciones sociales en que se desenvuelve la educación como proceso; todo esto concretado en el caso del ideal de profesional de la salud en general y del TSE en particular en el contexto de la sociedad ecuatoriana.

De la filosofía del Buen Vivir se asume su concepción ético-axiológico que propugna un sistema de valores entre los que se incluyen el bien común, la justicia, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad junto a los derechos individuales y comunitarios; y deberes, como promover y anteponer el bien común al individual. Estas ideas sirven de punto de partida y desempeñan un papel fundamental en la concepción que se propone, por la eticidad que propugnan y por ser propias del pensamiento

filosófico latinoamericano de todas las épocas históricas, en las mismas se amplía el marco de consideración de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales desde lo social y lo antropocéntrico hacia lo biosocial, criterio que está en la base de la educación como proceso y de la concepción que se propone.

De la filosofía del Buen Vivir se asume su concepción holística de la vida humana como parte de un todo de mayor nivel de generalidad, donde resultan de vital importancia la reciprocidad, la complementariedad y las relaciones multidireccionales de carácter cósmico propias del indigenismo andino y amazónico que supera la separación entre el hombre y la naturaleza, y por tanto, se asumen los valores que incluyen la convivencia comunitaria, la igualdad social, la equidad, la reciprocidad, la solidaridad, la justicia y la paz; que suponen igualmente una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza.

La bioética como ética global y profunda, aporta su visión de la relación sociedad-naturaleza, sobre la base del bienestar de ambas, a partir de la importancia de la naturaleza para la existencia humana y el reconocimiento de la existencia de deberes, valores y bienes que respetar en lo que a la naturaleza respecta, más allá de los beneficios que suponen para el hombre.

Sus posiciones fundamentan el contenido de la competencia ética del TSE y del proceso de su formación reconociendo la necesidad de un comportamiento ético respecto a los problemas de salud, el mejoramiento del bienestar y la calidad de la vida humana y no humana, así como en los actos deliberados de intervención directa o indirecta en los procesos biológicos ligados a la salud y sus consecuencias morales y las investigaciones médicas y su alcance; debido a que la bioética como ética global y profunda trasciende la dicotomía conocimiento(s)-valor(es), poniendo a la construcción social de saber al servicio de la vida, no solo como vida humana.

Como fundamentos sociológicos de la propuesta, se asumen la sociología de la educación y la

sociología de la salud y su concreción en el plano social de las ideas de la filosofía del Buen Vivir en la República del Ecuador refrendadas en los documentos legales antes expuestos.

La sociología de la educación aporta la concepción de la educación como hecho social singular con identidad propia en relación con la sociedad en la cual se inserta, esto fundamenta la adecuación de la propuesta a las condiciones de la sociedad y la educación ecuatorianas. Desde esta perspectiva, se reconoce al Instituto Tecnológico y a los centros de salud donde los estudiantes realizan sus prácticas pre profesionales como instituciones sociales y a los grupos que actúan en ellas como grupos sociales sui géneris relativamente independientes respecto a la sociedad en general, pero al mismo tiempo con estrechas relaciones entre ellos, portadores de su cultura y dentro de esta, su propio sistema de valores vinculados a la formación y el desempeño profesionales.

De la sociología de la salud, se asume la relación estrecha de la salud con las relaciones sociales, su inserción en la dinámica social, entendiendo la salud y la enfermedad como fenómenos sociales, aspecto que se tiene en cuenta al llevar a cabo los servicios de salud y al concebir la problemática de la ética de las relaciones sociales del TSE con miembros del equipo de salud, usuarios de sus servicios, familiares y comunitarios

Desde lo psicológico, la propuesta se sustenta en el Enfoque Histórico Cultural del psicólogo ruso Vygotsky, L.S. y seguidores del cual se asumen sus posiciones con respectos al carácter inter e intra subjetivo de los procesos de internalización de las funciones psíquicas superiores así como el papel de la cultura en la formación de la personalidad, desde esto último se reconoce la naturaleza social y cultural del proceso de formación ética del TSE; la concepción de la situación social del desarrollo posee valor epistémico al analizarse dialécticamente la interrelación entre los factores internos (conciencia y subjetividad del individuo) y los factores externos (elementos socio culturales) en dicho proceso. Desde esta posición, se destaca la importancia de las vivencias en los contextos de actuación

del TSE en formación.

Como fundamentación de la propuesta se tiene en cuenta, además, la relación entre lo cognitivo y lo afectivo como elemento medular para comprender el desarrollo de la personalidad, la aprehensión del sistema de valores socialmente establecidos y el sistema de valores de la profesión como condición necesaria para la formación de la competencia ética del TSE en formación.

La psicología de la salud permite considerar que los sentimientos y las emociones tienen efectos positivos o negativos en el bienestar psicológico y físico; en este sentido la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales constituye un factor asociado a un mayor nivel de la salud.

Desde el punto de vista pedagógico la concepción se fundamenta en la consideración de la educación como proceso conscientemente organizado susceptible de analizar, como proceso y como resultado, lo que permite concebir la formación del TSE en el proceso pedagógico, como momento integrador de todas las influencias educativas que tienen lugar en los diversos contextos socio-formativos en que se desenvuelve.

Esta concepción del proceso pedagógico reconoce además su condicionamiento a las necesidades, objetivos y tareas expresadas en el Modelo del Instituto Tecnológico en Ecuador y concreción en el Modelo del ITB, cuyos propósitos se resumen en instruir y educar al TSE en respuesta a las necesidades sociales contemporáneas en el campo de la salud en la República del Ecuador

Se asumen las concepciones pedagógicas actuales sobre la educación en valores, al reconocer que los mismos forman parte del contenido de la enseñanza y están presentes en todas las acciones de formación considerando a la educación en valores como proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza su preparación y se concreta a través de la conservación, desarrollo y difusión de la cultura profesional acumulada por la humanidad, en este sentido se tiene en cuenta los métodos de la educación en valores dirigidos a la conciencia, la actividad y la valoración. Se

asume el enfoque de formación por competencias o basada en competencias que se direcciona hacia la formación de profesionales más competitivos, aptos, comprometidos, flexibles y transcendentes, que reúnan cualidades morales, capacidad de argumentación y análisis, posean los conocimientos requeridos para desempeñarse eficiente y eficazmente, confiriéndole capacidad para el autoaprendizaje y la creatividad técnica (Forgas, J, 2003).

En este sentido, la formación por competencias, direcciona la formación de profesionales técnicos de la salud con una mayor capacidad de competitividad, innovación, creatividad; comprometidos y flexibles que puedan desempeñarse profesionalmente de manera eficiente y eficaz.

Se reconoce además como fundamento desde el punto de vista pedagógico, los principios para la dirección del proceso pedagógico (Addine F. y otros, 2002):

1. Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo en el proceso de educación de la personalidad
2. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso de educación de la personalidad
3. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de la personalidad.
4. Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad del educando.
5. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad.

Estos direccionan la formación de la competencia ética del TSE como un proceso donde se articulan las diversas influencias educativas, a partir del vínculo de la formación con las exigencias profesionales.

2.2 Contenido y estructura de la concepción de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería

A pesar de no existir consenso dentro de la comunidad científica acerca del reconocimiento de la concepción como resultado científico de las investigaciones educativas esta ha sido abordada por autores como Montoya, J. (2005), Fernández, K. (2006), Aguilera, E. (2007), Valle, A. (2007) Cortón, B. (2008), Barrera, J. (2011); Celeiro, A. (2012), Valle, A. (2013), Chiquito, R. (2017), Vaillant, J.(2019) y Galbán, Y. (2019) entre otros; quienes coinciden en considerar que una concepción incluye todo un sistema de ideas a partir del cual se representa y explica –de diversas formas- un determinado proceso de la realidad, en estos casos de la realidad educativa que tiene una esencia fundamentalmente teórica, aunque con las consiguientes implicaciones prácticas.

La consulta de diversas tesis doctorales que aportan una concepción como contribución a las ciencias pedagógicas, permitió constatar que estas se consideran dentro de una tipología diversa: pedagógicas, didácticas, metodológicas, entre otras. En la presente investigación se propone una concepción de pedagógica, siendo de interés un acercamiento a posiciones respecto a las mismas. Las concepciones pedagógicas constituyen un tipo específico de concepción teórica, en esta investigación se toman como referentes las elaboradas por Fernández, K. (2006), Aguilera, E. (2007) Cortón B. (2008), Celeiro, A. (2012), Chiquito, R. (2017), Vaillant J.(2019) y Galbán Y. (2019) los cuales, aunque abordan diferentes aspectos de la realidad educativa, reconocen como objeto el proceso pedagógico o educativo, y se expresan a través de un sistema de conceptos, principios, regularidades y representaciones teóricas, con carácter abarcador e integral, sobre la base de fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos, en todos los casos destacan la necesaria coherencia entre sus componentes y su dirección hacia un fin determinado relacionado con el fin de la educación y concretado en el proceso que se estudia. En algunos casos Chiquito, R. (2017) y Vaillant,

J. (2019), incluyen en la concepción un componente que denominan núcleo que consiste en la modelación del proceso a que hacen referencia.

A los efectos de esta investigación, se asumen los criterios de la investigadora Celeiro, A. (2012) quien considera que la concepción pedagógica, constituye una expresión teórica que incorpora un conjunto de ideas, conceptos y categorías que, desde relaciones internas, esenciales y estables, delimitan las singularidades de un proceso pedagógico, donde se significan rasgos esenciales de la formación del educando que aluden a contenidos afectivos, valorativos, motivacionales y relacionales y definen las cualidades personales del mismo. Esta se expresa a través de conceptos, categorías, juicios y representaciones teóricas dialécticamente relacionados y científicamente argumentados.

La concepción pedagógica que se propone en esta investigación parte de los criterios anteriores para conceptualizar y caracterizar el proceso de formación de la competencia ética del TSE, proceso que se deriva de la integración orgánica de la relación entre la bioética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la bioética médica

Se concibe la concepción pedagógica de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería como la representación desde un enfoque intercultural integral y ecológico de la formación ética del TSE, donde se articulan tesis de partida, conceptos esenciales dialécticamente relacionados que reflejan este proceso, la definición de la competencia ética del TSE y los elementos que la componen y la representación de las características del proceso formativo a que se hace referencia.

Su naturaleza pedagógica se expresa en que:

1. Se refiere a un proceso formativo, en este caso a la formación ética del TSE y específicamente a la formación de la competencia ética, en el marco de la institución educativa-el instituto técnico tecnológico-y con la dirección pedagógica de los docentes en el contexto del proceso pedagógico.

2. Se encamina al cumplimiento de los objetivos de la formación del TSE en correspondencia con los fines de la educación superior ecuatoriana.
3. Se desarrolla en las dimensiones curricular y extracurricular del proceso pedagógico aprovechando las potencialidades educativas del proceso de enseñanza aprendizaje y las vías y métodos de la labor educativa y específicamente de la educación en valores.

La concepción pedagógica de la formación de la competencia ética del TSE se caracteriza por:

1. Su carácter histórico concreto por cuanto hace referencia al proceso de formación del TSE en el contexto ecuatoriano.
2. Su enfoque intercultural, integral y ecológico aportado por la bioética como ética global o profunda, la bioética médica y la filosofía del Buen Vivir que tiene en cuenta el respecto a las diferentes culturas con las cuales interactúa el TSE en su formación y en su desempeño profesional, una concepción integral de la salud y de la atención sanitaria y de la vida no solo como vida humana sino en sentido general destacando la relación de la sociedad con la naturaleza.
3. Su carácter flexible por cuanto es susceptible de adecuar a las peculiaridades de este proceso de acuerdo a las características de los estudiantes y del claustro, y de las diferentes instituciones educativas en las que se forma este profesional y de salud en las que realizan las prácticas pre profesionales.
4. El reconocimiento de la educación en valores como vía para la formación ética del TSE.
5. El vínculo con la práctica profesional

La concepción que se propone parte de un conjunto de tesis o postulados teóricos que aportan el marco referencial más general para el análisis del proceso de formación de la competencia ética en el TSE, se definen las siguientes:

1. La formación ética se considera una dimensión de la formación en general y de la formación profesional en particular; aunque con aspectos comunes, con diferencias sustanciales relacionadas fundamentalmente con los objetivos de la formación en cada caso. La misma constituye un eje transversal en la formación del TSE.
2. En la formación profesional, la formación ética propende a lograr la aprehensión del sistema de valores propios de la profesión y a garantizar su asunción como reguladores de la conducta profesional, a la interiorización de los valores y principios de la ética profesional. En el caso de la formación del TSE por cuanto está basada en competencias supone la formación de la competencia ética.
3. La formación de la competencia ética en el TSE exige relacionar dialécticamente las ideas de la bioética como ética global o profunda, la bioética médica y la filosofía del buen vivir, sistemas de ideas que aportan elementos imprescindibles para la formación de una concepción integral y ecológica de la salud y de su atención; y la comprensión-solución de los dilemas éticos que se presentan durante el desempeño de este profesional desde un enfoque intercultural integral y ecológico.
4. La bioética como ética global o profunda aporta a la formación de la competencia ética en el TSE las bases para un enfoque más a tono con los problemas actuales, especialmente los ecológicos, al no reducir la vida a la vida humana y comprender la relación de esta con todas las formas de vida existentes aportando a la formación el compromiso de contribuir al cuidado de la "vida" como condición para el cuidado de la "vida humana", esta está en la base de una

concepción integral, holística de la salud y del enfoque ecológico en la solución de los problemas de salud y de los dilemas éticos que se presentan durante la asistencia.

5. La bioética médica aporta a la formación de la competencia ética en el TSE su enfoque humanista que exige la comprensión y análisis de las diversas dimensiones de lo humano que se concretan en el individuo y específicamente en el usuario de los servicios de salud, la preparación para concebir estrategias integrales para la solución de los dilemas éticos que se le presentan durante su actividad asistencial sobre la base del logro de la congruencia entre el sistema de valores de la profesión y el de los sujetos que interactúan en el proceso salud enfermedad, aportando fundamentos al enfoque intercultural.
6. La filosofía del Buen Vivir está en la base de la política de salud ecuatoriana, y aporta a la formación de la competencia ética en el TSE un posicionamiento ético de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y ambiental propia de la sociedad ecuatoriana sustentada en el conocimiento, el diálogo intercultural y el respeto a los derechos de las personas y de la naturaleza para el desempeño profesional.
7. La formación de la competencia ética en el TSE sobre la base de la bioética como ética global o profunda, la bioética médica y la filosofía del Buen Vivir se desarrolla sobre la base del enfoque intercultural integral ecológico de la formación ética del TSE, resultado de la integración de los conocimientos y saberes de estos sistemas de ideas y de la contextualización de la atención a la diversidad desde la actividad pedagógica y el principio de interculturalidad característicos del sistema de salud ecuatoriano.
8. Devienen conceptos esenciales o básicos de la concepción que se propone: formación ética del TSE, formación de la competencia ética en el TSE (a partir de considerar las dimensiones curriculares y

extracurricular) competencia ética del TSE, desempeño profesional ético del TSE y enfoque integral, intercultural y ecológico de la formación ética del TSE.

La formación ética del TSE constituye una dimensión de la formación de este tipo de profesional; es el proceso y resultado de la apropiación por los estudiantes de las normas, principios y sistema de valores que regulan la conducta profesional, la misma propende a lograr la aprehensión del sistema de valores propios de la profesión de enfermería- sobre la base de la aprehensión del sistema de valores de la sociedad- garantizando su asunción como reguladores de la conducta profesional que permita un desempeño concordante con las normas éticas de la sociedad y el sistema de salud ecuatorianos

Constituyen aspectos esenciales y necesarios en la formación ética del TSE el logro de:

1. La elaboración de un proyecto de vida concreto y realizable en que el que el proyecto profesional tenga un lugar fundamental, a partir de lograr una relación armónica entre los ideales y metas personales y los profesionales; y el sistema de valores socialmente instituidos, profesionales y la jerarquía de valores individual.
2. El desarrollo de una educación orientada hacia el aprendizaje ético sistemático concebido como un proceso que facilita el aprendizaje de contenidos teóricos, habilidades técnicas y valores que permitan la conformación de una “personalidad ética”, lo que implica desarrollarse plenamente como ser humano, poder descubrir y asumir el propio sentido de la vida y al mismo tiempo desarrollar al máximo todas sus potencialidades de crecimiento en forma armónica y ponderada, con énfasis en el crecimiento profesional.

La formación ética del TSE en los institutos tecnológicos ecuatorianos se desarrolla desde la formación basada en competencias, por lo que la formación de la competencia ética del TSE se define como el proceso y el resultado que permite la apropiación de los conocimientos, habilidades y valores

profesionales que se integran en la dicha competencia y que da cuenta de un desempeño profesional exitoso desde el punto de vista ético.

Para el análisis de la competencia ética del TSE se parte de la comprensión del lugar que ocupa dentro del sistema de competencias del TSE sobre la base de la definición de las competencias que conforman dicho sistema: administrativa, comunicativa e investigativa (genéricas), la técnica asistencial, la promoción de la salud y prevención de enfermedades en la comunidad y la ética profesional (específicas) por cuanto se relacionan específicamente con el ejercicio de la profesión. Se tienen en cuenta además los problemas profesionales, el objeto de la profesión y los objetivos de la formación.

La competencia ética del TSE es una competencia específica sustentada en la competencia ética que se adquiere durante todo el proceso de formación escolarizado o no, por el que ha transitado el estudiante que ingresa a la carrera.

Es una competencia específica, ya que responde al perfil del profesional del TSE que se relaciona con aspectos vinculados con su desempeño profesional que no son transferibles a otros contextos laborales, debido a que tienen que ver con la ética de la vida, con el comportamiento respecto a los procesos de salud y enfermedad y con problemas profesionales específicos ; en vínculo estrecho con la profesión del técnico en enfermería que le permite desempeñarse en concordancia con la ética profesional y solucionar los dilemas éticos que se le presentan durante el ejercicio de la profesión los cuales tiene características sui géneris.

La competencia ética no incluye sólo el conocimiento de lo ético, ni aún su formulación, expresión o valoración, es su práctica a través del ejercicio de las virtudes que sólo se logra con el saber hacer, la laboriosidad, la responsabilidad, el orden, la confianza, la disciplina, la prevención de enfermedades y

la promoción de salud, las cuales constituyen ventajas competitivas en la medida que se apliquen desde lo formativo y en el desempeño del TSE.

La *calidad y calidez* facilita un cuidado por el TSE que apela a diversos procesos: reflexión, creencias y valores, análisis crítico, conocimientos, juicio clínico, organización de recursos entre otros. La calidez se asocia a algo entrañable, humano en medio de la vulnerabilidad y la calidad impregna cuidados de ternura, de cordialidad, de algo afectuoso donde los procesos que se realizan emergen de la bondad de unos y llegan a la necesidad de otros.

Por lo que, brindar atención con *calidad y calidez* en el TSE depende de los conocimientos y habilidades, así como de los valores que regulan su actuación profesional que desarrolla desde lo curricular. En tal sentido, debe desarrollar amor hacia la profesión, responsabilidad, humanismo, solidaridad y honestidad constituyen valores esenciales, reguladores de la actuación para ser un profesional competente.

La competencia ética del TSE se conforma a partir del análisis teórico e histórico realizado con la intención de resolver insuficiencias encontradas y determinadas desde:

Análisis de las concepciones de diferentes instituciones de Latinoamérica que forman este tipo de profesional de Chile y Colombia.

Estudio de la concepción de la formación del TSE en el ITB a partir del análisis de los syllabus y del documento donde se definen los aspectos generales de la carrera.

Estudio de los documentos normativos de la salud pública ecuatoriana (Ley Orgánica de salud, MAIS)

Código de ética del TSE (2012)

Ley de ejercicio profesional de las enfermeras y enfermeros del Ecuador

La competencia ética del Técnico Superior en Enfermería, la que se define a partir del lograr que el TSE:

Brinde consciente y responsablemente asistencia especializada de calidad a los usuarios a su cargo, desempeñándose en concordancia con la ética profesional, y estableciendo relaciones con superiores, usuarios, familiares y comunitarios caracterizadas por la calidez, da solución a los dilemas éticos que se le presentan durante el ejercicio de la profesión de manera independiente sobre la base del razonamiento moral sustentado en el humanismo y una concepción intercultural y ecológica de la salud y los servicios de salud.

Los *elementos que la conforman* se erigen en guía para el proceso formativo de la competencia ética del TSE, ellos son:

Ejerce sus funciones profesionales conforme al sistema de valores profesionales, brindando a los usuarios una atención con calidad y calidez, bajo la orientación y supervisión del licenciado/a en enfermería.

Demuestra respeto por la diversidad, tratando con dignidad y sin discriminación a *niños/as*, mujeres y hombres de distintos orígenes, *ideologías,* niveles socio económicos, etnias y culturas desarrollando una práctica profesional intercultural

Establece relaciones profesionales con superiores y el resto del equipo de salud basadas en el respeto a las jerarquías profesionales la colaboración y la comunicación profesional.

Establece relaciones profesionales con usuarios, familiares y comunitarios, basadas en el respeto y la empatía, y caracterizadas por la calidez.

Resuelve con independencia sensibilidad, humanismo y capacidad de razonamiento moral los dilemas éticos que se le presentan durante el ejercicio de sus funciones profesionales desde una concepción integral, holística de la salud, y un enfoque intercultural, integral y ecológico.

Cumple los principios éticos para la intervención en la familia y la comunidad durante las acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades.

Cumple con las normas establecidas con respecto a la presencia personal de los profesionales de la salud

Ejerce sus funciones profesionales conforme al sistema de valores profesionales, brindando a los usuarios una atención con calidad y calidez, bajo la orientación y supervisión del licenciado/a en enfermería.

Esto exige el conocimiento, dominio e implementación de la política sanitaria de la República de Ecuador y del código de ética de la profesión y la incorporación a la jerarquía de valores del TSE del sistema de valores socialmente instituido y su expresión concreta en la actividad profesional que desarrolla.

Se connota el humanismo como el valor central del sistema de valores profesionales del TSE, al cual se incorporan además el respeto, la solidaridad, la responsabilidad.

El humanismo se define como el amor y preocupación por los seres humanos, especialmente por los usuarios de los servicios de salud al desarrollar su actividad profesional y se expresa en una atención sanitaria de calidad y con calidez, sin discriminación de ningún ser humano y por ninguna causa, en la que se pongan de manifiesto la compasión y el altruismo. En este caso se trata de un humanismo que reconoce además las relaciones y la importancia de las relaciones armónicas con la naturaleza como condición necesaria para garantizar la salud y el bienestar humano y como manifestación del respeto a la naturaleza.

El respeto implica el reconocimiento al otro y a sus derechos y supone el cumplimiento estricto de los deberes profesionales que garantizan una adecuada atención de salud, tiene en cuenta el respeto a la diversidad cultural, al ser humano y a la naturaleza y su concreción en el respeto a la diversidad de posiciones con respecto a los procesos de salud y enfermedad y a los cuidados de la salud.

La solidaridad supone una actitud empática sobre todo para con el dolor ajeno y el compromiso con el

logro del bienestar de los usuarios a su cargo, implica además la colaboración con el resto de los miembros del equipo de salud sobre la base del respeto, la consideración a los demás, la justicia y la equidad en el trato con superiores, miembros del equipo, usuarios, familiares y comunitarios.

La responsabilidad implica, la disciplina en el cumplimiento de las tareas profesionales, el compromiso con el perfeccionamiento continuo de su actividad profesional, la calidad, calidez y rigor en los servicios que se ofertan y la administración adecuada de los recursos de que se dispone para la actividad profesional.

El Técnico Superior en Enfermería deberá ofrecer información adecuada al usuario, desarrollar labor de educación sanitaria para modificar ideas, hábitos, conductas dañinas a la salud y a las relaciones con la naturaleza instrumentando acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades para sí en función de las exigencias del perfil del profesional.

Demuestra respeto por la diversidad, tratando con dignidad y sin discriminación a niños/as, mujeres y hombres de distintos orígenes, ideologías, niveles socio económicos, etnias y culturas desarrollando una práctica profesional intercultural.

A partir de la multiculturalidad que caracteriza a la sociedad ecuatoriana y de las manifestaciones peculiares que esta adquiere en los servicios de salud, el TSE debe en primer lugar conocer las diversas expresiones de la multiculturalidad fundamentalmente en lo que se refiere a las concepciones sobre la salud y la enfermedad y las prácticas para el cuidado de la salud, según los criterios de los diferentes proveedores de la misma, planificando y desarrollando su actividad profesional teniendo en cuenta no solo el respeto a dichas concepciones y prácticas sino además el aprovechamiento de las mismas para el desarrollo de su actividad profesional desde la complementariedad, dando respuesta a las necesidades específicas de los usuarios, familiares y comunitarios sobre la base de sus

características culturales. Esto exige la observancia del humanismo como valor central en el sistema de valores profesionales.

Establece relaciones profesionales con superiores y el resto del equipo de salud basadas en el respeto a las jerarquías profesionales la colaboración y la comunicación profesional.

Al TSE se les presentan problemas éticos que para dar solución, debe primero entender la esencia del conflicto que deberá resolver de diferentes maneras, ya sea acudiendo a la autoridad superior, dígase licenciado en enfermería o médico de un documento oficial, o mediante un diálogo entre la profesión y el usuario del personal de salud, donde deberá mostrar acato, con responsabilidad profesional ya que cualquier decisión de cuidados tiene como objetivo preservar, potenciar y defender el bien de la persona tratada, asimilándola como responsabilidades compartidas de todos los profesionales, que requieren consideración de todos los que intervienen en el proceso de atención, pero dependiendo del rango profesional sobre la base del respeto y ayuda o colaboración y de una comunicación eminentemente profesional .

Establece relaciones profesionales con usuarios, familiares y comunitarios, basadas en el respeto y la empatía, y caracterizadas por la calidez.

En el desarrollo de su actividad profesional el TSE deberá establecer relaciones con usuarios, familiares y comunitarios, sustentadas en el respeto a las peculiaridades de los mismos, especialmente a las culturales, colocándose en su lugar de manera empática, utilizando un lenguaje respetuoso y cálido para comunicarse, adecuado a las posibilidades de comprensión de cada uno, respetuosos de creencias y tradiciones, fundamentalmente las relacionadas con las concepciones sobre la salud y la enfermedad y las prácticas para el cuidado de la salud y mostrando interés por los problemas y preocupaciones del usuario y sus familiares ofreciéndole apoyo oportuno y eficaz.

El TSE debe saber escuchar al paciente, ponerse en el lugar de la persona cuidada y favorecer la autonomía entendida esta como la capacidad de autogobierno, de decidir en libertad como un derecho personal y social, de buscar el respeto interno y externo, respetar la voluntad de ser uno mismo responsable de su decisión. El desarrollo de la autonomía de los pacientes favorece la relación enfermero-paciente, sobre la base del reconocimiento y respeto de la dignidad humana.

La sensibilidad es significativa en personas que tienen la responsabilidad de cuidar a otras y se asume como la capacidad del TSE de poder sentir y/o percibir, sentimientos humanitarios, capacidad de captar los aspectos más bellos y delicados de las cosas.

Resuelve con independencia sensibilidad, humanismo y capacidad de razonamiento moral los dilemas éticos que se le presentan durante el ejercicio de sus funciones profesionales desde una concepción integral, holística de la salud, y un enfoque intercultural, integral y ecológico.

El TSE debe caracterizarse por cumplir con independencia los tratamientos médicos orientados, y estar capacitado para dar solución adecuada a los dilemas éticos que se le presentan durante el ejercicio de sus funciones profesionales con la supervisión y apoyo del licenciado en enfermería.

Un dilema ético profesional se define como una situación de duda, de debate entre dos o más alternativas de solución a situaciones conflictivas que se presentan en el ejercicio de la profesión, un conflicto entre dos imperativos éticos que se le presenta al TSE en situaciones podrían traer repercusiones negativas y/o positivas y donde los valores entran en un conflicto.

El razonamiento moral constituye el juicio de valor que se hace ante situaciones en la que se debe tomar una determinada elección, que permite considerar el valor de las cosas y determinar lo que es correcto o no.

Los dilemas éticos que se derivan de prácticas médicas son diversos, y pueden ser entre los propios miembros del equipo de trabajo, o entre estos y los familiares de los pacientes. En ese ambiente, el

trabajo del TSE, no solo articula con diversos medios de trabajo del equipo de salud también debe prestar atención directa al usuario y sus familiares y desarrollar la profesión basada en el sentido y valor de las normas éticas.

En el acto de cuidado, al TSE se les presentan conflictos, independientemente del diagnóstico o del contexto clínico, a esto se añade estar apto a cuidar a todos los enfermos, incluyendo los pacientes internados en el servicio de terapia intensiva; al analizar el conflicto para buscar posibles soluciones, no puede perderse de vista las causas que lo generan.

Se significa que, debido a las características tecnológicas y científicas de centros hospitalarios, es necesario priorizar procedimientos técnicos de alta complejidad, fundamentales para mantener la vida del ser humano, ello requiere de una ética.

En la solución de dilemas éticos se revela el compromiso del TSE con su profesión. Dada la riqueza y amplitud de la práctica profesional del TSE no es posible listar los dilemas que puede enfrentar en el ejercicio de su profesión, aunque de manera general pueden modelarse los posibles dilemas.

A partir de los sujetos que intervienen:

Entre TSE, licenciado en enfermería y médicos (acatamiento o no de la subordinación a la autoridad profesional)

Seguir lo orientado por el superior teniendo la certeza de que no es adecuado y que puede poner en peligro al usuario del servicio de salud.

Seguir lo orientado cuando sus creencias le dicen otra cosa. Tomar una decisión importante solo o no.

Entre el TSE y el usuario (Por creencias del último que se oponen al tratamiento)

Entre el TSE y otros proveedores de salud en las comunidades (Por concepciones diferentes con respecto al cuidado de la salud)

Cumple los principios éticos para la intervención en la familia y la comunidad durante las acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades.

La intervención familiar y comunitaria del TSE requiere el cumplimiento de principios éticos, (compromiso moral de preservar la vida, promover salud, prevenir enfermedades, aliviar sufrimiento), con el objetivo de orientar a la familia, ayudarle frente a un problema difícil que posea como lo es la adicción, y así devolverles la dignidad y la esperanza de que pueden mejorar y recuperarse. En este sentido, resulta pertinente y de obligatoriedad, contribuir al desarrollo de su profesión, de acuerdo con el código de ética teniendo en cuenta las condiciones que determinan los fenómenos de salud y enfermedad en cada comunidad y región, utilizando métodos para indagar críticamente la realidad respetuosa de la diversidad cultural

El respeto a los principios éticos por el TSE para realizar con éxito el trabajo con la familia y la comunidad, supone de una explicación inicial del tipo de actividad que se va a realizar, ser confiable de la información manejada, no transgredir a la ética de la familia, el respeto a sus ideas, creencias, cultos y prácticas religiosas, hacerlos partícipes de la atención, asumir una posición autocrítica como profesional y buscar ayuda o asesoría en caso necesario.

La labor de prevención de enfermedades y promoción de salud del TSE posee una intencionalidad educativa por lo que implica educar en la población un comportamiento que requiere formar nuevas conductas, actitudes, fomentar creencias favorables mediante diferentes acciones como campañas, trabajo en grupo, entre otras, que favorezcan la salud y definan cómo esos comportamientos se han de establecer, en esta actividad con frecuencia el TSE se enfrenta a dilemas morales.

Cumple con las normas establecidas con respecto a la presencia personal de los profesionales de la salud.

La presencia personal del TSE y el cumplimiento de las normas de higiene establecidas para este tipo de profesional constituye además de una garantía de la calidad de los servicios que brinda una expresión de respeto hacia miembros del equipo de salud, usuarios y familiares, de ahí la necesidad e importancia de mantener una observancia estricta de las normas para el aseo personal y uso del uniforme establecidos por el sistema de salud y la unidad asistencial en que se desempeña.

La formación de la competencia ética en el TSE solo es observable en el desempeño de ahí que sea necesario definir el desempeño profesional ético del TSE como la expresión de la capacidad para actuar en situaciones profesionales sobre la base de los conocimientos habilidades y valores adquiridos y dar solución a problemas profesionales actuales y futuros relacionados con el cumplimiento de sus deberes en el cuidado de la salud de los usuarios de los servicios de salud, la relación con miembros del equipo de salud, familiares y comunitarios; la promoción de salud y la prevención de enfermedades sobre la base del sistema de valores sociales en general y profesionales en particular.

El proceso de formación de la competencia ética en el TSE se desarrolla en dos dimensiones: curricular y extracurricular.

La dimensión curricular se expresa y concreta en el diseño y la implementación del currículo de la carrera TSE, su contenido se evidencia en el contenido del proceso de enseñanza aprendizaje de todas asignaturas del currículo, en esta dimensión devienen vías, métodos y medios de formación de la competencia ética las formas de organización de la docencia y los métodos y medios de enseñanza. La educación en valores desde la clase y el tratamiento al sistema de valores profesionales como parte del contenido de las asignaturas desempeña un papel fundamental. Incluye lo académico, lo investigativo y la práctica pre profesional concebidos en la malla curricular, y aporta los conocimientos, habilidades y valores que como parte del contenido de la enseñanza que se integran en la competencia ética.

La dimensión extracurricular incluye actividades no contempladas en la malla curricular pero que contribuyen al logro de los objetivos de la formación, estas actividades se orientan y organizan desde la institución escolar en vínculo con instituciones y organizaciones sociales, en este caso hospitales y otros centros de atención de la salud. Incluye investigaciones, proyectos, actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades entre otras. Su contexto de desarrollo puede ser la institución educativa, las instituciones de salud o las comunidades.

Desde lo pedagógico, existe relación entre ambas dimensiones partiendo de que, tanto lo curricular como lo extracurricular aportan a la formación de la competencia ética en el TSE, desde sus necesidades profesionales y potencialidades.

Se trata de contribuir a formar la competencia ética en el TSE desde y a través del proceso formativo, al relacionar la lógica del profesional con las peculiaridades más apremiantes que demanda el mundo y la sociedad ecuatoriana hoy, de forma tal que garanticen las cualidades, valores, conocimientos y habilidades que deben estar presente en un profesional de dicha especialidad y que contribuyan al modelo del profesional.

Desde lo curricular el docente prepara el proceso de formación de la competencia ética en el TSE a partir de los conocimientos entendidos como todos los saberes necesarios que el TSE adquiere en la formación inicial, y les permite desarrollar destrezas, habilidades técnicas, actitudes y valores que le serán demandados por la sociedad.

Constituyen contenidos propios de la profesión que deben ser abordados: Contenidos propios del ejercicio profesional desde el punto de vista operativo. Contenidos de la Bioética como Ética Global o profunda

Contenidos de la Bioética médica Contenidos de la filosofía del Buen Vivir

Documentos del sistema de salud ecuatoriano (Ley Orgánica de salud, MAIS, Código deontológico del

enfermero)

Para contribuir a la formación teórica de este especialista TSE se debe conocer los contenidos declarados anteriormente; la interrelación entre estos constituye puntos de partida en la formación de la competencia ética del TSE ya que le capacita para enfrentar con profesionalidad en la práctica de la actividad que realizan en diversos contextos de aplicación de cuidados de salud.

Todo esto se corresponde con la formación de una cultura de la profesión y los valores profesionales en que se concreta la ética de este profesional, contextualizada al Ecuador, y guardan relación con el desempeño del TSE.

Esto se produce a lo largo de la formación inicial del TSE bajo la dirección del docente y se concreta en el marco de la actividad laboral profesional, a partir de las propias contradicciones que se van generando en la práctica.

Se requiere de una formación a partir de los contenidos citados, asociados al desempeño del TSE a fin de poder explicar, predecir y proyectar su actuación y extender la actividad trasformadora y creadora en los diversos contextos donde se insertan, lo que condiciona el desarrollo de habilidades. Las *habilidades* (técnico-profesionales y para las relaciones interpersonales) - son identificadas como las destrezas que posee para desarrollar la profesión y se adquieren mediante el aprendizaje.

El desarrollo de las habilidades técnico-profesionales, deberá estar asociado al vínculo del conocimiento con la práctica para realizar actividades, apoyados en métodos -medios -procedimientos disímiles- y debe basarse en el apoyo tanto de los principios éticos, como de lo científico, las cuales permitirán orientar sobre la práctica con legitimidad y dominio sobre la profesión en el TSE según se define en el pensum de estudios, la presencia y enfoque al tratamiento de los contenidos éticos presentes en los syllabus, así como los contextos donde se realizan las actividades curriculares, extracurriculares y comunitarias

Las habilidades técnico-profesionales son las que se destacan en el campo de la profesión que ejercen, en tal sentido, se deben desarrollar habilidades técnico-profesionales en el TSE-entendida como la destreza alcanzada en el ejercicio de la profesión y la solución de problemas de su especialidad- para lo cual cuenta, desde lo académico, con el desarrollo de una formación de excelencia; por esta razón cada uno del personal del equipo de salud debe tener una preparación académica dirigida, especializada para poder brindar una atención de calidad hacia los usuarios.

Para el desarrollo de las habilidades técnico-profesionales el TSE se requiere de autonomía, que implica, tener un buen control sobre cada una de las funciones que realiza, es decir, responsabilidad e independencia en cada uno de sus actos, consistente en elaborar juicios para poder desenvolverse aplicando el conocimiento, realizar actividades, trabajos con los equipos tanto inter como multidisciplinario, ayudar y brindar servicio hacia quien lo necesite; tener una comunicación tanto afectiva como cordial con cada uno de los usuarios, como también de los demás colegas de trabajo; reflejar hacia los demás el desarrollo de actividades bajo confianza como de seguridad; desarrollar estudios enfocados en la proyección de la sociedad, interrelacionar en actividades que permitan el crecimiento de la profesión. Que para el TSE son necesarias:

Solución de dilemas éticos profesionales

Labor de prevención de enfermedades y promoción de salud

Labor de educación social

Investigación de problemas relacionados con el ejercicio profesional.

Trabajo comunitario de salud

La labor de educación social del TSE es entendida como las actividades de transformación social de este en las comunidades, deberá ser dinámica y viva, su desarrollo se convierte en competencia ética de toda actuación concreta que los técnicos deban contener. Por tanto, el componente ético está

presente en toda práctica profesional como proceso individual como componente permanentemente, presente en el desarrollo de desempeño.

La *investigación*, de problemas relacionados con el ejercicio profesional se constituye en otro elemento en el desarrollo de la competencia ética debe formarse en cada uno de los niveles de desarrollo por los que atraviesa el proceso de formación del TSE. En tal sentido, se debe aprender y aprender a investigar, investigando, ya que permitirá un proceso de indagación, creatividad y espíritu crítico.

Es importante conocer las técnicas de investigación y seleccionar problemas de la profesión o de los servicios de su área de acción para estudiarlos, analizarlos, y contribuir a resolverlos. La confidencialidad de la información que se obtenga en el proceso investigativo y confianza es de gran importancia y requieren de un proceso de apropiación del contenido ético que tiene lugar en los diferentes escenarios del TSE

El sistema de valores (humanos en general y de la profesión en particular)- se manifiesta como orientadores de la conducta y de la actividad profesional del TSE. Se definen el humanismo, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad.

El proceso de formación del TSE se encarga de formar profesionales en un sistema de valores que va construyendo la ética de ese profesional, el cual no solo tendrá que asumir y hacerlos en su práctica profesional, sino en toda acción cotidiana, téngase en cuenta que la práctica va más allá del quehacer diario en servicio. De igual forma, cuando el TSE investiga, parte de valores como la lealtad, compromiso, responsabilidad, sustentado en una base humanista.

El respeto a la diversidad tiene un lugar esencial en el sistema de valores en el TSE, al poseer variedad de pacientes a las que cuidar de diversos lugares y con distintas características y culturas diferentes, aun cuando se trate del propio contexto ecuatoriano. De ahí la necesidad de conocer al paciente contextualizándolo en su propia cultura, referente esencial dentro del contexto ecuatoriano.

Se reconoce la diversidad en el sentido sociocultural a partir de la coexistencia, convivencia e interacción entre diversas culturas, tanto en centros asistenciales, como en la atención a las diversas familias y comunidades, lo que demanda de una atención diferenciada, que desde lo curricular trasciende la unidad de lo cognitivo y prepara las condiciones para el sentido de actuación en los diferentes contextos donde se insertar el TSE.

Esto significa realizar la prevención de la enfermedad y promoción de salud, siguiendo el control, tratamiento y la rehabilitación del paciente de manera oportuna, profesional, confiable para los usuarios de los servicios de salud.

Ello es posible si el TSE es capaz de ofrecer cuidados en relación a las necesidades de los usuarios, con independencia de las características personales, lo que permite interactuar con este y otros profesionales. A diferencia de otros profesionales del equipo de salud, el TSE proporciona en los cuidados, la comunicación que la conduzca a hacer de su práctica acciones éticas y no solo destreza técnica propia de la profesión. Está presente al condescender las diferencias personales, siendo capaz de saber diferenciar la tolerancia de la debilidad y respeto por sus conocimientos y honestidad al utilizar procedimientos propios de su profesión y/o saber ofrecer servicios o ayuda a las personas, de forma tal que de seguridad a las personas.

La solidaridad, se entiende como la disposición de ayuda mutua entre el TSE, el usuario y la comunidad, y otros profesionales del equipo de salud, permitiendo que se eleve sus niveles de conciencia, así como el fortalecimiento de las relaciones de sociabilidad contribuyendo al restablecimiento de la salud. Caracteriza la esencia humana del TSE y se identifica al compartir intereses, derechos, deberes y obligaciones. Por eso se basa en el derecho humano de unión y asociación, en el reconocimiento de sus raíces, los medios y los fines comunes de los seres humanos entre sí.

Desde el trabajo extracurricular, el *trabajo comunitario* es entendido como aquel que realiza el TSE en

la comunidad para promover, mantener y restaurar la salud de los comunitarios o prevenir enfermedades que puede ser mediante cuidados directos e indirectos.

En este, el TSE se constituye en agente de cambio al propiciar el desarrollo de una promoción y labor preventiva mediante un comportamiento ético, para lo cual debe tratar cortésmente a la población y al público en general, saber redactar informes, analizar y diagnosticar situaciones complejas e instruir a otros en el área de educación para la salud. Además de revelar el desarrollo de destrezas como: manejo de equipos médicos y manejo de computador, entre otros.

El trabajo comunitario donde interactúa el TSE, debe basarse la concienciación y conocimiento acerca de la necesidad de cuidado en las comunidades, con la intención de actuar correctamente en acciones basadas en conocimientos y valores éticos morales.

En consecuencia, la integración de los conocimientos, habilidades y el sistema de valores del TSE favorecerá los esfuerzos de la profesión para promover su práctica materializada en la relación de lo instructivo, lo educativo y el reconocimiento de los principios de la Bioética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la bioética médica.

Para lograr lo expresado anteriormente hay que trabajar por un proceso formativo en correspondencia con la concepción pedagógica. Se debe revelar el significado del docente para el proceso de formación del TSE particularmente la formación de la competencia ética, de ahí que la formación de la competencia ética en el TSE, es el proceso de apropiación durante la formación profesional de los conocimientos, habilidades y valores que le permitan una vez egresado mantener un comportamiento ético y responsable, solidario y respetuoso de la dignidad humana en las relaciones con superiores, el resto del equipo médico, usuarios, familiares y comunitarios en los diferentes contextos de su actuación profesional.

La definición anterior permite declarar como rasgos fundamentales de este proceso:

La apropiación del contenido ético, adquiridos en el proceso formativo y a partir del cual deberá lograr su autodesarrollo.

La relación entre lo instructivo y lo educativo, en tanto los conocimientos que el TSE alcanza en su formación, al estar incluidos en el proceso pedagógico se relacionan con las influencias que lo integran y son de naturaleza educativa; de ahí la indispensable unidad dialéctica entre la instrucción y la educación a partir de reconocer el aporte de la Bioética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la bioética médica en unidad.

La formación de la competencia ética del Técnico Superior en Enfermería, debe orientarse al desarrollo de técnicos competentes y de excelencia humana, en el desempeño de la profesión, su forma de ser en la práctica cotidiana, a través del respeto, la solidaridad y la justicia, la tolerancia y la equidad, capaz de reflexionar críticamente y argumentativamente sobre su propio proceso de formación moral. Como resultado de la formación de la competencia ética del Técnico Superior en Enfermería se manifiestan las potencialidades del proceso de formación y apropiación de la competencia la que exige armonizar, de manera dialéctica, las ideas de la bioética como ética global o profunda, a partir de la cual le imprime lo interdisciplinario e intercultural al considerar el actual contexto mundial, la bioética médica, que le imprime lo humano, lo responsable para ofrecer servicios de calidad y la filosofía del Buen Vivir con el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y ambiental del Ecuador teniendo como premisa el conocimiento, el diálogo intercultural y el respeto para ejercer un desempeño profesional de excelencia. Cada uno de estos postulados, aportan elementos imprescindibles a la formación de la competencia ética del TSE, y trae como cualidad resultante: una concepción integral de la salud y de la atención de salud, a partir de considerar la necesaria comprensión de los dilemas de carácter ético que en el contexto del mundo de hoy y específicamente de la sociedad ecuatoriana se presentan ante este profesional durante su desempeño, preparándolo para su solución también desde un *enfoque*

intercultural integral y ecológico de la formación ética del TSE.

Integral: porque incorpora la dimensión ecológica a la concepción de la salud, al reconocer que estar saludable es también vivir en armonía con la naturaleza.

Intercultural: porque reconoce las potencialidades y necesidad de las relaciones respetuosas y enriquecedoras entre la diversidad de proveedores de salud, concepciones sobre la salud y la enfermedad y prácticas sanitarias durante la actividad profesional del TSE.

Ecológico: porque propende al cuidado del medio ambiente como parte de la actividad profesional del TSE sobre la base de una concepción integral e integradora de la salud.

Este enfoque se delimita a partir de una concepción holística de la vida humana como parte de un complejo mayor que amplía el marco de consideración política desde lo social y lo antropocéntrico hacia lo biosocial e implica poder establecer puentes entre las ciencias humanas y naturales para enfrentar los problemas ecológicos del mundo actual, a partir del enfoque interdisciplinar, la integración curricular sobre la base de la formación ética como eje transversal, de ahí que considere formar a los futuros TSE para expresar en su actividad profesional:

La exigencia de juicio y responsabilidad en la relación con los usuarios de los servicios de salud y la naturaleza.

El análisis desde una perspectiva ética de la relación entre la sociedad y la naturaleza, procurando el bienestar de ambas.

El logro de un comportamiento moral respecto a los problemas tanto globales como locales de salud, alimentación, superpoblación, degradación ambiental, supervivencia y mejoramiento del bienestar y la calidad de la vida humana y no humana.

Análisis desde una perspectiva ética de los actos deliberados de intervención directa o indirecta en los procesos biológicos.

Logro de la interrelación dialéctica entre conocimiento(s)-valor(es), Construcción de saber al servicio de la vida, aunque no solo de la vida humana.

Observancia de las consecuencias morales de cualquier acto relacionado con la biología, la moralidad de las decisiones humanas respecto a realidades biológicas humanas o no (deberes, derechos y obligaciones morales).

Consideración de las condiciones que determinan los fenómenos de salud y enfermedad en cada comunidad y región, la utilización de métodos para indagar críticamente la realidad y la comunicación de los resultados positivos o negativos hallados se revelen solo a personal autorizado a conocerlos".

El respeto y aprovechamiento con fines profesionales de las manifestaciones de la diversidad cultural.

Al caracterizar y revelar las relaciones existentes entre estos procesos, la competencia ética del Técnico Superior en Enfermería y elementos de competencia que la condicionan, así como la formación de esta, se compendian dialécticamente en un proceso de formación de una competencia ética avalada a partir de los siguientes postulados teórico-conceptuales:

Aborda los procesos cognitivos e intelectivos asociado a la bioética dentro del proceso de formación del Técnico Superior en Enfermería, como eje vertebrador de la formación humanista de este profesional.

Revelan una dialéctica entre las referencias socioculturales profesionales y la axiología del técnico en enfermería; la primera como diferenciación, y la segunda como integración.

Concibe lo ético como objeto de aprendizaje en el Técnico Superior en Enfermería, a partir de un proceso de sistematización, concretado en el empleo de recursos reflexivos, y bases teórico - metodológicas para la formación de la competencia ética.

Concibe desde los postulados conceptuales y metodológicos de la bioética global y profunda, bioética médica, filosofía del Buen Vivir y de la pedagogía como constructos científicos contextualizadas en la

formación del Técnico Superior en Enfermería.

Conclusiones del capítulo

La concepción pedagógica de formación de la competencia ética del TSE, aporta en el marco teórico para el abordaje de este proceso desde un enfoque intercultural integral y ecológico de la formación ética del este profesional, la misma al sustentarse en los postulados de la bioética como ética global o profunda, la bioética médica y la filosofía del Buen Vivir aporta este enfoque novedoso que tiene en cuenta la dimensión ecológica de la salud y la interculturalidad en el desarrollo de la actividad profesional como respuesta a las necesidades de la sociedad ecuatoriana contemporánea.

Desde el punto de vista práctico al modelar la competencia ética del TSE y los aspectos centrales para su formación deviene una herramienta metodológica para orientar este proceso en los institutos técnicos ecuatorianos en los que se forma este profesional.

CAPITULO III ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA ÉTICA EN EL TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA. CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS

En este capítulo se establece los fundamentos teóricos que sustentan la estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería, pertinencia y aplicación parcial, de igual manera en el mismo aparece la concepción e implementación general de la estrategia pedagógica. Se realiza una valoración de la puesta en práctica contentiva en la unidad de competencia con sus elementos que sustentan la formación de la competencia ética en el proceso de formación inicial del Técnico Superior en Enfermería además los resultados del proceso de corroboración de su factibilidad y pertinencia respectivamente a través de talleres de socialización, encuesta a especialistas, actividades docentes y el empleo de la triangulación múltiple.

3.1-Estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

La estrategia pedagógica es el punto de partida para el despliegue en la práctica de la teorización realizada dirigida al trabajo con el estudiante en formación. La variante asumida permite dar respuesta a los problemas teóricos conceptuales en torno a la formación ética del estudiante en su formación inicial y que se revertirá en su actuación práctica pedagógica.

La estrategia pedagógica como resultado de las investigaciones pedagógicas ha sido ampliamente trabajada y definida en la literatura general y en la pedagogía en particular, aportándose múltiples definiciones entre las que pueden citarse: González, H. y otros, (1996), Castellanos, B. (2002); De

Armas, R. (2003); Rodríguez del Castillo, M y Palacios, A. (2003), Ronda, G y otros., (2005), Sierra, R. (2008), González, E. (2011), entre otros.

De manera general, las definiciones dadas por estos autores apuntan hacia aspectos importantes como: la manera de planificar y dirigir las acciones para alcanzar determinados objetivos a largo, mediano y corto plazo, la adaptación de estas y de los recursos necesarios para lograrlo; el propósito de toda estrategia es vencer dificultades con optimización de tiempo y recursos, lo que permite conocer qué hacer para transformar la acción existente e implica un proceso de planificación que culmina en un plan general con misiones organizativas, metas objetivos básicos a desarrollar en determinados plazos con recursos mínimos y métodos que aseguren el cumplimiento de dichas metas.

Aunque en ellas se encuentran elementos comunes que refuercen su carácter participativo, dinámico, flexible, contextualizado, orientado a un fin previamente establecido, para esta investigación se asume de la investigadora cubana Sierra, (2008); al definir la estrategia pedagógica como " la concepción teórico-práctico de la dirección del proceso pedagógico durante la transformación del estado real al estado deseado, en la formación y desarrollo de la personalidad, de los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la institución escolar". (Sierra, R, 2008, p. 7)

Se identifican el uso de este término aproximadamente en la década de los años 60 del siglo XX coincidiendo con el comienzo del desarrollo de investigaciones dirigidas a describir indicadores relacionados con la calidad de la educación, se utiliza la estrategia como habilidad, destreza, maestría para dirigir algo y alcanzar objetivos deseados, por lo que es propósito de ella *transformar* el objeto investigado, considerando el estado actual y el estado deseado. En este sentido, se coincide con los diversos autores en valorarlas como instrumentos de la actividad cognoscitiva que permiten una forma

de *actuar* en un contexto determinado y suele clasificarse, según su incidencia, en pedagógica, educativa, didáctica, metodológica permitiendo transformar los objetos y situaciones.

Las estrategias pedagógicas, están asociadas a acciones integradas al proceso pedagógico que posibilitan la transformación de sujetos o de objetos y el alcance de los niveles de desarrollo aspirados, debido a que las acciones que se realizan se encuentren vinculadas a este proceso por la vía docente, extra docente y/o extraescolar, lo cual posibilita la transformación de sujetos y objetos mediante las relaciones que se establecen y el desarrollo de estos.

Se tiene como fundamento general la idea que la educación en su función formativa-desarrolladora permite la formación de la competencia ética como uno de sus componentes desarrollado en vínculo con la práctica pedagógica, aspecto que le permite al estudiante en formación desenvolver todas sus potencialidades personológicas integrando las cualidades cognitivas, afectivas y actitudinales.

Un requerimiento esencial de la estrategia es la mirada prospectiva capaz de prever las transformaciones a largo plazo y que ha de ser vista desde los momentos en que estructura su concepción. Se considera de carácter prospectivo a partir de sus implicaciones en el desarrollo de capacidades transformadoras en el en el orden ético.

Esta estrategia pedagógica se caracteriza por su:

Aplicabilidad: Es posible de ser aplicada, adaptándola a las condiciones concretas de cada nivel de formación de la carrera.

Flexibilidad: Es susceptible cambios, por su capacidad de rediseño y argumentación, en correspondencia con los resultados del diagnóstico, las metas y las necesidades del estudiante en formación.

Carácter Participativo: Da la posibilidad de otras variantes para la formación de la competencia ética y la capacidad para insertarse esta estrategia pedagógica en las asignaturas de forma activa con

talleres, de forma en que todos participen en enriquecer la formación ética del estudiante en formación inicial.

Carácter contextualizado: Los contenidos de los syllabus y las acciones planificadas para desarrollar en las prácticas pre-profesionales de los estudiantes, serán adecuadas a las características de los diferentes niveles formativos, para contribuir al logro de la vinculación de lo afectivo-cognitivo, así como a la comunidad de salud del centro que se encuentra realizando su práctica pre-profesional.

Carácter de sistema: La concepción de la estrategia pedagógica parte de la interrelación que existe entre sus componentes: objetivo general y particulares, etapas y acciones.

El carácter dialéctico, a partir de los constantes cambios y adecuaciones.

Su irrepetibilidad, a partir de su aplicabilidad en el momento y contexto específico, condición que no contradice que una o varias de sus acciones puedan repetirse en otros contextos.

Su aporte eminentemente práctico, lo cual no niega la existencia de aportes teóricos dentro de su conformación.

La estrategia que se propone es pedagógica, se caracteriza por la estrecha vinculación entre los diferentes elementos que forman parte de la unidad de competencia establecida en el capítulo dos de la tesis, reforzando el carácter sistémico. Estas etapas contribuyen por su esencia a la comunicación entre los docentes implicados en su puesta en práctica, en una actividad de carácter orientadora y desarrolladora, lo que está dado por el hecho de tener presente las particularidades de los estudiantes de la carrera Técnico Superior en Enfermería.

Se define como una estrategia pedagógica, a partir de que se estructura desde lo formativo como eje central integrador que permite, de forma coordinada, llevar el encargo social de forma planificada mediante el establecimiento de pasos y vías a seguir a fin de poder alcanzar el crecimiento de las

partes involucradas para que respondan a las necesidades tanto individuales como a las exigencias sociales.

La intencionalidad pedagógica de la estrategia se concreta en núcleos estructurados y delimitados como: La ética y Bioética; la Bioética y enfermería; y la problemática Bioética.

La propuesta condiciona el análisis del contexto educativo, las fortalezas y debilidades con que se cuenta, la realidad de la práctica pedagógica, las influencias y los factores que desde ellas redimensionan el proceso formativo.

La *Ética y Bioética* considera los valores, principios y moral; el valor "vida humana digna"; precisiones conceptuales y antecedentes históricos, así como valores bioéticos. A partir de los cuales se consideran como mecanismos en su concreción.

1. Enfoque conceptual de los términos usados para desarrollar la ética profesional.
2. El paciente tanto sano como enfermo necesita desarrollar una vida y muerte donde se respete el Buen Vivir
3. El Técnico Superior en Enfermería debe de aclarar conceptos y conocer la evolución de lo ético, moral y valores que luego podrán servir en beneficio de su paciente.
4. Considerar el contenido de la bioética a partir de que esta enseña al ser humano a vivir y relacionarse con su entorno.

La *Bioética y enfermería* considera: la bioética en el cuidado de los pacientes; los valores profesionales aplicados a confiabilidad paciente-enfermero, así como aspectos éticos y deontológicos.

A partir de los cuales se consideran como mecanismos en su concreción.

1. Apropiación del término para aplicar los cuidados, procedimientos y medicamento dentro de los parámetros del respeto a la vida para que esta sea con calidad hasta la muerte o recuperación de la salud.

1. Desarrollar el hermetismo, si el paciente así lo requiere, siempre y cuando sea para el bienestar de su salud para que su relación paciente-Técnico Superior en Enfermería se fortalezca.
2. Reconocer los términos de la deontología de esta profesión que realza su calidad.

Sus desempeños están en: aplicar al paciente los cuidados desde el punto de vista ético; desarrollar y aplicar la confiabilidad con sus pacientes con criterio científico y valores profesionales y dominar el término de la ética y la deontología.

La *problemática Bioética* considera: responsabilidad profesional; consentimiento informado; secreto profesional, así como las historias clínicas manejadas con ética tratándolo como documento médico legal. A partir de los cuales se consideran como mecanismos en su concreción.

1. Aprender a admitir cuando por algún motivo no realiza sus actividades o no aplica correctamente procedimientos
2. Manejar con normalidad la información, guiando al paciente de manera natural y conocimiento a que decida sobre la decisión que tomara el paciente.
3. Todo lo que conozca de la enfermedad si el superior el pide que no lo comunique lo hará con facilidad y no quebrantara lo indicado por su superior
4. Aprender a manejar con seriedad y de manera científica, guardando la ética, sin olvidar que es un documento legal en dos vías, tanto para el paciente como para el médico o institución.

Sus desempeños están en: aprender acertadamente a ejercitar todos los procedimientos con responsabilidad; dominar habilidades de comunicación de forma profesional y le indica la pro y el control de medicamentos o procedimiento para obtener el consentimiento de parte del paciente, pero luego de informarle; identificar claramente y valora que todo lo que conoce de su paciente es entre el médico, Lcda. en enfermería y el técnico, respetando el secreto de profesional de su patología, así como apropiarse de habilidades de comunicación escrita desarrolladas en el llenado de la Historia

Clínica de manera eficiente y completa con de valores éticos inherentes a la parte humana de la profesión para poder documentar todo lo inherente al paciente, enfermedad y evolución.

En el diseño de la estrategia pedagógica se destacan tres etapas principales contentivas de acciones; es importante destacar que, aunque la evaluación constituye una etapa específica, en cada una se deberá ir evaluando y controlando su correcta aplicación para perfeccionar las acciones que permitan alcanzar los resultados deseados.

La estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería se define la *proyección anticipada en el contexto socioeducativo que integra las influencias de la escuela, la familia y la sociedad para organizar el logro de la competencia ética en la formación del TSE, en aras de un mejor desempeño profesional en su contexto.*

Se declara como Objetivo General de la estrategia: Contribuir a la formación de la competencia ética en el Técnico Superior de Enfermería para un mejor desempeño profesional en los diversos contextos donde este se inserta.

En su concepción se estructura en tres etapas:

Primera etapa: Sensibilización y Diagnóstico. Segunda etapa: Creación y transformación. Tercera etapa: Evaluación.

Etapa 1: Sensibilización y Diagnóstico. Es una etapa de sensibilización y diagnóstico a estudiantes y docentes de la carrera TSE, en torno a la formación de la competencia ética. En esta etapa se identifican las necesidades, insuficiencias y potencialidades del TSE en relación al desarrollo de la competencia ética de este, a partir del cual se crean las condiciones para su desempeño en la práctica asistencial.

Objetivos específicos:

-Sensibilizar a docentes, directivos y estudiantes de la carrera TSE para el desarrollo de la formación de la competencia ética.

- Diagnosticar las necesidades, insuficiencias y potencialidades respecto a la competencia ética en docentes y estudiantes de la carrera TSE.

Son consideradas las siguientes acciones:

1. Valorar la preparación docente, estudiantes y directivos de la carrera TSE para el desarrollo de la formación de la competencia ética teniendo en cuenta:
2. Dominio de la importancia y el lugar de la competencia ética en la estrategia de salud pública en la carrera.
3. Potencialidades y barreras de los contextos de formación para el desarrollo de la competencia ética en el TSE.
4. Desarrollar talleres de sensibilización con docentes, estudiantes y directivos de la carrera TSE para su preparación en competencia ética:
5. Elaborar y aplicar instrumentos para la exploración de las insuficiencias, potencialidades y necesidades del TSE respecto al desarrollo de la formación de la competencia ética para lo cual se considerarán como indicadores:
6. Dominio del contenido ético que debe poseer el TSE en el proceso de asistencia médica en relación con las características del contexto en el que se inserta.
7. Dominio de los métodos para el desarrollo de una competencia ética en el TSE Habilidades asociadas a la competencia ética del TSE
8. Desarrollar un taller de socialización de los resultados del diagnóstico.
9. Capacitar al claustro docente para la implementación de la estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en los estudiantes Técnico Superior en Enfermería

Para el cumplimiento de estas acciones se sugiere técnicas participativas que sensibilicen y diagnostiquen situación en docentes, directivos y estudiantes de la carrera TSE, acerca de la importancia de su preparación para alcanzar el desarrollo de una competencia ética en la profesión. Se reconocerán las tesis de partida expuesta en la concepción presentada argumentando la esencia y relación de la bioética global o profunda, filosofía del Buen Vivir y la bioética médica en el proceso de formación de la competencia ética del TSE.

Se considerará el grado de desarrollo alcanzado y su concreción en el desempeño de la práctica preprofesional, además de tener en cuenta el conocimiento precedente que posee en relación con la temática, el cual se despliega a través del desarrollo de talleres que favorezcan la reflexión y el diálogo a partir de una adecuada interacción entre los participantes y el autodiagnóstico del estudiante TSE.

SEGUNDA ETAPA: CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN.

Se desarrolla a partir de considerar el proceso de apropiación, durante la formación del TSE, de los conocimientos y habilidades necesaria que contribuyan a la competencia ética del este como concreción de la concepción pedagógica elaborada.

Objetivo específico: Desarrollar acciones de carácter formativo teniendo en cuenta las vivencias de los procesos desarrollados por estudiantes TSE en su desempeño y que se manifiestan en su comportamiento ético.

En el desarrollo y concreción de esta etapa se reconoce la necesidad de acciones que contribuyan a la formación de la competencia ética en el TSE a partir de considera el contenido de la competencia ética aportada y los elementos que la identifican a partir de un enfoque intercultural integral y ecológico de la formación ética del TSE.

Se proyectan acciones que dan salida a las dimensiones curricular y extracurricular concebidas en el proceso de formación de la competencia ética, mediante situaciones planificadas que tienen como punto de partida los resultados del diagnóstico realizado a estudiantes de la carrera TSE.

Son consideradas las siguientes acciones:

Desde el nivel curricular.

- Instrumentar, desde la asignatura "Ética y bioética", el reconocimiento de la bioética como ética global y profunda, bioética médica, así como la filosofía del Buen Vivir a partir la solución de casos clínicos simulados, contextualizados.
- Implementar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas que potencien el uso de métodos productivos y técnicas participativas. vías, métodos y medios de formación de la competencia ética
- Promover en estudiantes, investigaciones científicas relacionadas con la competencia ética desde el contenido de los diferentes syllabus, a partir de considerar la bioética como ética global o profunda, la bioética médica y la filosofía del Buen Vivir, además de los inherentes a la profesión
- Elaborar situaciones de aprendizajes relacionadas con dilemas éticos, desde los syllabus, en el TSE como parte del contenido de la enseñanza que se integran en la competencia ética.
- Elaborar los planes de prácticas pre-profesionales de los estudiantes con actividades acerca de cómo poner a prueba la competencia ética del estudiante TSE en diferentes niveles de atención en salud.
- Realizar talleres de reflexión con estudiantes sobre la base de la aprehensión del sistema de valores de la sociedad ecuatoriana como reguladores de la conducta profesional:

Desde el nivel extra curricular.

- Revelar en las ferias académicas desarrolladas por la Institución, un desempeño ético.

 Desarrollar ferias itinerantes en diversos contextos sociales donde revele habilidades asociados a la competencia ética del TSE

 Elaborar trabajos investigativos representativo del programa social “para toda una vida” en la salud desde la institución educativa, las instituciones de salud o las comunidades.

 Elaborar y distribuir carteles, audio-visuales, entre otros, que revelen los elementos contenidos en el desarrollo de la competencia ética en el TSE.

 Participar en diversas campañas y movilizaciones, evidenciando un aprendizaje ético representativo de la diversidad cultural en salud en Ecuador.

3 Las ferias académicas son actividades extracurriculares, orientadas desde las asignaturas de la malla curricular en las que se integran contenidos de las diversas asignaturas que respondan a las directrices de la promoción de la salud, en las cuáles los estudiantes presentan a la comunidad educativa sus conocimientos sobre cómo lograr estilos de vida saludables, entornos favorables para la salud y el cuidado y autocuidado de la salud, las mismas se desarrollan en la institución escolar con la participación de la comunidad educativa, pueden invitarse a los familiares o amigos de los estudiantes (Notas tomadas de tesis doctoral, Grunauer, (2016)

TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN.

Esta transita por la valoración de los resultados que se alcanzan en instrumentación de la estrategia pedagógica y propicia valorar las transformaciones alcanzadas. En esta etapa se tendrá en cuenta los criterios evolutivos observados y recogidos en las etapas anteriores.

Objetivo: Evaluar los resultados de la estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

La evaluación tiene un carácter variado a través de técnicas con indicadores para medir factibilidad de la estrategia. Los indicadores que permitirán evaluar el impacto de esta estrategia, y que se van constando en cada momento de su instrumentación, están dirigidos a tres aspectos fundamentales:

Evaluación del proceso. Asume como indicador general: La correspondencia entre los resultados alcanzados en la aplicación de dichas acciones y los resultados probados para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

Evaluación de la pertinencia. Se evalúa el nivel de aprendizaje ético alcanzado por el TSE. Asume como indicador: Nivel de satisfacción del TSE en lo referido a desarrollo de la competencia ética.

Evaluación del impacto. Valora los beneficios que concibe el proceso de formación de la competencia ética del TSE. Asume como indicador: Nivel de satisfacción estudiante TSE.

En esta etapa se utiliza la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación

3.2 Valoración de la factibilidad de la estrategia pedagógica y la pertinencia de la concepción en que se sustenta

La valoración de la factibilidad de la estrategia pedagógica y la concepción en que se sustenta, se utilizó encuesta a especialistas, talleres de socialización y un estudio de caso.

Criterio de especialistas

El criterio de selección de los especialistas tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

1.-. Preparación académica, científica y experiencia docente.

2.-. Estabilidad en el trabajo de atención de los especialistas en los Centros asistenciales.

3.- Conocimiento de los contenidos de la formación pre profesional del Técnico Superior en Enfermería.

Fueron seleccionados 20 especialistas, entre 8 y 10 años de experiencia en Institutos de salud, docentes del cuarto nivel de la carrera directivos y tutores. Estos se caracterizan por poseer una vasta

experiencia en la práctica formativa y sus criterios permitieron remodelar o replantear aspectos de la estrategia pedagógica, para lograr confiabilidad de los datos obtenidos, se elaboró una guía previa. Se les aplicó una encuesta a especialistas (Anexo 5) con preguntas de interés referidos al aporte teórico y práctico de la investigación, así como las principales acciones formuladas en la estrategia pedagógica. Se planteó además algunos aspectos a tener en cuenta al emitir sus juicios valorativos de viabilidad y factibilidad como:

Conveniencia de los fundamentos teóricos de la investigación. Pertinencia y relevancia social de la concepción pedagógica.

Pertinencia de la estrategia pedagógica, posibilidades de aplicación y utilidad práctica. La encuesta aplicada a los especialistas se resume en las siguientes valoraciones:

El 100% de los especialistas consideran válidas la concepción y la estrategia propuestas, consideran que están contextualizados a la realidad educativa ecuatoriana y específicamente a la formación del TSE pues expresan el reconocimiento a las particularidades de la formación profesional y en ella la formación ética para revalorizar el ser, el hacer, el conocer y el convivir desde la perspectiva del aporte que cada docente hace a su contexto, generando así, el sentido de pertenencia a la solución de problemas pedagógicos concretos.

La concreción la concepción en la estrategia resulta apropiada, en tanto su implementación resulta orientadora para los docentes, al indicar en la escala de **5** (muy adecuada), el 100%, que la concepción es expresión de un proceso de estructuración inductivo y deductivo; al aportar el aparato conceptual necesario, a partir de reconocer tesis o postulados teóricos así como conceptos esenciales o básicos, llevado a la práctica a través de la instrumentación de una estrategia pedagógica que permite definir las insuficiencias y logros del TSE.

El 100% reconoce también la factibilidad de aplicación de la estrategia pedagógica al incorporar sus pensamientos, conocimientos y percepciones, al ofrecerles la oportunidad de trabajar hacia un proceso formativo de la competencia ética de forma permanente expresada en su actuación comprometida con su propia transformación y con la transmisión de conocimientos a su realidad, generando cambios cualitativos en el contexto educativo concreto.

Reconocen que la concepción y la estrategia pedagógicas son necesarias para que el estudiante pueda establecer relaciones interpersonales durante su praxis y se desarrolle como parte del equipo profesional de la salud con respeto en el proceso formativo ético y equilibrar la dicotomía teoría-práctica.

Los especialistas consultados asumen que en el proceso de instrumentación de la propuesta puede contribuir transformación del TSE en formación inicial y su actuación formativo ética, transformando con ello su desempeño hacia un modo de actuación ético profesional.

En relación al indicador de la unidad de competencia ética y elementos de competencia con respecto a si resuelve con independencia sensibilidad, humanismo y capacidad moral los dilemas éticos los 12 especialistas consultados (100%) coincidieron con lo oportuno de la propuesta.

Se reconoce como válida la búsqueda del proceso constructivo científico que se desarrolla en el modelo y la estrategia desde una fundamentación teórico- práctica que no va a culminar allí, sino que se extiende en la medida que se lleve a la práctica y se enriquezca, cuya vinculación con la realidad, lo hace significativo y válido.

Al realizar el indicador de la unidad de competencia ética y elementos de competencia, de si cumple los principios éticos para la intervención en la familia y la comunidad durante las acciones de promoción y prevención de salud, los especialistas escogieron en un 100%, adecuada.

Valoran como válido la propuesta de generar un espacio de reflexión teórica que se convierta en medio de transformación del profesional y con él su contexto educativo por la vía del reconocimiento de la diversidad en la individualidad de los docentes en formación inicial.

Con respecto a si resulta orientador para los docentes el enfoque de la concepción pedagógica propuesta, los especialistas escogieron por la opción de muy adecuada a esta pregunta.

Aprecian que se logra revelar vías para el proceso formativo ético en el sentido que se reconocen los saberes prácticos en torno a la realidad objetiva, la manera de asimilarla de forma sensible y la manera de conducirse el proceso pedagógico con lo cual se ganaría y generaría los momentos de ser, conocer, convivir y hacer, a partir de que la actuación profesional les permitiría saber, comprender, convivir y producir soluciones pedagógicas para apreciar el mundo.

Se les solicitó a los especialistas que expliquen las sugerencias esenciales para el proceso de perfeccionamiento de la concepción y la estrategia propuesta, al respecto recomendaron:

La posibilidad de un proceso de revisión del diseño curricular de la carrera de Técnico Superior en Enfermería, y de los contenidos de los syllabus de las asignaturas de enfermería, para adecuar la concepción y la estrategia propuestas al proceso de formación de la competencia ética a partir de lo cual se dará una transformación en el modo de actuación de los mismos, generando cambios cualitativos en su accionar.

La técnica de encuesta aplicada a especialistas, evidenció que tanto la concepción como la estrategia pedagógica, son contentivas de una novedad científica a partir de que revela una lógica integradora en la formación ética en el estudiante TSE, que contribuye a perfeccionar la práctica y se distingue por su factibilidad de aplicación y pertinencia a la carrera citada.

Taller de socialización.

El taller de socialización se realizó a partir de considerar los argumentos de factibilidad que podrían aportar y constituyen una modalidad de formación que se sustenta en los presupuestos de formación continua, en tanto se pueden determinar y desarrollar según las demandas investigativas de la propia Institución, resulta dinámico, de rápida aplicación y flexibles por su carácter contextualizado.

Esta modalidad, según criterio en la presente investigación, constituye base del cumplimiento de sus aspiraciones con la intención de obtener resultados en el menor plazo posible, a pesar de la complejidad que en orden psicopedagógico presenta la formación de la competencia ética.

Su objetivo fundamental se orientó a obtener científicamente las razones valorativas de sus miembros en la temática para determinar la pertinencia y factibilidad tanto de la concepción como de la estrategia pedagógica

De esta manera, se realizó un taller de socialización, con los seis miembros del proyecto institucional "Competencias profesionales en docentes del área de la salud de las IES" que se implementa desde el ITB de Guayaquil, con la precisión de que debían analizar y exponer sus criterios**,** sustentados en indicadores esenciales de la investigación cualitativa, que permitieran evaluar y enriquecer ambos aportes.

La decisión investigativa de realizar este taller de socialización se realiza a partir de considerar que los miembros del mismo, así como sus intereses están asociados al objetivo de: "Determinar las competencias profesionales del docente universitario del área de la salud de las IES, para favorecer su desempeño profesional"; permitirá dar argumentos de factibilidad, según las necesidades formativas de la propia Institución, por ser dinámico y de carácter contextualizado.

Los seis miembros del proyecto institucional son graduados universitarios como dos Licenciados en enfermería y 4 médicos con más de cinco años de trabajo en la institución, de ellos, 5 son doctores en

Ciencias Pedagógicas (83.3%) y 1 es Magíster en Salud Pública y en Educación Superior (16.6%); aspectos que revelan preparación en el tema y avalan la pertinencia de los resultados científicos.

Para el taller se les entregó un resumen de los resultados obtenidos en la investigación y se les indico que debían:

- Analizar los criterios respecto al contenido y la estructura de ambos aportes
- Evaluar la factibilidad de la estrategia.

Se asumen como indicadores los siguientes:

1. Pertinencia de los argumentos que describen la concepción pedagógica y rasgos fundamentales de este proceso:
2. La relación de la concepción pedagógica y la estrategia, así como la lógica de acciones propuestas en esta última.
3. Fortalezas y debilidades de la aplicación de la estrategia en la práctica Los resultados del taller fueron los siguientes:

El 100% de los participantes consideran válidas las categorías de la concepción y sus relaciones en el proceso de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

Resulta adecuada la concreción de la concepción pedagógica en la estrategia, a partir de que las categorías delimitadas y rasgos que la identifican, favorecen el desarrollo del proceso de formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería desde los intereses trazados, en tal sentido, señalan que el modelo es expresión de un proceso de estructuración inductivo y deductivo; aquí se erige no solo la base pedagógica, sino también el aparato conceptual necesario, que permite establecer subsistemas y componentes, llevado a la práctica a través de la instrumentación de una estrategia pedagógica que permite definir las insuficiencias y logros que se van alcanzando desde la labor orientadora del tutor.

Estudio de caso:

Se toma un caso único a partir de considerar su contribución al conocimiento y a la construcción teórica en la medida en que pondere un carácter crítico que permita confirmar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre los objetos de estudio, según apreciación de Robert K, Y. (2009).

Se reconoce su uso, a partir de que es posible confirmar y justificar la implementación de la estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en los estudiantes Técnico Superior en Enfermería, sustentada en una concepción pedagógico desde un enfoque intercultural integral y ecológico de la formación ética del TSE, para favorecer el desarrollo y perfeccionamiento de este, desde el contexto formativo y, para el ejercicio de la profesión.

Se seleccionó como caso, 5 estudiantes de 4to año de la carrera de TSE del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. En la selección se reconocieron las tesis de partida, la esencia de la competencia ética asumida y elementos que la sustentan, se tuvo en cuenta además los núcleos estructurados para la instrumentación de la estrategia. El total de seleccionados fueron los 5 estudiantes, 3 docentes y 1 directivo, los que suman un total de 8.

En la selección de los 8 que forman parte del caso único, se consideró que cumplan los requisitos establecidos para la implementación de la estrategia pedagógica, todos están vinculados al proceso formativo de TSE, y reconocen la necesidad de potenciar conocimientos, habilidades y valores que accedan a mantener un comportamiento ético en los diferentes contextos de actuación, lo cual se corroboró en instrumentos aplicados para llevar a cabo el diagnóstico inicial. Se corroboran así, las afirmaciones de transformación como resultado de la introducción del aporte práctico.

El estudio de caso se desarrolló durante los meses de junio –diciembre del 2018 y se organizó metodológicamente en tres fases, según Corda, M; Coria, M; Ayala, A y Stefanizzi, R (2017):

I. Fase preactiva

II. Fase interactiva

III. Fase postactiva

En la fase preactiva se lleva a cabo la sensibilización y diagnóstico de docentes, directivos y estudiantes, se presenta la estrategia pedagógica, se considera la situación del ITB para asumir la propuesta investigativa, a partir del nivel de preparación que poseen docentes, tutores y directivos.

En la fase interactiva, se precisan las acciones pedagógicas para incidir en la formación de la competencia ética del TSE.

En la fase postactiva, se valora la eficiencia y funcionamiento y uso de la estrategia para perfeccionar su implementación futura.

Fase preactiva:

Se realizó a partir de la sensibilización y diagnóstico a docentes, directivos y estudiantes seleccionados de la carrera de TSE para la formación de la competencia ética. Este proceso de sensibilización y diagnóstico se estructuraron sobre la base de talleres de reflexión que incidieron en su concientización. Los temas trabajados en esta fase de estudio y que sirvieron de base en la sensibilización de docentes, directivos y estudiantes fueron los siguientes:

Taller 1. La competencia ética, importancia y lugar en la asistencia médica de Ecuador. Peculiaridades de la formación ética en el Técnico Superior en Enfermería.

Objetivo: Analizar la importancia y las peculiaridades de la competencia ética en salud en la República de Ecuador y peculiaridades en el TSE.

Contenidos: Competencias en salud. Análisis y diagnóstico de situaciones que se presentan en la práctica del cuidado de salud en el proceso de asistencia médica. La filosofía del Buen Vivir su posicionamiento ético de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y ambiental en la sociedad ecuatoriana, influencia en la ética del técnico de salud. La competencia ética como competencia

específica en la formación del TSE.

Método: Exposición problémica y conversación heurística. Técnica participativa: Lluvia de ideas, PNI.

Medios: Audiovisuales, presentación digital, documentos normativos de la política de salud ecuatoriana.

Participantes: Docentes y directivo

Se inicia a partir de la exposición central de la investigadora apoyada en los referentes teóricos de la investigación y considerando aspectos esenciales de documentos normativos del sector salud en el contexto ecuatoriano.

La problemática presentada, fue a partir de considerar valores sociales en general y profesionales en particular; así como los razonamientos éticos realizados en torno a la competencia ética del TSE.

Evaluación: Se les solicito a los participantes sus valoraciones sobre los aprendizajes obtenidos en el taller.

Cierre: Se realiza las conclusiones del taller significando fortalezas y debilidades de la problemática investigativa en el contexto ecuatoriano.

Taller 2. Los dilemas éticos en técnicos de salud en el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano

Objetivo: Analizar dilemas éticos en técnicos de salud presentes en el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano.

Contenidos: El acto de cuidado de técnicos de salud en el marco de la prestación ética de los servicios de salud. Violaciones a los principios de igualdad y respeto por los derechos. Los dilemas éticos. Esencia y peculiaridades en técnicos de salud.

Método: Exposición problémica y elaboración conjunta.

Medios: Pancartas, trípticos y afiches.

Participantes: Docentes y estudiantes de la carrera TSE.

Se inicia el taller con la exposición de un docente de experiencias en el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano evaluando los dilemas éticos presentados en los técnicos de la salud, fundamentalmente los técnicos en enfermería en el contexto de la práctica, y se promueve el debate entre sus participantes a partir de los siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que se presentan en técnicos en enfermería en la asistencia médica?
- ¿Cómo el sistema nacional de salud da tratamiento a estos dilemas éticos?
- ¿Cómo el sistema nacional de salud utiliza diversos espacios para dar tratamiento al componente ético desde el contenido bioética global o profunda, filosofía del Buen Vivir y la bioética médica en el TSE?

Evaluación: Se recomienda solicitar a los participantes en el taller sus valoraciones sobre los aprendizajes alcanzados en el taller.

Cierre: Se realiza las conclusiones del taller significando fortalezas y debilidades de la problemática investigativa en el contexto ecuatoriano.

Sobre esta base se realizó un intercambio reflexivo entre el investigador, docentes, directivos y estudiantes. En estos talleres de sensibilización la bibliografía fundamental fueron los fundamentos teóricos de la presente investigación.

Entre las opiniones más significativas se pueden destacar los siguientes:

"…consideramos positivo que se nos aporten elementos relacionados con la competencia ética, la importancia y lugar en la asistencia médica de Ecuador*, pues no siempre contamos con toda la*

preparación para entenderlos, y esto limita nuestra actuación en la práctica, la que ha de caracterizarse por una gran eticidad cargada de humanismo" (estudiantes)

"…a veces no entendemos el valor de conocer como presupuesto en nuestras prácticas en salud, la filosofía del Buen Vivir como base del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) en la sociedad ecuatoriana*, por lo que es bueno acercarnos a estos documentos que nos explican cómo debemos proceder de acuerdo a las peculiaridades de nuestro país, así podemos conocer mejor lo que nos corresponden al respecto" (docentes).*

"…fue positivo conocer más sobre la necesaria competencia ética en el TSE, eso nos hace más humanos en nuestra labor formativa" (directivo).

"consideramos pertinente que se les brinde ayuda a los estudiantes TSE para que puedan conducir mejor el proceso formativo desde el contexto áulico" (docentes).

"es positivo, el conocimiento de lo que aporta la Bioética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la Bioética médica, al modelo del profesional TSE *para poder cumplir y hacer cumplir la política de salud en Ecuador, la cual tiene dentro de una de sus aristas el desarrollo de la competencia ética" (docentes y directivos)*

"*se agradece la preparación realizada y los ejemplos aportados en torno a los dilemas éticos a partir de lo cual se favorece nuestra preparación pedagógica" (docentes).*

"se agradece la posibilidad de la actualización recibida, así se enriquece la formación del TSE" (docentes, directivos y estudiantes).

La aplicación del PNI permitió constatar que hubo consenso en valorar como:

- Positivo: el reconocimiento a la importancia de la investigación orientada a la formación de la competencia ética en el TSE.

- Negativo: la posibilidad de que no se interprete adecuadamente y pongan barreras para su generalización en otros colectivos.
- Interesante: la comprensión de los fundamentos aportados acerca de la Bioética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir, la Bioética médica, contextualizada a los objetivos Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) y el modelo del profesional TSE como un proceso que debe constituir una práctica diaria en el profesional de la salud en los diversos contextos de actuación.

De manera general, se reconoció el valor de la estrategia propuesta, hubo una aceptación de las dificultades detectadas en el diagnóstico efectuado y se reveló la necesidad y pertinencia de los temas tratados en los talleres, los cuales contribuyeron a la sensibilización sobre la importancia del proceso que se estudia.

Taller 3: El proceso de formación de la competencia ética en el TSE. Caracterización. Objetivo:

Caracterizar el proceso de formación de la competencia ética en el TSE.

Contenidos: Los resultados de las técnicas utilizadas como parte del diagnóstico. Necesidades, fortalezas y debilidades respecto al proceso de formación de la competencia ética en el TSE.

Método: Exposición y Debate abierto

Medios: Presentación digital.

Participan. Docentes, estudiantes y directivos

En este taller el docente investigador expuso los principales resultados del diagnóstico el cual se desarrolló a través de los indicadores establecidos en la estrategia pedagógica propuesta y la utilización de técnicas de investigación. En este proceso se constataron los siguientes criterios:

Directivos.

"los estudiantes TSE al ingresar a nuestra institución muestran contradicción entre los intereses del modelo de formación a que se aspira - la preparación que reciben en la formación inicial - las necesidades de los diversos contextos donde deberán interactuar".

Docentes:

"las actividades de preparación de los docentes resultan insuficientes respecto al tratamiento al contenido que aportan la bioética global y profunda, la filosofía del Buen Vivir y la bioética médica a la formación de la competencia ética de estudiantes en respuesta a los problemas que se les presenta en la práctica asistencial".

Estudiantes.

"necesitamos más información y niveles de concreción de cómo alcanzar competencia ética para obtener mejores resultados en nuestras prácticas en instituciones y comunidades de salud".

"se nos hace muy difícil esta temática, en lo referido a su aplicación desde nuestro desempeño".

Estos criterios muestran que existen insuficiencias en:

La preparación para poder asumir prácticas médicas con calidad, donde primen análisis cuali-cuantitativas respecto a los procesos de salud enfermedad.

El predominio de actividades metodológicas donde se trabaje el desarrollo de la competencia ética en el TSE.

El conocimiento de las vías metodológicas necesarias para el desarrollo de la competencia ética en el estudiante TSE

Fase interactiva:

En esta fase se despliegan las acciones que dan salida a la formación de la competencia ética en el TSE desde las dimensiones curricular y extracurricular. Esta fase coincide con la segunda etapa de la estrategia pedagógica propuesta.

El objetivo coincide con el declarado en la segunda etapa de la estrategia – orientado desde el proceso formativo hacia la formación de la competencia ética en el TSE

Las acciones desarrolladas desde la *dimensión curricular* se orientaron por los docentes desde el contexto áulico en las diferentes asignaturas, reconociendo la transversalidad de la competencia ética y en todos los casos el profesor guía la actuación del estudiante.

Taller 1. Dilemas éticos en el TSE. Su solución

Objetivo: Elaborar situaciones desde su actuación en la práctica profesional que evidencia la presencia de dilemas éticos y dar respuesta acertada a los mismos.

Participan: docente y estudiantes.

Esta acción se realizó a partir de la presentación por el profesor de casos clínicos donde el estudiante deberá reflexionar sobre el mismo. El protagonista de la actividad fue el propio estudiante, el cual presentó dilemas éticos enfrentados no solo en las instituciones médicas, sino en los contextos donde interactuaron, dígase familias y comunidades.

En esta acción el docente orientó a los estudiantes diversos casos (Anexo 6) y aspectos generales a considerar partir de los siguientes indicadores:

El dilema ético.

Contexto donde se desarrolla. Posible solución.

En el desarrollo de esta acción a partir del taller se emitieron los siguientes criterios:

"debemos cuidar de realizar prácticas antiéticas, pues no están escritas en los códigos de ética del TSE, *y por consiguiente no se orientan* en beneficio de los pacientes para así contribuir a la humanización y calidad de vida en pacientes*".*

"la formación ética del TSE, favorece el desarrollo profesional".

"la acción desarrollada desde la práctica implica el desarrollo de competencias y permiten al TSE establecer relaciones terapéuticas sustentadas en la autonomía moral".

Entre las principales situaciones donde se presentaron dilemas éticos y el estudiante TSE demostró competencia ética al atender fueron:

-Al valorar el "Alzheimer"; enfermedad que implica el deterioro del proceso cognoscitivo, que interfiere de manera significativa en el desempeño cotidiano, restringiendo progresivamente la autonomía del individuo. Aquí, el estudiante TSE actuó de acuerdo a lo indicado por el médico tratante, que es decirle la verdad al paciente para aplicar temprano los medicamentos, enfatiza el derecho del paciente a ser informado. Por tanto, el estudiante puso en práctica el principio de beneficencia, pues se entiende que conocer el diagnóstico es el comienzo de un proceso largo de soporte y cuidado hacia el paciente, en conjunto con la familia. (El estudiante TSE se sujetó a la autoridad, hizo uso del principio de Beneficencia, además informó al paciente y familiares).

-Ante un paciente con "cáncer"; ante la aplicación de métodos invasivos como radio o quimioterapia, que requieren alto nivel de confianza entre el personal médico y el paciente. Los enfermos pueden presentar cambios en el estado de ánimo, como angustia, estrés, resentimiento, temor. En éstos pacientes el TSE aplicó los principios éticos, como el de beneficencia; dio apoyo emocional, comunicación clara y sintetizada; además apoyo a la familia, reflejando la aprehensión de la competencia ética en su desenvolvimiento

-Ante un paciente con "VIH", el estudiante TSE tiene diversas implicaciones éticas, especialmente por el sufrimiento y las consecuencias familiares que acarrea; además que genera conflictos de diversos tipos como económicos, lo derechos personales y colectivos al plantear el dilema entre libertad individual y salud pública, de valores y principios éticos por el respeto a la confidencialidad, entre otros. Lo cual, evidentemente, tiene connotaciones éticas, pues se tiende a tachar o discriminar a quienes lo

padecen con lo que se certifica el alcance de esta enfermedad. Existen algunos dilemas éticos a partir de: la perspectiva del grupo multidisciplinario de la salud, el enfoque social, el derecho a la paternidad y maternidad de los pacientes. La competencia ética indica la confidencialidad y secreto profesional. Asimismo, con menores infectados se debe contar con la presencia de los padres y plantear inicialmente tal situación a ellos, a fin de buscar la mejor manera de comunicar y explicar la situación al menor portador. Finalmente, lo ético respecto del VIH lo primero es manejara la prevención por gran cantidad de jóvenes que están expuestos, El estudiante pudo manejar la situación de manera ética con el paciente, familiares y enfocó la importancia de la protección.

Taller 2. Competencia ética en el TSE. Objetivo: Valorar la competencia ética del TSE. Participan: Docente y estudiantes.

Se utilizó como técnica la composición con el título "Competencia ética en mi desempeño profesional" (Anexo 7).

Se les orientó anticipadamente a los estudiantes, redactar una composición con el título definido y posteriormente se socializaron los resultados en un taller ampliamente debatidos, identificándose como regularidades en sus expresiones acerca de la competencia ética rasgos de: responsabilidad, ética profesional, personal; honestidad, honradez; compromiso social; respeto, humildad.

Al finalizar el taller se recogieron los siguientes criterios de los estudiantes participantes:

"nos sentimos muy satisfechos al poder identificar posiciones éticas que debemos asumir en nuestra profesión pues así podemos perfeccionar nuestra práctica".

"nuestro desarrollo profesional necesita poseer conocimientos, habilidades y actitudes que nos guíen hacia una integridad profesional y una conducta ética, lo cual *favorece que podamos alcanzar objetivos propuestos, tanto personal como social".*

“es pertinente para nuestra formación profesional durante practica preprofesional laboral que el tutor nos ayude a proyectar nuestro futuro profesional, a fin de cuentas, está más preparado y nos puede orientar”.

Entre las metas principales registradas se encuentran:

“*lograr enriquecer los* conocimientos de la profesión para perfeccionar modos de actuar y actitudes”

“lograr mayor dominio de la metodología y otros elementos en relación con la bioética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la biótica médica”.

“alcanzar profunda preparación para la función investigadora la cual da un sentido social y un desarrollo moral a su ejercicio profesional”

“la superación constante en temáticas asociadas a la competencia ética en el TSE”

“continuar implementando mi propuesta en Tesis de licenciatura”.

En esta etapa se atendieron además situaciones presentados por los estudiantes en su práctica acerca de dilemas éticos como la ausencia del estudiante en las unidades de los pacientes por estar participando en actividades de gestión de la institución, en la elaboración de registros y otros diferentes al cuidado; la presencia de los estudiantes TSE era solo para la realización de algunos procedimientos en el plano físico, muy raras veces para escuchar acerca de emociones, sentimientos y preocupaciones o dar instrucciones.

Uno de los estudiantes manifestó que el hecho de no considerar válidas y reales las manifestaciones de los pacientes puede conducir a que los problemas no sean resueltos de una manera apropiada, a alargar el padecimiento, el malestar y el sufrimiento de pacientes y los pone en la condición de no poder dar libre expresión a sus sentimientos y necesidades, situación que demandó la asesoría del docente

Se atendieron además situaciones relacionadas con el trato al estudiante TSE, énfasis en que el trato impersonal y frío no resulta útil para construir una relación profesional basada en el respeto y caracterizadas por la calidez, además de que no causa una buena impresión en los pacientes.

Taller 3. Socialización de experiencias pedagógico-profesionales de estudiantes asociadas a la competencia ética.

Objetivo: Socializar las experiencias de trabajos de desarrollo profesional asociado a la competencia ética.

Participan: estudiantes, directivos y docentes del ITB e investigadora.

Se realizó al culminar el 4to año en el cual los estudiantes presentaron trabajos de culminación de estudios (Anexo 8). En el taller se socializaron experiencias y se recogieron los siguientes criterios emitidos por los adiestrados:

"al iniciar la carrera tenía dudas de cómo podría ser en el ejercicio de la profesión pues me parecía no comprender bien las funciones como técnico de salud, sin embargo, la práctica realizada con la asesoría del docente y sustentada en lo que se quiere desde esta profesión, me ha permitido realizar información oportuna y de fácil comprensión para pacientes y familiares, traducir algunos términos técnicos en el contacto con los pacientes, ha sido desplazada por información incompleta e incomprensible que no contribuye *a mi formación y la constante búsqueda de soluciones de los problemas que se me presentan en la práctica".*

"la atención que he recibido en relación a mi desarrollo profesional toma en cuenta los dilemas éticos que están presentes en las interacciones de cuidado que en la actualidad establecen con los pacientes, y se ha reflexionado acerca de estos dilemas desde el trabajo en la práctica, lo que ha favorecido las necesidades y expectativas que tenía en relación a los contextos donde debo actuar y para el cual en principio no me sentía preparado".

“atender al TSE desde la utilidad de la competencia ética en su transversalidad, favorece la profesión”.

Desde lo extracurricular se desarrollaron 2 ferias académicas sobre:

La Historia Clínica documento médico legal, implicaciones éticas.

Realizar un trato digno, sin discriminación socio - económicos, etnias y cultural indicador de atención ético profesional.

Las opiniones de los participantes se resumen en:

Docentes:

“La participación y proyección de los estudiantes fue muy buena, mostraron respeto a los derechos del paciente y el cumplimiento de sus deberes con sus pacientes”

“El trabajo con la Historia Clínica reflejó, no solo una correcta práctica profesional del técnico, sino también el valor médico-legal que servirá al paciente y profesional en un momento determinado”

“La feria fue muy educativa y el estudiante TSE mostró en su exposición respeto, reconocimiento del valor intrínseco de la persona y se le vio plasmado en su presentación (esto como valores éticos)”

Directivo

“Fueron muy productivas ambas ferias académicas y motivaron a los estudiantes a niveles de profundización hacia estudios e investigaciones sobre patologías, así como la realización de publicaciones científicas junto con sus profesores”.

“El estudiante TSE conoció mediante estos ejercicios, que este documento es evaluación de la calidad asistencial ya que la historia clínica se considerada una de las normas deontológicas y norma legal como un derecho del paciente para una asistencia médica de calidad”.

“Se tuvo la percepción positiva de la relación paciente-TSE y que el paciente tuvo un trato digno por el personal técnico en enfermería que estuvo en la feria, el estudiante TSE siguió criterios importantes como la presentación del personal, la actitud hacia el paciente, así como la información que brindo

respecto al estado de salud.

Estudiantes

"Estas ferias para nosotros constituyen un elemento fundamental de control y gestión de los servicios sanitarios de las instituciones de salud, y nos hace perder temor en la práctica"

"Consolidó en nosotros conocimiento acerca de procedimientos y como la medicación a administrar ha de hacerse con nombre, hora y médico que lo prescribió. Se trata de un documento con derecho de acceso limitado, ello es parte de nuestra ética"

"Reconocemos la necesidad de darle valor a la presentación con el paciente, llamarlo por su nombre porque da un ambiente de respeto y desarrollo de comunicación entre el paciente y el enfermero (a)".

"Comprendimos que explicarnos sobre los cuidados o actividades a realizar con los pacientes, lo ayuda a colaborar con el tratamiento al momento de ejecutarse, mostrando interés para que la estancia del paciente sea agradable en un ambiente de confort, intimidad y seguridad una buena comunicación"

Fase posactiva

Esta fue estructurada para valorar los resultados de la aplicación del estudio de caso, a partir de la constatación la actuación de docentes y estudiantes.

Se realizó una triangulación para corroborar los criterios de utilidad de la propuesta científica. Se tuvo en cuenta la observación sistemática y la sistematización de los criterios planteados por los sujetos participantes en los talleres, el análisis de la composición y las ferias académicas.

A través de la metodología cualitativa utilizada se pudo constatar que la triangulación posibilitó, valorar la efectividad de la aplicación de la propuesta, utilizando indicadores como la eficacia, eficiencia, funcionalidad e impacto de las acciones realizadas durante el estudio de caso.

La eficacia de la estrategia se reveló al valorar los resultados en cuanto al cumplimiento del objetivo previsto por la misma, teniendo en cuenta los elementos de la competencia ética, lo que repercutió en la actuación del estudiante TSE. En este sentido se observó que se logró.

-Que el 100 % de los docentes lograran asumir el proceso de formación de la competencia ética y sus elementos desde la concepción que se propone en esta investigación.

-Que los 5 estudiantes del estudio de caso llegaron a asumir como parte de su práctica la validez de la competencia ética y necesidad de su contextualización, desde la perspectiva planteada para un 100%.

La eficacia estuvo referida a la obtención de mejores resultados en correspondencia con los propósitos y las acciones desarrolladas.

Los principales cambios demostraron la eficacia y se contemplaron, tanto en los estudiantes como en los docentes y el directivo.

En los estudiantes se manifiesta en:

Reflexión sobre los contenidos de los syllabus con las necesidades formativas desde la competencia ética.

Profundizaron en el conocimiento de sí mismo y de su identidad con la profesión Acertado comportamiento ético en sus relaciones con el grupo multidisciplinario de salud

Adecuado trato al paciente y familiares ante situaciones que se presentan por su estado de salud

Se proyectan adecuadamente la promoción de salud y prevención de enfermedades en el despliegue de acciones educativas con el respeto y la cordialidad

En el caso de los docentes y el directivo, el despliegue de la estrategia resultó una alternativa válida para la atención a estudiantes, repercusión revelada a partir de:

El diagnóstico del estudiante TSE para la formación de la competencia ética.

La modelación de dilemas éticos y so solución acertada.

Mayor conciencia respecto a fomentar la competencia ética del docente desde el currículo y en acciones desde lo extracurricular que debe existir en el proceso formativo del Técnico Superior en Enfermería.

Reorganización del proceso formativo, potencializando en los estudiantes los elementos de la competencia ética como estrategia para lograr el Buen Vivir en el individuo y la familia.

La importancia de la formación permanente en la consolidación de los elementos de la competencia ética

En cuanto a la eficiencia, se partió de considerarla como el empleo racional de los recursos didácticos y humanos en función de los objetivos para alcanzar los resultados previstos.

Se alcanzaron los objetivos propuestos a través de la instrumentación de la estrategia pedagógica, y el desarrollo de acciones con sentido profundamente humano, lo que favoreció el desarrollo de relaciones interactivas de respeto (ello refuerza la base moral) entre docentes, directivo y estudiantes, generando compromiso consigo mismo mediante convicciones personales y con la formación profesional.

Durante la fase interactiva del estudio de caso se evidenció, desde la perspectiva humanista, la adquisición de conocimientos, habilidades y experiencias fundamentales para la comprensión de las relaciones interpersonales en el cuidado de pacientes en diversos contextos.

La funcionalidad, reveló que las acciones emprendidas eran pertinentes en relación con el contexto, las relaciones interpersonales y las necesidades formativas de los estudiantes.

La estrategia permitió el establecimiento de un diagnóstico ajustado a la realidad ecuatoriana en respuestas a documentos como la bioética como ética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la bioética médica, las que favorecen la formación de la competencia ética en el TSE y el contexto.

La evaluación de la estrategia pedagógica como proceso comenzó desde su propia concepción y diagnóstico hasta la aplicación y valoración de sus resultados, dirigidos a lograr una transformación en el proceso de formación de la competencia ética del estudiante TSE.

El impacto se expresa en los logros a partir del efecto que producen los resultados de la utilización de la estrategia pedagógica. Se manifiesta en:

El proceso de formación de la competencia ética en estudiantes de la carrera de TSE se perfeccionó a partir de considerar las potencialidades de la bioética como ética global o profunda, la filosofía del Buen Vivir y la bioética médica en su formación, en relación con las condiciones del contexto.

Los estudiantes que participaron en la implementación de la propuesta se sintieron mejor preparados para actividad profesional.

Se favoreció la motivación del estudiante hacia la carrera a partir de la atención ofrecida por el docente

Se favorece en el 100% de los estudiantes TSE, el comportamiento moral y ético frente a la persona de quienes se hacen responsables en su labor diaria en los diversos contextos donde interactúan Todos los docentes de la muestra seleccionada, ampliaron su preparación técnica respecto a la competencia ética en estudiantes que participaron de esta propuesta investigativa.

La relación estudiante TSE-paciente-contextos, el interés hacia la profesión y la doble formación como estudiante y como técnico en la práctica desplegada se favoreció.

Para febrero del 2019 los 5 estudiantes al culminar el 4to año se graduaron y pudieron materializar algunas de sus trabajos de culminación de estudios las experiencias desarrolladas; actualmente se encuentran asignados en los centros asistenciales de la ciudad de Guayaquil con excelentes opiniones sobre su actuación.

Conclusiones del capítulo

La estrategia pedagógica propuesta concebida en etapas considera acciones encaminadas a formación ética del TSE a partir de la modelación de la competencia y la determinación de sus unidades permitiendo concretar en la práctica la propuesta teórica de la investigación, la misma se orienta a la preparación de docentes para guiar el proceso de formación de la competencia ética.

-Se reconoce por los especialistas las potencialidades de la propuesta como una vía para contribuir a la formación de la competencia ética del TSE durante el proceso formativo, además de la pertinencia de la concepción en que se sustenta.

La aplicación parcial de la estrategia pedagógica a través del estudio de caso reveló su valor pedagógico al alcanzar un nivel superior en la formación de la competencia ética en estudiantes de la carrera de TSE, mostrado en una mayor comprensión de su papel en el desarrollo de su práctica.

Se reconoce a partir de la aplicación parcial de la estrategia que tanto estudiantes como docentes descubren y auto-descubren necesidades cognitivas y deficiencias presentes en el proceso de formación del TSE.

CONCLUSIONES GENERALES

La formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería constituye una necesidad para el cumplimiento de los objetivos del sistema de salud ecuatoriano y un reto para las instituciones formadoras de este tipo de profesional de; el proceso formativo en este sentido presenta insuficiencias que hacen necesario su perfeccionamiento desde la investigación .La sistematización de los referentes teórico metodológicos sobre la formación de este profesional y específicamente sobre la formación de la competencia ética, el análisis histórico y del estado actual de la problemática permitieron constatar estas insuficiencias en el orden teórico y práctico, justificando el problema científico planteado y la pertinencia de los aportes de la investigación.

La concepción pedagógica, contribución a la teoría de la investigación partiendo de las exigencias del desempeño del TSE en el sistema de salud ecuatoriano se sustenta en los postulados de la bioética como ética global y profunda, la filosofía del Buen Vivir y la bioética médica; la articulación entre estas posiciones teóricas permite concebir el proceso de formación de la competencia ética desde un enfoque intercultural integral y ecológico de la formación y superar el reduccionismo médico en el proceso de formación articulando el pensamiento ético contemporáneo con las ideas que sustentan la estrategia de desarrollo de la salud pública en Ecuador

La concepción pedagógica de formación de la competencia ética del TSE se concreta en la práctica pedagógica en una estrategia cuya implementación tiene en cuenta las diversas dimensiones en que se desarrolla el proceso de formación y los contextos y agentes que participan en el proceso.

La instrumentación en la práctica de la estrategia en el ITB, permitió valorar científicamente la viabilidad, pertinencia y factibilidad de esta y la concepción en que se sustenta, ya que contribuyen significativamente a la formación de la competencia ética del TSE, elevando la calidad en su desempeño profesional.

RECOMENDACIONES

Valorar la generalización de la propuesta en otras carreras del perfil de salud que se desarrollan en los Institutos tecnológicos previa validación de los resultados de la investigación.

Continuar investigando la temática en lo que respecta a:

La argumentación de la formación ética como eje transversal en el proceso de formación del TSE y su materialización en el diseño curricular de la carrera.

La contribución de las prácticas pre profesionales a la formación ética del TSE y el papel de los miembros del equipo de salud en el proceso formativo de este profesional durante las mismas.

BIBLIOGRAFÍA

- Addine, F, F. y otros. (2003). Principios para la dirección del proceso pedagógico. En: Compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.
- _____ (1995). Exigencias en la formación del profesional pedagógico. La Habana: Pedagogía 95, Cuba.
- _____(2004). El principio de la integración del estudio con el trabajo: fundamento de la pedagogía cubana revolucionaria.
- Ahedo, J. (2014). El fundamento antropológico de la enseñanza ética de la participación ciudadana. Simposio internacional de Filosofía de la educación 29 y 30 de septiembre. Recuperado de https://books.google.com.ec/books?id
- Albacete, M. (2003). "El mundo de los valores: ética mínima y educación". 2da. Ed. Bogotá: El Búho.
- Alfonso, S, Troadio L. González, Carmen, Rosa María Báez (2000). La bioética y su relación con la tecnología médica. Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore
- Almaguer, B (2003). Temas de Bioética ambiental. Bogotá. Centro Editorial javeriano.
- Álvarez de Zayas, C. (1999). La escuela en la vida. Didáctica. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- Andreau, M. (2006). Los principios bioéticos en la toma de decisiones clínicas, Recuperado de http://www.bioetica.org/colab8.htm
- Angulo, M. (2012). Ética profesional y la Ingeniería Industrial. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Recuperado de http://bb9.ulacit.ac.cr/tesinas/Publicaciones/044272.pdf

- Altamirano B, L. (2016). Reseña histórica del proceso de formación profesional del Técnico Superior en Enfermería en relación a la competencia investigativa. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- Alzate Peralta, L. (2016). Concepción pedagógica socioeducativo del aprendizaje cooperativo asistencial en la carrera de Técnico Superior en Enfermería. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- Aniorte, N. (2011). Proceso salud y enfermedad, Recuperado de http://perso.wanadoo.es/aniorte.nic/apunt.salud
- Argüelles, A. (1996). Competencia Laboral y Educación basada en normas de competencia: Compilación. México. Editorial Limusa.
- Bárcena Orbe, F. (2000). El aprendizaje como acontecimiento ético. Sobre las formas del aprender Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Madrid. Ciudad Universitaria. 28040 Recuperado en https://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/viewFile
- Banda, B y Bautista, M. (2014). Evaluación e intervención de los conocimientos sobre las técnicas para la estimulación de succión no nutritiva y nutritiva en prematuros y recién nacidos con problemas de succión a alumnos y/o alumnas de quinto y séptimo semestre de estimulación temprana de la universidad de Cuenca. Tesis de Licenciada en Estimulación Temprana en Salud. Ecuador. Universidad de Cuenca.
- Baxter, E. (2002). La formación de valores. Una tarea educativa. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Beauchamp. T.L. y J.F. Childress (2001). Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford University Press,

- Blázquez, N (2005). Bioética fundamental. Madrid. España: Editorial Taurus
- Bombino, L (2004). El saber ético de ayer a hoy. La Habana. Cuba: Editorial Félix Varela.
- Bonilla Merizalde, J. (2010). Actitudes éticas del personal médico, participación de enfermería y la familia en la toma de decisiones humanizadas en pacientes con Limitación del Esfuerzo Terapéutico. Tesis doctoral en Ciencias Médicas. Universidad Libre Internacional de Las Américas. Quito
- Buxarrais, M. R. (1997). La formación del profesorado en educación en valores. Propuestas y materiales. Bilbao: Editorial Descleé De Brouwers S. A.
- _____(2004). La práctica de los valores en los contextos educativos. Educación superior y aprendizaje ético. Ponencia presentada al I Encuentro-Taller Internacional sobre Educación superior y gestión por valores, celebrado el. 23 y 24 de septiembre
- Blasco León, M. (2019). Ética y valores en enfermería. Revista enfermería del Instituto Mexicana del Seguro Social. Número 2. Recuperado de http://revistaenfermeria.imss.g
- Caicedo Quiroz, R. (2016). La formación del Técnico Superior en Enfermería para la prevención de enfermedades desde el vínculo con la comunidad. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- _____(2014). La medicina preventiva comunitaria incorporada al plan de estudios del TSE ecuatoriano. Revista MEDISAN Volumen 18 (12) Dic. ISSN 1029-3019.
- _____(2014a). La medicina preventiva comunitaria en el TSE en Ecuador. Revista IPLAC. Nov/Dic. RNPS N° 2140.
- _____(2015). Diagnóstico pedagógico para la atención primaria de salud en las prácticas comunitarias del TSE en Ecuador. Revista IPLAC. Ener/Feb. ISSN 1943-6850.

- _____ (2015a). El desarrollo de la medicina preventiva desde el vínculo con la comunidad. Apuntes para un modelo. Revista IPLAC. Ener/Feb. ISSN 1943-6850.
- _____(2016). Estrategia socio pedagógica para la formación del TSE en Ecuador. Revista MEDISAN Volumen 20 (5). (Sistema de Información Científica Redalyc. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal).
- _____(2016a). Un enfoque teórico-pedagógico de la cultura para la labor educativa. Vol. VII, (3) Julio-septiembre. Recuperado de Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación con ISSN 2224-2643.
- Calviño, M (2003). Análisis dinámico del comportamiento. Habana: Editorial Félix Varela.
- Camps, V. (2003). Capítulo III. Perspectivas éticas generales y Capítulo V. Ética para las ciencias y técnicas de la vida. En Ibarra, A. y Olivé (eds.). *Cuestiones éticas en ciencia y tecnología en el siglo XXI*. Págs. 2002.2015 Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, OEI.
- _____(1992). Educación moral. Cuadernos de Pedagogía, 20 de marzo. Volumen 2. No. 1
- Campillo Zaragoza, B. (2014). Disponible en Creación y validación de cuestionario de sensibilidad moral en los cuidados enfermeros. Estudio de la sensibilidad moral enfermera. Tesis doctoral. Universitat Internacional de Catalunga.
- Cano, B. y Martínez, A. (2014). Las habilidades para la vida como contenido de promoción de salud en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. La Habana.
- Cantavella, M. (2005). Bioética: Ciencia y humanismo. España: Clemente Editores.
- Cárdenas Cepero Y. (2006). Alternativa pedagógica para la educación bioética en el proceso de formación moral de los estudiantes de la carrera licenciatura en educación, en el área de ciencias naturales. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Soporte digital.

- Castellanos, E. (2004). Bioética: cultura solidaria. Disponible en http://culturasolidariawordpress.com/tag/
- Castillo, J (2000). Estrategia docente para un aprendizaje desarrollador". Disponible en http://www.monografía.com
- Cantos, M. (2010). Enfermería y bioética. Disponible en http://www.bioetica.org.ec/articulo
- Celeiro, A. (2012). La cultura ético-axiológica humanista del profesional de la educación desde la formación inicial. Tesis doctoral. Santiago de Cuba. Cuba.
- _____(2012a). Una intelección pedagógica del proceso de formación de la cultura ética. Órbita Científica. (67). *Vol. 18*. julio-agosto. ISSN: 1027-4472 RNPS: 1805.
- Cortón, B. (2008). Estrategia de intervención pedagógica para potenciar la función cultural de la escuela en la comunidad. Tesis doctoral. Santiago de Cuba. Cuba
- Chacón, N. (2005). Profesionalidad pedagógica, valores y cambio educativo. Retos y perspectivas. Curso prevento Evento Internacional Pedagogía.
- Código Deontológico para la profesión de enfermería Universidad de Navarra. Centro de documentación de Bioética (2008) Disponible en http://www.unav.es
- Cortés, P. A. (2009). Valores y competencias profesionales en la sociedad actual. IV Congreso de formación para el trabajo. Zaragoza
- Chacón, N. (2005). Ética y sociedad. Folleto de universidad para todos. La Habana. Cuba: Editorial
- Claursse, L. (2013). Análisis y reflexión sobre modelos teóricos del proceso salud enfermedad. Recuperado de http//www.scielo.br/pdf/csp/u8n.pdf
- Cifuentes, M. (2008). Educación por competencias: el concepto de competencia para la educación. Disponible en http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/870/1/T595-MGE-Cifuentes-Educaci%C3%B3n%20por%20competencias.pdf

- Constitución de la República del Ecuador (2008). Art. 32. Pág. 17:140. Disponible en http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/EC/constitucion.pdf
- Quiñones, RE, (2007). Ética, bioética y educación para el desarrollo sostenible. Disponible en http://www.files.sld.cu
- Corda, M; Coria, M; Ayala, A y Stefanizzi, R (2017) El método de caso como estrategia didáctica aplicada a la enseñanza de la gestión de la información en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Revista Brasileira de educacao em ciencia da informacao, 4 (2): 3-22
- Curshman, P. (2006). Educación en valores éticos, Disponible en http.//www.monografia.com7valoreseticos/htm
- Cussó, J. (2003). Interculturalidad. Disponible en http://www.ua-ambit.org/interculturalidad
- Dell, Ordine J. L. (2000). Aprender a aprender. Disponible en http://www.monografía.com/cgi-bin/recomendar.cgi
- Delors, J (2002). "La educación encierra un tesoro". Informe de la UNESCO de la comisión internacional sobre la Educación para el siglo XXI.
- Dlvago, N. (2006) Valores en la enseñanza. Disponible en de http.//wwwnncondelvago.com/valores2html
- Didriksson, A. (2003). La universidad de la innovación. Una estrategia de transformación para la construcción de universidades del futuro. Argentina: Editorial Paidós, Buenos Aires
- Domínguez, G. (1995). Introducción a la Bioética. Santiago de Chile. Chile: Editorial universitaria.
- Donosita,C. (2005). Foro de Educación en valores. Disponible en http://wwwdonostia.org/forovalores/files/method
- Domínguez A, C, Kohlen, H. y Tronto, J. (2018). El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado y práctica enfermera. Barcelona: Ediciones San Juan de Dios.

- Ecuador, Quito. Ley Orgánica de Salud de la República Del Ecuador (2006). Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423
- _____ (2008). SEMPLADES. Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir (2009-2013). Segunda edición. Pp. 189/520. ISBN: 978-9978-92-794-6.
- _____ (2010). Presidencia de la República. Ley Orgánica de Educación Superior Lexis S.A. N° 298
- _____ (2011) Ley de ejercicio profesional de las enfermeras y enfermeros de Ecuador. Disponible en https://vdocuments.site_
- _____ (2012). Código de Ética del Técnico Superior en Enfermería. Disponible en http://www.itb.edu.ec/tecnico_superior_en_enfermeria
- _____ (2012). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Macrodiseño de la Carrera TSE del ITB Disponible en : http://www.itb.edu.ec/enfermeria
- _____ (2012). Pensum de estudio de la carrera Técnico Superior en Enfermería (2009). Disponible en http://www.itb.edu.ec/tecnico_superior_en_enfermeria
- _____ (2012) Enfermería. Instituto Tecnológico Superior Stanford. Disponible en http://stanford.edu.ec/index.php/home
- _____ (2013) Enfermería. Instituto Superior Tecnológico Libertad. Disponible en http://web.itslibertad.edu.ec/enfermeria
- _____ (2013). Nuevo Modelo de Atención Primaria Integral de Salud y Vida (APISV) con Enfoque integrativo e Intercultural.
- Espinosa, D. (2003). Una dimensión de la Ética en Salud Pública. Brasil: Facultad de Salud Pública, Sao Paulo.
- Estévez Fundora, H (s/f). La formación de valores en el proceso formativo y su incidencia en las Ciencias Sociales. Cuba: Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca".

- Fabara Garzón, E y otros (2013). Estado del arte de la formación docente en Ecuador. Cuadernos del contrato social por la educación. Quito. Ecuador.
- Fabelo Corzo, R. (2004). Los valores y los desafíos actuales. La Habana: Editorial José Martí.
- _____ (2004). Los valores y la familia. Disponible en http://www.filosofía.cu/contemp/fabelo001.htm
- Fabelo Corzo, J R. (2004). Mercado y valores humanos. Por una nueva ética. La Habana: Editorial Félix Varela, p-352.
- Fernández, A M y otros (2002). Comunicación educativa. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Fernández Biggs, B. (2010). La ética como competencia laboral. Dirección de Formación General. Instituto Profesional DuocUC.
- Fernández Burillo, S. (2006). Introducción a la fundamentación Bioética. Disponible en http://www.aceb.org/index.html
- Ferry, G. (1991). El trayecto de la formación, los enseñantes entre la teoría y la práctica. Disponible en https://www.researchgate.net
- _____. (1997). Pedagogía de la formación. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Ferrera F, Acebal, E y Paganini, JM. (1975). Medicina de la comunidad. Intermédica. (s.l.) Editorial Argentina.
- Fire, Angel: (2014) "Comunicación intercultural". Disponible en http://www.angelfire.com/emo/
- Forgas Brioso, J. A. (2003). Modelo curricular para la formación del técnico de nivel medio basado en competencias profesionales. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba.
- _____ (2003). Modelo para la formación profesional. En la educación técnica y profesional, sobre la base de competencias profesionales, en la rama mecánica. Pág. 26:295.

- _____(2003a). La Formación por competencias del técnico de nivel medio en mecánica de taller en Cuba: Una alternativa del diseño curricular. La Habana: Pedagogía.
- _____ (2001). Algunas consideraciones sobre la formación profesional basada en competencias en Cuba: Seminario Internacional de Formación Profesional Basada en Competencias. Quito. Disponible en: http// www.campus-oei.org/eduytrabajo
- Fuentes González, H. (2009). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente.
- _____. (2007). Proceso de investigación Científica orientada a las Ciencias Sociales, Universidad Estatal de Bolívar-Ecuador.
- Fuentes González, H. Estrabao, A., Macia, T. (2003). La universidad y su gestión. Una mirada dialéctica holística. Santiago de Cuba: CeeS Manuel. F. Gran.
- _____(2002). Las competencias como configuración didáctica en la formación de los profesionales (soporte digital).
- Fuentes González, H (1997). Conferencia didáctica del postgrado: Universidad de Oriente, Centro de Estudios de Educación Superior. "Manuel F Gran", Santiago de Cuba, Cuba.
- Florez Ochoa, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá: Editorial Mac Graw-Hill.
- Gacel, J (2004). Modalidades y tendencias de la cooperación internacional. Revista Española de Desarrollo y Cooperación. (5)
- Giddens, A. (2005). Sociología. Alianza Editorial, Madrid.
- Galbán Mendoza, Y. (2019). Integración de los contenidos del marxismo leninismo en la formación inicial en las carreras pedagógicas. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba
- García, V. (2005). Principios bioéticos. Su incidencia en el plano de lo subjetivo. Disponible en

http://www.bioética.org/bioética/monog.shtm

- García, E. (2010)- Competencias éticas del profesor y calidad de la educación. 13 (4), 29–41. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Disponible en https://eprints.ucm.es/
- Garzón F B. (2000). Bioética, manual interactivo, Bogotá, Colombia: Editorial. Bogotá
- González, F. (1996). Un análisis psicológico de los valores: su lugar e importancia en el mundo subjetivo. En la formación de valores en las nuevas generaciones. (pp:57-88). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- González, V. (2005). La educación de competencias profesionales en la Universidad. Su comprensión desde una perspectiva socio-histórica del desarrollo humano. Ponencia presentada al V Taller de Pedagogía de la Educación Superior. Evento Base del Congreso Internacional de Universidades. Universidad 2006. La Habana.
- _____. (2004). ¿Qué significa ser un profesional competente? Reflexiones desde una perspectiva psicológica. [en línea] Revista Iberoamericana de Educación. Madrid. Disponible en http://www.oei.es
- González Rey, F. y otros. (1989) La personalidad, su educación y desarrollo. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- González U. (2002). Ubicación de la Ética, la Bioética y la Ética Médica en el campo del conocimiento. Recuperado de: http/www.infomed.cu Revista Cubana de Salud Pública. Diciembre; Vol.5. (12).
- González A M (2002) El proceso de enseñanza aprendizaje ¿agente de cambio educativo? En: González AN y Reinoso C. (2010) Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía. (pp 28-42). La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- González Cárdenas D, y otros (2007). Principios bioéticos y atención primaria de salud de personas que viven con el VIH-SIDA. Rev. Habana Ciencias Médicas 2007; 6(3). Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php

- González G. (2004). La globalización cultural: América Latina ante una reconstrucción axiológica alternativa. En López Bombino LR, (Comp.). Por una nueva ética. (pp. 45-67). La Habana: Editorial "Félix Varela"; 2004. p.367.
- González Gerez M. (2007) La formación de valores en la escuela cubana. En: Bombino LR. Compilador. Por una nueva ética. (pp. 12-29). Ciudad de La Habana: Editorial "Félix Varela".
- González Pérez U. (2002) Ubicación de la ética, la bioética y la ética médica en el campo del conocimiento. Rev. Cubana de Salud Pública 2002;28(3). Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php
- Gonczi, A. (2001). Análisis de las tendencias internacionales y de los avances en educación y capacitación laboral basadas en normas de competencias. En Argüelles, A y Gonczi, A. Educación y capacitación basada en normas de competencias: una perspectiva internacional. (pp.63-82). México.
- Gracia Ortiz, H M. (2019). ¿Cuál es el código de ética de enfermería? UNITEC/BLOG. Disponible en http://bñogs.unitec.mx
- Guadarrama González, P. (1990). Lo universal y lo específico en la cultura. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, Cuba.
- Gurruchaga, M., y otros (2011). Aplicación de la competencia ética en grupos de ingeniería y negocios. Revista de ética profesional ISSN 1940-2155 Volumen 2, (1)
- Guillen, R. (2001). La ética y la moral en enfermería. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos21/etica-enfermeria,shtml/
- Gracia, D. (2001). La revolución ética. UNESCO universitas, Madrid.
- Grífols, V. (2012) Ética y salud pública. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Nr. 27 Disponible en https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10
- Grunauer Robalino, G. R. (2016) La formación para la promoción de la salud del técnico superior en enfermería. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Cuba

- Hager, P. y Beckett D. (1999). Bases filosóficas del concepto integrado de Competencia. CONALEP.
- Herder, H (2004). La Bioética en las universidades de hoy. Madrid. España: Editorial Paidós.
- Herrera Herrera, E. (2009). La Educación Moral Disponible en http://www.monografias.com/trabajos21/educacion-moral,shtml
- _____ (2004). La construcción de la identidad juvenil en la post – modernidad. Disponible en http://www.dominicasorg/cidad/españa/revista/identidadhtm
- Horruitiner Silva, P. (2007). El proceso de formación: sus características. Capítulo II. En: Universidad Cubana: El Modelo De Formación. (pp. 54-82). Revista Pedagógica Universitaria.
- Houtart, F. (2011). El concepto de Sumak Kausay (Buen vivir) y su correspondencia con el bien común de la humanidad. Revista Ecuador debate 84. Quito Ecuador Biblioteca Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias Sociales REGIÓN ANDINA Y AMÉRICA LATINA Disponible en http://hdl.handle.net/10469/3523
- Ibáñez, J. (2006). La educación transformadora: concepto, fines, método. Disponible en http://educación.com/forovalores
- Idoate, V. (2003). Aspectos bioéticos en la determinación genómica y sus aplicaciones. Disponible en http://www.bu.edu/wcp/papersbioeidoauninavarra.htm
- Josefiphine K, Bratz, Sandoval-Ramírez (2017). Competencias éticas para el desarrollo del cuidado en enfermería. Revista Brasileira Enferm 71(Suppl 4): 1810-4 Disponible en http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167
- Kérouac, S. (1996). El pensamiento Enfermero. Barcelona, España: Masson, S. A.
- Laucirica, F (2004). Un nuevo enfoque de valores bioéticos. Milwaukee Marquette University Press.

- Larroca, F. (2011). Aprendizaje de lo ético y moral en los humanos. Disponible en http://www.mailxmail.com/
- Lema Cachinell, B M. (2016) Formación investigativa del docente de los institutos superiores tecnológicos. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- León Cáceres, F. M. (2015). Las TIC como recurso de aprendizaje: una visión pedagógica y didáctica en el Técnico Superior de Enfermería. Revista IPLAC. ISSN 1993-6850, Disponible en www.revista.iplac.rimed.cu
- _____. (2015a). Los entornos virtuales como recursos de aprendizaje en la formación inicial del Técnico Superior de Enfermería. Revista IPLAC ISSN 1993-6850. Recuperado de: www.revista.iplac.rimed.cu.
- _____. (2015b). Las Tic: Mirada desde el contexto educativo ecuatoriano. Revista IPLAC. ISSN 1993-8850. Recuperado de: www.revista.iplac.rimed.cu
- _____ (2015c). La utilización de las TIC en el ITB, en la carrera Técnico Superior de enfermería en Guayaquil –Ecuador. Revista Pedagógica Maestro y Sociedad. ISSN 1815-4867.
- León-Sanz, M. P. (2006). La competencia ética, parte de la competencia profesional. Revista de Medicina de la Universidad de Navarra, Revista Medicina-Humanidades Biomédicas Volumen.46, (5-6). Disponible en http://hdl.handle.net/10171/36114
- León García, M. (2005). Los problemas profesionales generales de enfermería en el diseño curricular. Revista Cubana Enfermería v.21 (1). Ciudad de la Habana 2005, versión On-line ISSN 1561-2961,
- _____. (2003). Modelo teórico para la integración escuela politécnica-mundo laboral en la formación de profesionales de nivel medio. Tesis doctoral. I.S.P "Enrique José Varona", La Habana.
- Limia, M. (2004). Vida con sentido o sentido de la vida. Disponible en http://www.filosofía.cu/contemp/index.htm

- López Bombino, LR, (2005), El saber ético de ayer a hoy. La Habana. Cuba Editorial Félix Varela.
- López, J. y otros (2000). Fundamentos de la educación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Loreto García, M. (2015). La ética del cuidado y su aplicación en la profesión enfermera Acta Bioethica. VOL.21 (2). Santiago NOV. Disponible en http://dx.dol.org/10.4067/s1726
- Malherbe, D (1996). Fundamentos de la cultura bioética. Populi. FNUAP, Volumen 16 No. 2.
- Mancini, U. (2004). El hablar de multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad: conceptos y estrategias. Disponible en http//www.crim.unam.mx/cultura/cultd
- Mariscal San Martín, L. C. (2015). Competencia ética: una necesidad en la formación del TSE. Revista IPLAC Enero/Febrero. (2140). ISBN 1993-6850 RNPS N°
- _____(2015a). Evolución histórico-lógica en la formación de la competencia ética en el TSE, en Ecuador. Revista IPLAC (2140). Marzo/Abril. ISBN 1993-6850 RNPS.
- _____ (2015b). El cuidado directo de salud y la ética como expresión de competencias profesionales específicas en el Técnico Superior en Enfermería en Ecuador (TSE). Revista Santiago. Junio/2015 ISSN 2227-6513
- _____(2016). Formación de la competencia ética en técnicos de la salud. Revista MEDISAN 2016; 20(7):994
- Martínez Pérez, M. (1991). La identidad como objeto de estudio. En L.I. Méndez, comp; Primer seminario sobre identidad, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México.
- Martínez, M. y Payà, M. (2007). La formación de la ciudadanía en el Espacio Europeo de Educación Superior. En José Luis García Garrido (Ed.). Formar ciudadanos euro- peos, pp. 19-
  93. Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes. Disponible en file:///C:/Users/docente3/Downloads/552-3078-1-PB.pdf
- Martínez Martin, M (2008) Aprendizaje ético en contextos virtuales en el EEES. Revista "Teoría de la

Educación: educación y cultura en la sociedad de la información", 9 (1), 24-40. Ediciones Universidad de Salamanca, España

- Martínez Martín, M y otros. (2003). La universidad como espacio de aprendizaje ético. Número 3. Octubre - noviembre de 2003. Disponible en https://www.oei.es/historico/valores
- Martínez, L. R. (2014). La promoción de la salud en docentes de formación inicial. Tesis doctoral Universidad de Ciencias Pedagógicas. Pepito Tey. Las Tunas. Cuba.
- Markarian, C. (1970). Teoría de la cultura en: Problema del mundo contemporáneo. (110). Moscú.
- Martin Arteaga, A. (2012). Formación de la identidad universitaria bolivariana de Venezuela.
- Miranda, A y Contreras. (2014). El cuidado enfermero como problema ético: concepto y principios prácticos apolicados al acto de cuidado. Revista brasileira de enfermagen. Nov-dic; 67 (6): 873- Santiago. Chile
- Morales Basadre, R (2001) Hacia una ética global y una ética pública. Organización de Estados Iberoamericanos. Disponible en http://www.Oei.Es/Valores2/Morales.Htm
- Musick DW. (1999) Teaching Medical Ethics A Review of the Literature from North American Medical Schools with Emphasis on Education. Med Health Care Philos. 2(3):239-54
- Nandy, R (2005) Future studies: Methods, Emerging segues and civilizational visions. Brisbane: Prosperity Press.
- Núñez-Cubero, E (1998) La actividad del aprendizaje. Buenos Aires. Argentina: Editorial Nueva visión.
- Outomuro, Delia (2008) Fundamentación de la enseñanza de la bioética en medicina. Acta Bioethica. Volumen14 (1) Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php
- Ocampo, M. J. (2005). Consideraciones bioéticas sobre la investigación médica en seres humanos Tesis doctoral. México: Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Paccini, S (2006) La clonación, un reto para la responsabilidad de los hombres". Revista

Latinoamericana de Bioética. (2). Nueva Granada.

- Paz, I. (2009). Fundamentos de la formación profesional pedagógica en Cuba. Material base. Encuentro de Educadores Cuba – México (APC- AELAC). México: Curso Pre evento
- _____. y otros. (2010). Carpeta Metodológica. Santiago de Cuba. Universidad de Ciencias pedagógicas.
- _____. (2011) Los proyectos de desarrollo profesional. Fundamentos psicopedagógicos y recomendaciones. Seminario científico. Santiago de Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas.
- Porra Casals, J M, y otros (2001) Conocimientos y aplicación de los principios éticos y bioéticos en el proceso de atención de enfermería. Revista Cubana Enfermería Volumen 17 (2) La Habana Cuba.
- Potdevin, P. (2014). ¿Es posible una Ética Global? Disponible en http://www.utp.edu.co/~girivera/documentos/
- Placencio Macas, M S (2014). Un reto para la formación del personal de salud desde la perspectiva de la relación ciencia –sociedad. Revista IPLAC Nov/ Dic. ISSN 1993-6850.
- _____. (2015) Diagnóstico pedagógico para la atención primaria en salud en las prácticas comunitarias del TSE en Ecuador. Revista IPLAC Enero/Febrero. ISSN 1993-6850
- _____(2016). Las prácticas comunitarias en la formación del Técnico Superior en Enfermería: un enfoque desde la atención primaria de salud. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- Ranuzi, C, Vierira y Contim (2017) La ética en la formación del enfermero, según graduandos de enfermería de una institución pública brasileña. Bioética no Mundo da Saúde. Sao Paulo. 41 (1): 116-121
- Regalado E. (2012). ¿Formación del Docente? Disponible en http://www.eldiario.ec/noticias- Manabí-ecuador/

- Reich, W (1998). Encyclopedics of Bioethics. Prentice Hall. Disponible en https://panel.inkiba.com
- Renzo, G (2005). El problema medicamento. Revista del Instituto Juan César García, Ecuador. Revista sistematización CIE "Graciela Bustillos". Asociación de Pedagogos de Cuba.
- Robert K, Y (2009) Investigación sobre estudio de casos. Diseño y Métodos
- Rodríguez Ayala, L (2016) La didáctica de la ofimática en la formación del Técnico Superior en Enfermería en el contexto ecuatoriano. Tesis doctoral. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- Rodríguez Medrano V. H. (2015). La enfermería en cuidados críticos. Una competencia específica a formar en el Técnico Superior en Enfermería. Revista Santiago. Latindex, Cubaciencia, Academic Search (EBSCO) y Clase. ISSN: 2227-6513.
- Rojas, R. (2004). Estrategia educativa para la formación integral de los prestadores en servicio social. Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Romero, R (1999) Fundamentos de Bioética aplicada. Eudema, Mid.
- Sánchez, A (2004). Transculturalidad, proyecto latinoamericanista. Disponible en http://www.colombiavirtual.com/gestaculta/trans.htm
- Sariego, Acosta JR (2002). Bioética para la sustentabilidad. La Habana. Cuba Publicaciones Acuario. Centro Félix Varela.
- Salas Zapata, W (2013). Formación por competencias en educación superior. Una aproximación conceptual a propósito del caso colombiano. Universidad de Antioquia, Colombia Revista Iberoamericana de Educación ISSN: 1681 5653 Disponible en http://www.oei.es/pdfs/formacionmaestrosamericalatina
- Salleras L (1994) La medicina clínica preventiva: el futuro de la prevención. Disponible en *lbe.uab.es/vm/sp/old/docs/salud-publica/medicina-preventiva*

- Segura, R (2010). Una experiencia didáctica sobre la enseñanza de la bioética en programas de educación superior. Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de ciencias de la educación. Maestría en educación.
- Sierra Salcedo, R A (2008). La estrategia pedagógica, su diseño e implementación. La Habana Pueblo y Educación. Cuba.
- Scarduelli, K (1997) Las bases biológicas del conocimiento humano. España. Editorial Debate, Madrid.
- Schramm, Fermín. (2004). Principios bioéticos en salud pública: limitaciones y propuestas. Disponible en http://bibliotecauniversia.net/htm
- Schon, D (1992). La formación de profesionales reflexivos. Buenos Aires. Argentina. Editorial Paidós.
- Suardíaz, J (2003). La Bioética en los cuidados intensivos. Revista cubana de Bioética. Centro de Referencia de Bioética Juan Pablo II, nov-dic, La Habana. Cuba.
- Suárez Rodríguez, C (1998). La orientación educativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
- Tey Teijón, A, Vilà Baños, Martín (2014) Competencias para el aprendizaje ético en estudiantes universitarios de enfermería y pedagogía Revista de Docencia Universitaria. Vol. 12,
- Tey Teijón, Amèlia y Joana Cifre-Mas (2011) El profesorado ante el reto del aprendizaje ético y el desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas. El modelo adoptado en el programa Barcelona. Aula de Ciudadanía. Revista de Educación, número extraordinario. Disponible en http://www.revistaeducacion.educacion.es/
- Torralba, P: (2004). Educere Universidad de los Andes. Disponible en http//redalycsaemec/ mx/redalyc//
- Torres Sáez, H y Padrón Álvarez, A (2014). Elementos esenciales de una concepción pedagógica para la formación de valores en ingenieros y arquitectos. Revista Referencia Pedagógica. No. 2. ISSN 2308-3042 Disponible en http://revistascientificas.cujae.edu.cu/

- Tunermann, C (1995). Una nueva visión de la Educación superior. CSUCA, San José. Viciedo, L (2003) "Diez palabras claves en Bioética. Madrid. España Editorial Verbo divino.
- Vaillant Despaigne J C (2019**).** La formación profesional de estudiantes de otras nacionalidades en el contexto multicultural de las universidades cubanas. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente
- Vicenc F (1998). Una comunidad con una ética global. (Capítulo X del libro "Cultura de paz y gestión de conflictos", Icaria/UNESCO, Barcelona, España.
- Viteri Díaz, G. (2009). Situación de la salud en Ecuador. Disponible en www.monografia.com
- Vivianos, A (2000). Sociedad Internacional de Bioética. Aspectos bioéticos para el nuevo siglo. Disponible en http://www.sibi.org/pub/asp.htm
- Vidal, S (2013). Bioética y desarrollo humano: una visión desde América Latina Revista ACTIO. (15):
- Zarzar, C (1995). ¿Cómo incorporar los valores en el currículum? En Didáctica (23). Universidad iberoamericana. Centro de Didáctica. México. Primavera.
- Zeledón Ruíz, M (2005). El aprendizaje ético en la construcción de la ciudadanía democrática. Conferencia de fondo en el Congreso Internacional de Investigación Educativa: "Investigar para transformar" Instituto de Investigación en Educación-Universidad de Costa Rica, febrero. Disponible en https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/9174

Anexo 1

Entrevista a estudiantes

Objetivo: Explorar Conocer las opiniones de los estudiantes relacionado con las acciones educativas que reciben acerca del desempeño ético profesional.

Estimado estudiante:

Se está realizando una investigación para perfeccionar el desarrollo de la competencia ética en el TSE. Su opinión resulta de gran valor, por lo que le solicitamos que nos brinde sus consideraciones acerca de la temática que se aborda.

Año que cursa_____ Edad_____ Sexo. F____M_____

PREGUNTAS

1.- ¿Qué definición usted le atribuye a la profesión de enfermería en las actividades que realizan en el proceso de formación como enfermeros? ¿Cuáles los orientan sobre las manifestaciones de relación que debe establecer con el paciente?

2.- ¿Existe alguna asignatura en especial que explique los principios metodológicos del comportamiento ético en las manifestaciones de su desempeño profesional? Fundamente.

3.- ¿Cuáles son a su juicio las actividades del proceso de su formación como Técnico Superior en Enfermería, que usted está recibiendo que le aporte mayor información sobre los valores que debe poseer para el desempeño?

4.- ¿Cuáles son los valores que a su juicio deben poseer los profesionales de la especialidad del Técnico Superior en Enfermería?

5.- ¿Qué importancia usted les atribuye a los valores éticos en el desempeño del profesional del Técnico Superior en Enfermería?

Anexo 2

Entrevista a docentes y directivos

Objetivo: Constatar el nivel de preparación de docentes y directivos acerca del tratamiento a la ética en el Técnico Superior en Enfermería.

Estimado profesor

Se está realizando una investigación para perfeccionar el desarrollo de la competencia ética en el TSE. Su opinión resulta de gran valor por lo que le solicitamos que nos brinde sus consideraciones acerca de la temática que se aborda.

Marque usted según corresponda: Docente

a. Médico _____Enfermero_MSc. _____Dr. C. ___Años de experiencia _____

Directivo (cargo)_____

a. Médico_____Enfermero____MSc. ___Dr. C. ___Años de experiencia _____

1.- Recibió usted en su formación profesional aspectos relacionados con la formación en valores y Ética médica.

2.- ¿Qué métodos utiliza en las clases y/o actividades educativas que potencien el proceso de formación de valores éticos en estudiantes de la carrera TSE?

3.- ¿Que valores éticos considera necesarios para fortalecer la ética profesional de los TSE? Emita sugerencias.

4.- De sus valoraciones acerca de la concepción de los syllabus respecto a la formación de valores éticos profesionales.

5.- ¿Cómo considera Usted que actualmente se desarrollan las cualidades éticas del estudiante?

Anexo 3

Análisis documental

Documentos a revisar

1. PENSUM
2. Malla curricular
3. Syllabus

Objetivo: Conocer cómo está concebida y proyectada la formación ética en el TSE. Indicadores:

1. Concreción de la formación de la competencia ética en el TSE.
2. Insuficiencias y potencialidades de la competencia ética en documentos para el desempeño del TSE.
3. Proyección de la carrera respecto al desarrollo de una competencia ética en el TSE.

Anexo 4

Observación científica

Objetivo: Identificar en la práctica pedagógica las insuficiencias y potencialidades de la formación para el desarrollo de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería.

Tipo de actividad:

Participantes:

Aspectos a observar:

1. Tratamiento de autoridades y docentes a la formación de una competencia ética en el TSE desde la labor educativa.
2. Tratamiento a la formación de la competencia ética en el TSE, desde:
    a. Los objetivos.
    b. El contenido.
    c. Vinculo de la teoría con la práctica.
    d. Preparación de los docentes.
    e. Participación de los estudiantes en actividades orientadas

Anexo 5

Encuesta a especialistas

Objetivo: Valorar la factibilidad de la estrategia pedagógica para la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería y la concepción que la sustenta.

Estimado colega:

Desarrollamos una investigación pedagógica, relacionada con la formación de la competencia ética en el Técnico Superior en Enfermería. Se han propuesto una estrategia pedagógica y su sustento teórico en una concepción de la misma naturaleza. Por la labor que realiza, sería valioso conocer sus criterios al respecto.

Por ello se solicita su colaboración con este instrumento. Le agradecemos anticipadamente.

1. Sobre la pertinencia de la estrategia pedagógica propuesta contentivas de la concepción pedagógica que explicita la unidad de competencia ética. Marque con una X en la respuesta escogida en una escala de 1 a 5 en orden ascendente de calidad.

Tenga en cuenta que la escala valorativa es:

5 muy adecuada **4** bastante adecuada **3** adecuada **2** poco adecuada **1** no adecuada

1_____ 2_____ 3____ 4_____ 5 ____

a) Argumente.

2. ¿Resulta orientador para los docentes el enfoque de la concepción pedagógica propuesta?

Marque con una X en la respuesta escogida en una escala de 1 a 5 en orden ascendente de calidad.

1_____ 2_____ 3____ 4_____ 5_____

Argumente.

3. Explique las sugerencias esenciales para el proceso de perfeccionamiento de la concepción y la estrategia propuesta.

Anexo 6

Taller de socialización Nro. 1

Título: Dilemas éticos en el TSE. Su solución

Objetivo: Elaborar situaciones desde su actuación en la práctica profesional que evidencia la presencia de dilemas éticos y dar respuesta acertada a los mismos.

Contenidos:

- Conocimiento de la deontología
- Ponderación del perfil profesional del Técnico Superior en enfermería.

Precisiones metodológicas.

Se establece en el taller modos de actuación de los docentes en su desempeño, se analizan y valoran ejemplos concretos desde la práctica del TSE. Deberá considerarse.

Nivel por donde transita el estudiante Actividad –intencionalidad-pasos a seguir Se valoran propuestas pedagógicas como:

Caso propuesto No. 1

Ana es analfabeta, padece de sífilis, acude al hospital para recibir un tratamiento para su padecimiento; sin embargo, al no contar con las camas suficientes, decide derivarla a un centro de atención primaria con una vía venosa instalada. Ana, ya en el centro le indican que el tratamiento consiste en inyecciones de penicilina cada 6 horas, dando la opción de que asista al consultorio dos veces, en el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, de modo que pueda aplicarse dos veces el tratamiento; sin embargo, ya para aquellas no cubiertas en el horario, la propia señora, debía ser quien se suministre el tratamiento.

Para cumplir el objetivo, el Técnico Superior en Enfermería (por orden del médico y enfermero tratante) le enseña a Ana la forma de suministrarse. En éste caso:

- ¿Actuó éticamente al enseñarle a una señora analfabeta a aplicar por vía venosa su tratamiento?
- ¿Cómo hubiese actuado Usted?
- ¿Ante la orden del superior de enseñarle al paciente, cómo hubiese reaccionado?
- En la siguiente tabla establezca en conjunto con su clase por lo menos tres argumentos tanto a favor como en contra de proceder de la enfermera.

Argumentos a favor	**Argumento en contra**

Caso propuesto No. 2

Proyección del video Código de Bioética para enfermería

Actividades propuestas. -

En grupos de 10 personas discutan las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la Ética?
b. ¿Qué es la Bioética?
c. ¿Por qué es importante la Bioética?
d. ¿Por qué es importante aplicar un Código de Bioética a la práctica profesional de enfermería?
e. Haga referencia a cinco principios básicos de aplicación de Ética en la enfermería y dé ejemplos de cómo se ejecutarían en la práctica profesional.

Las respuestas serán presentadas en el siguiente esquema en un paleógrafo, de modo que puedan ser expuestas por un miembro del grupo y se pueda abrir un foro general.

Ética	
Bioética	
Importancia de la Bioética	
Código de ética	
Importancia	

Caso propuesto No. 3

Un paciente enfermo de SIDA, no desea comunicar la situación a su pareja y pretende continuar una vida normal, haciendo caso omiso a su diagnóstico. Usted conoce del tema, así como a la familia del paciente. ¿Sería ético guardar secreto profesional basado en la autonomía del paciente que no quiere informar de su estado a la persona con quien mantiene relaciones sexuales, aun cuando su autonomía afecte a los demás a ejercer su propia autonomía, al no poder consentir la relación con conocimiento del riesgo que conllevaría? ¿Diría Usted el diagnóstico o persuadiría al paciente para ser él mismo quien informe? ¿Qué medidas cree necesarias asumir en este caso?

En el caso del estudiante, al finalizar el taller se le aplicara el siguiente instrumento:

Escoja el número que más se adapte a su respuesta de acuerdo a la siguiente valoración					
1.- Muy malo 2.- Malo 3.- Regular 4.- Bueno 5.- Muy bueno					
¿Cómo valora la actuación del moderador?	1	2	3	4	5
¿Cómo valora la relevancia de la información presentada?	1	2	3	4	5
¿Cómo valora el diseño y estructura?	1	2	3	4	5
¿Cómo valora los casos prácticos propuestos?	1	2	3	4	5

¿La actitud del moderador incentivó el debate argumentativo?	1	2	3	4	
Recomendaciones y/o sugerencias:					

Caso propuesto No. 4

Proyección del documental Eutanasia

Actividades propuestas. -

En grupos de 8 personas elijan uno de los casos propuestos en el documental y discutan el esquema propuesto a continuación, el cual será presentado en un papelógrafo para abrir el debate grupal.

Argumentos a favor	Argumentos en contra	Argumentos del grupo
• •	• •	• •

Caso propuesto No. 5

Trato digno, ¿indicador de calidad?

En grupos de 10 personas discutan las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la Dignidad?
b. ¿Qué es el trato digno
c. ¿Por qué es importante el trato digno en enfermería?
d. Haga referencia a tres principios básicos del Decálogo Ético
e. Haga referencia a tres casos de pacientes vulnerables e indique cómo actuaria frente a tal situación
f. Las respuestas serán presentadas en un paleógrafo, de modo que puedan ser expuestas por un miembro del grupo y se pueda abrir un foro general.

Anexo 7

Taller de socialización Nro. 2

Taller 2. Competencia ética en el TSE.

Título: “Competencia ética en mi desempeño profesional”.

Objetivo de la técnica: Valorar el desarrollo alcanzado por el TSE respecto de la competencia ética en función de su crecimiento personal y su implicación social.

Estudiante TSE.

Requerimos que escribas una composición con el título “Competencia ética en mi desempeño profesional”, donde expreses como serias en tu desarrollo profesional en relación con la competencia ética que debes alcanzar en la práctica.

No es necesario que escribas tu nombre, pero sí que seas lo más sincero posible.

Anexo 8

Taller de socialización Nro. 3

Taller 3. Socialización de experiencias pedagógico-profesionales de estudiantes asociadas a la competencia ética.

Objetivo: Socializar las experiencias de trabajos de desarrollo profesional asociado a la competencia ética.

Estudiante TSE.

Solicitamos de usted sus opiniones de cómo se concretó en el trabajo investigativo de cierre de carrera el desarrollo alcanzado en su competencia ética, donde expreses tratamiento abordado desde los syllabus.